

terapia familiar

**ESTRUCTURA, PATOLOGIA
Y TERAPEUTICA
DEL GRUPO FAMILIAR**

4

GISELA AHLIN - GRACIELA B. DE LUXARDO

La relación de alianza: una formación de compromiso

SUSANA BARILARI - STELLA M. MOLINA IVONNE ROZENBERG

Articulación del enfoque familiar en el proceso
terapéutico de un paciente discapacitado

SUSANA M. DE GIUDICE

Estudio de la composición familiar de las internas
condenadas en la Penitenciaría provincial de Mendoza

OSCAR CZERTOK

Sobre mitos y terapias familiares. Ejercicio clínico
alrededor de un mito yurok

PHILIPPE CAILLE

Psicopatología de la familia

JAQUES RUDRAUF

Ensayo sobre la dialéctica de los niveles de
comunicación en la intervención terapéutica

MARA SELVINI PALAZZOLI

Terapia de la familia a transacción esquizofrénica

MAURICIO ANDOLFI - PAOLO MENGHI

ANA MARIA NICOLÒ - CARMINE SACCU

La interacción en los sistemas rígidos: un modelo
de intervención en la familia con paciente esquizofrénico

VIII Congreso de Psicología y Psicoterapia de Grupo

Simposio de Terapia Familiar

IVAN BOSZORMENYI-NAGY - A. CANEVARO

Diálogos

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año II - N° 4 - Diciembre de 1979

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires-San Antonio-Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heldelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina-St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Block (New York)

Ives Colas (Lyon)

C. Sluzki (Buenos Aires-S. Francisco-California)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Relaciones Públicas

Dra. L. de Stunz

Secretaria Administrativa

Graciela Rodríguez

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Editorial ACE S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs.As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 1382769

Compuesto e impreso en los Talleres Gráficos Offset-grama s.r.l. - Independencia 3117, Capital Federal, en Diciembre de 1979.

Tarifa reducida 3053 - Franqueo pagado 339
Número del Registro Internacional
de Publicaciones Científicas ISSN 025-5905

terapia familiar

Estructura, Patología y Terapéutica
del grupo familiar

Año II - Nº 4 - Diciembre de 1979

Director

Dr. Alfredo A. Canevaro

Comité de Redacción

Lic. Stella Maris Molina

Dr. Rafael Skiadaressis

Consejo de Redacción

Jorge García Badaracco (Buenos Aires)

Isidoro Berenstein (Buenos Aires)

Juan C. Nocetti (Buenos Aires)

Ivan Boszormenyi-Nagy (Filadelfia)

Gerald Zuk (Filadelfia)

Alberto Serrano (Buenos Aires-San Antonio-Texas)

Jacques Rudrauf (París)

Helm Stierlin (Heldelberg)

Maurizio Andolfi (Roma)

Richard Sauber (Massachusetts)

Robin Skynner (Londres)

Mara Selvini Palazzoli (Milán)

Raymundo Macías (México)

Guillermo Vidal (Buenos Aires)

Reynaldo Perrone (Rosario, Argentina-St. Etienne, Francia)

David Rubinstein (Filadelfia)

Donald Block (New York)

Ives Colas (Lyon)

C. Sluzki (Buenos Aires-S. Francisco-California)

Director Administrativo

Alberto Cattán

Relaciones Públicas

Dra. L. de Stunz

Secretaria Administrativa

Graciela Rodríguez

Asesor Editorial

Alfredo Carlino

TERAPIA FAMILIAR es una publicación semestral de Editorial ACES S.R.L. (ef), Gorostiaga 1731, Bs.As., Argentina. Acogida a la protección de las Convenciones Internacional y Panamericana sobre derechos de autor. Nombre de la Revista registrado como marca. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual 1382769

Compuesto e impreso en los Talleres Gráficos Offset-grama s.r.l. - Independencia 3117, Capital Federal, en Diciembre de 1979.

Tarifa reducida 3053 - Franqueo pagado 339
Número del Registro Internacional
de Publicaciones Científicas ISSN 025-5905

Indice

GISELA AHLIN - GRACIELA B. DE LUXARDO La relación de alianza: una formación de compromiso.....	7
SUSANA BARILARI - STELLA M. MOLINA IVONNE ROZENBERG Articulación del enfoque familiar en el proceso terapéutico de un paciente discapacitado.....	19
SUSANA M. DE GIUDICE Estudio de la composición familiar de las internas condenadas en la Penitenciaría provincial de Mendoza.....	29
OSCAR CZERTOK Sobre mitos y terapias familiares. Ejercicio clínico alrededor de un mito yurok.....	56

PHILIPPE CAILLE Psicopatología de la familia.....	73
JAQUES RUDRAUF Ensayo sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica.....	87
MARA SELVINI PALAZZOLI Terapia de la familia a transacción esquizofrénica.....	99
MAURICIO ANDOLFI - PAOLO MENGHI ANA MARIA NICOLÒ - CARMINE SACCU La interacción en los sistemas rígidos: un modelo de intervención en la familia con paciente esquizofrénico....	108
VIII Congreso de Psicología y Psicoterapia de Grupo Simposio de Terapia Familiar	143
IVAN BOSZORMENYI-NAGY - A. CANEVARO Diálogos.....	187
LIBROS	199
CONGRESOS	209
Información sobre la Sociedad Argentina de Terapia Familiar	217
Información General	220

La relación de alianza: una formación de compromiso

GISELA AHLIN
GRACIELA BOTTICELLA DE LUXARDO

Licenciadas en Psicología. Miembros Adherentes de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Coordinadoras del equipo de "Pareja y Familia" del Depto. de Orientación y Prevención de A. P. B. A.

El propósito de este trabajo es mostrar la articulación interna entre las relaciones de objeto narcisistas y el predominio de la "familia materna" en determinados grupos familiares. El marco referencial teórico reúne los aportes de la Antropología Estructural y el Psicoanálisis. Desde la primera se señala que el elemento de parentesco está constituido por la unión de dos familias a través de la relación entre la pareja conyugal, el hijo y un representante de la familia de donde proviene la mujer. Estructura que aunque borrada o confundida con otras de complejidad mayor reaparece cuando un sistema familiar presenta un aspecto crítico. Desde el Psicoanálisis se analiza la elección de objeto exogámico signada por las vicisitudes del complejo de Edipo, elección que puede ser hecha de acuerdo al modelo de apuntalamiento o al modelo narcisista.

Se presenta un material clínico de una pareja unida por un vínculo narcisista, que consulta diciendo que "no pueden estar ni juntos ni separados" y que se llevan mal porque "él es débil y

Gisela Ahlin - Graciela B. de Luxardo

ella fuerte". La historia de esta pareja muestra que desde su constitución han intentado separarse de la familia de Carmen, la mujer, pero han vuelto a una relación estrecha y conflictiva con la misma cada vez que determinados hechos, tales como el nacimiento de los hijos, ponía en evidencia la existencia de la relación de alianza.

El análisis del material indica que el movimiento de acercamiento-alejamiento de la familia materna, junto con los ejes que articulan los términos fuerte-débil, valorizado-desvalorizado, constituyen el universo semántico que pauta la relación fuertemente narcisista de esta pareja, supuestamente basada sobre una estructura similar madre-hijo, en la que el padre de cada cónyuge quedaba significado como ausente.

Mediante el uso del modelo de la estructura elemental de la significación, se muestran las operaciones inconscientes por las cuales esta pareja trataba de compensar la pérdida de parientes consanguíneos, implicada en la relación de alianza, evitando el pase a una "posición diferente": exogamia, alejamiento de la familia materna.

Se postula que la relación de alianza es una relación de compromiso entre los dictados de la ley del tabú del incesto, y los que responden a la ley del cumplimiento del deseo, compromiso que reúne las contradicciones de los cónyuges y las de la familia que cede a la mujer. Tanto más es así, cuanto, relaciones narcisistas mediante, el padre no cumple su función que permite el pasaje de la naturaleza a la cultura, de la endogamia a la exogamia.

La relación de alianza: una formación de compromiso.

Es frecuente observar en los grupos familiares que consultan, que cuando atraviesan determinadas crisis que cuestionan el equilibrio existente, se pone de manifiesto el predominio de sus relaciones con la familia materna. Denominamos como tal a aquella de donde proviene la mujer al establecerse la alianza matrimonial. El propósito de este trabajo es mostrar la articulación interna existente entre este fenómeno y las relaciones de objeto narcisistas.

Presentación de un material clínico.

Carmen y Reinaldo constituyen una pareja de edad madura. Tienen dos hijos: Luisa, de 21 años, casada tres meses antes de la consulta y José María, de 19, que se casaría pocos meses después. Consultaron por desavenencias frecuentes y malestar en diversas áreas de sus relaciones. Decían: "No podemos estar ni juntos ni separados". Según Reinaldo se llevaban mal porque "él" era débil y ella fuerte".

Tres meses antes del matrimonio murió el hermano mayor de Reinaldo, quién, según él, cumplió ciertas funciones de padre. "Comenzamos con pérdidas", comentaron respecto a este suceso.

El decía que su "padre no fue tan padre" y lo describió alejado de él. Recordaba un vínculo más intenso con su madre, centrado particularmente en las preocupaciones que ésta tenía sobre su salud, pues "era tan raquítico que temía que muriese". Creía que se lo tomó en cuenta por ser débil y admitió haber buscado una madre en la de Carmen para cubrir las carencias en relación con la propia.

La infancia de Carmen estuvo signada por los cuidados y las restricciones impuestas debido a una afección congénita, aún cuando por otra parte se quejaba de que su madre nunca dió cabida a sus demandas de amor. Por el contrario creía que siempre había sido "la madre de su madre". Deseaba estar más ligada al padre con quién sintió haber tenido poco contacto.

Al casarse alquilaron un pequeño departamento.

Cuando nació la hija, Reinaldo, que trabajaba en forma independiente, fue empleado por el suegro debido a "las mayores responsabilidades que para él implicaba ser padre". Poco después compraron un departamento y, mientras vivían allí nació el segundo hijo.

Para ese entonces, Reinaldo tenía participación en otro negocio y debido a una estafa del director que les hacía temer un posible embargo de sus bienes, realizaron una venta ficticia del departamento a nombre del hermano de Carmen y alquilaron otro más grande.

En el discurso de la pareja diversos temas se reiteraban como

motivo de conflicto. Uno de ellos gravitaba en torno a los reproches referidos al modo en que cada uno sentía que era atado y dominado por el otro, y por la desvalorización que, recíprocamente se infligían por sus demandas de cuidado.

Reinaldo acusaba a Carmen de ser poco afectiva y de tener que cuidarla y estar permanentemente a su disposición, aún cuando dijo que se casó con ella sabiendo que era una enferma. Carmen, a su vez, se quejaba de las exigencias de él, de tener que estar en la casa a la hora que él volvía, puesto que no toleraba estar solo. Tampoco aceptaba que otra persona que no fuera ella le preparase sus comidas debido a que padecía una afección gástrica.

Respecto a los hijos, pensaban que se habían casado jóvenes para alejarse de ellos, hartos de ser testigos de sus peleas. Les resultaba muy difícil tolerar su ausencia. Cuando dibujaron el plano de la casa denominaron con el nombre de sus hijos las habitaciones que éstos ocuparon hasta el momento de irse.

Otro terreno de agudas discrepancias era la relación con la familia de Carmen. Ella pensaba que su hermano, socio de Reinaldo, perjudicaba sus relaciones de pareja. La relación con la madre de Carmen también daba lugar a discusiones. Cada uno pensaba que el otro la introducía invasoramente en sus vidas. La describían como desvalida en determinados aspectos y Reinaldo tenía que hacerse cargo de resolverle muchos problemas. Ellos no podían saber quién necesitaba a quién.

Además comenzaban a plantearse la sucesión del padre. Carmen proponía vender el edificio que ahora le pertenecía en condominio con su madre y hermanos, a lo que Reinaldo se oponía porque allí funcionaba su negocio.

También les preocupaba tener que abandonar el departamento que alquilaban y comprar uno nuevo.

Su lugar de residencia había sido siempre fijado próximo a los familiares de Carmen. Esta vez ella deseaba vivir en un barrio diferente.

Durante el tratamiento las interpretaciones eran casi sistemáticamente rechazadas. Las categorizaban inconscientemente como juicios de valor. Tendían a "autointerpretarse" y formular sus propias explicaciones sobre lo que les ocurría.

Consideraciones teóricas respecto a la relación de alianza.

Partiremos de una doble consideración proveniente de dos campos teóricos.

a) de la Antropología Estructural y b) del Psicoanálisis.

a) Lévi-Strauss ha señalado que toda relación matrimonial está fundada sobre un sistema de intercambio y que a su vez es la condición para que se realice la reciprocidad.

A raíz de la existencia universal del tabú del incesto, un hombre obtiene una mujer únicamente de manos de otro hombre, el cual la cede bajo forma de hija o de hermana y el primero, recíprocamente, está obligado a su vez, a ceder a su hermana a otro hombre.

No hace al objetivo de este trabajo transcribir en forma minuciosa la teoría por él expuesta sobre la estructura elemental del parentesco. Para el desarrollo de nuestras ideas lo que nos interesa destacar es que el elemento del parentesco no está constituido por la familia biológica sino por la unión de dos familias, a través de la relación existente entre la pareja conyugal, el hijo y un representante de la familia de donde proviene la mujer (familia materna).

En nuestra sociedad esta estructura puede borrarse o confundirse con otras de una complejidad aún mayor. Pero precisamente, dice L. Strauss, porque pertenece a la estructura elemental, reaparece con nitidez y tiende a exasperarse cada vez que el sistema considerado presenta un aspecto crítico.

b) Desde el punto de vista psicoanalítico la elección de una pareja matrimonial está signada por las vicisitudes del Complejo de Edipo. Se encuentra a alguien a través de cuya relación se espera completar de alguna manera la solución siempre inacabada dada a las primeras relaciones de objeto.

El comienzo de esta relación no es fortuito, ni la pareja tiene un comienzo cero, aunque sus integrantes así lo piensen.

La elección de objeto está sistémicamente regulada y determinada por el interjuego de dos factores que a la vez que permiten, restringen la elección.

El primero de ellos está referido al sistema de parentesco, con la ley, por excelencia, de la prohibición del incesto, que lleva a la búsqueda de un objeto exogámico, reemplazando un sistema de relaciones consanguíneas por un sistema de alianza.

El segundo es el plano determinado por la significación inconsciente que cada familia otorga al modo del cumplimiento y a la transgresión de la ley del tabú del incesto, la que se genera en el seno de la estructura edípica. Este último nivel supone un código de significaciones inconsciente, propio de cada grupo familiar, internalizado por cada uno de los futuros integrantes de la pareja, el que a su vez formará una nueva trama con el código aportado por el otro que va a integrar la relación de alianza, organizando así un universo común de significaciones compartidas que va a reglar y dar sentido a dicha relación.

Esto hace a los aspectos comunes de la misma, que coexisten con lo que cada uno tiene de diferente, variables ambas intervinientes en distinto grado en la elección mutua.

De todos modos no es lo mismo pensar en la clase a la que pertenecen ciertas parejas, en la cual las diferencias funcionan como la posibilidad de lo común, que en la clase de parejas donde lo común no da lugar a la inclusión de lo diferente. Estas últimas nos remiten a las elecciones de objeto narcisistas.

Freud señaló los dos modelos de elección objetal exogámica: 1) conforme al tipo de aposición (sobre el modelo de la mujer nutriz o del hombre protector) y 2) conforme al modelo narcisista (eligiendo lo que el sujeto es, lo que fue, lo que quisiera ser, o alguien que fue una parte del mismo).

Una relación narcisista involucra especialmente, dos aspectos ligados entre sí: a) la negación de la diferencia entre el yo y el objeto y b) que, mediante este tipo de elección se intenta recuperar la identificación del yo ideal perdido y evitar así, caer en el contrario temido que sería el negativo del yo ideal. Coincidimos con Berenstein en que la pareja matrimonial es un sistema de intercambio que posee una estructura inconsciente. Esta estructura, modelo teórico que construimos a partir de los datos que la pareja aporta, involucra el universo de sus significaciones inconscientes y su determinación histórica, en la que se incluye la modalidad específica de conexión con la familia materna.

Análisis del material clínico y conclusiones.

Pensamos que el universo semántico de esta pareja gira predominantemente en torno a los ejes que articulan los términos: fuerte-débil, valorizado-desvalorizado y acercamiento-alejamiento con respecto a la familia materna.

Ellos comparten una situación infantil semejante en cuanto a que ambos tenían un vínculo intenso con las madres. Se los consideraba como meros objetos a cuidar en un plano corporal concreto, pero dejándose de lado sus demandas de amor y de reconocimiento como sujetos deseantes. Para ambos el padre quedó significado como una figura distante.

Esta constelación objetual fue tanto motivo de su unión como de sus desaveniencias. La manera a través de la cual intentaban regular su autoestima era mediante la identificación con un yo ideal cuya función semántica era la de otorgar cuidados y la ubicación en el otro del negativo complementario del mismo: ser débil-desamparado.

"El no poder estar ni juntos ni separados" también da cuenta del carácter narcisista de esta relación.

No pueden estar juntos porque la elección que hicieron basada en esas semejanzas los ubica a ambos en la misma situación de deseo (se sienten conducidos a desear lo mismo que, como a su vez es faltante en el otro, ninguno puede cubrir; decepcionándose al no cumplirse las mutuas demandas).

Estar separados no es tolerado porque necesitan al otro para completarse en un plano imaginario.

Suponemos que esta relación guarda un isomorfismo estructural con una díada madre-hijo de carácter narcisista. Vínculo intersubjetivo que articula la legalidad del deseo materno con la demanda de amor del hijo.

El hijo en esta relación se ofrece a ser lo que la madre quiere que él sea a cambio de su amor.

A su vez la madre le ofrece su amor incondicional a condición de que él sea el objeto que la complete narcisísticamente. Esto estructura el primer doble mensaje de la vida: el de la incondicionalidad condicionada.

Carmen quedó capturada en el deseo materno de encontrar una madre en su hija. Por los datos que tenemos, suponemos que Reinaldo también quedó preso en una relación narcisista con su madre, legalidad que en ambos el padre no pudo romper totalmente para cumplir con su función, que es la de instaurar una ley (la ley de la cultura) que está más allá de la madre y de él mismo y cuyo paradigma es el tabú del incesto.

El inicio de esta pareja estuvo marcada por estas significaciones, las que determinaron su modalidad de conexión con la familia materna.

Reinaldo eligió una mujer que en tanto débil le hizo posible alojar en ella su propia debilidad y que a su vez al estar fuertemente ligada a su familia le permitió ubicarse en ella como hijo, siendo débil pue, como objeto exogámico para tomarla como mujer. Precisamente éste fue otro de los motivos por donde pasó la elección de Carmen.

Analizando en su dimensión temporal, los acontecimientos significantes de la vida de esta pareja, notamos que se hallan organizados en torno a dos movimientos: alejamiento y acercamiento con respecto a la familia materna.

El establecimiento de la alianza circunscribió el primer alejamiento.

Después de la llegada de la primera hija, quién certificaba la existencia de la pareja conyugal y los ubicaba como padres, Reinaldo comenzó a trabajar con el suegro, lo que implicó una vuelta a la familia materna.

Otros hechos que cobraron la significación de afianzamiento de la alianza matrimonial fueron la compra del departamento y el nacimiento del segundo hijo, los cuales estuvieron acompañados nuevamente por un movimiento de acercamiento a la familia materna a través de la venta ficticia del departamento al hermano de Carmen.

A partir de qué quedó establecida la conexión en forma permanente.

La consulta se produjo en el momento en que la pareja debía enfrentar una serie de pérdidas: la muerte de los padres, el alejamiento de los hijos, la sucesión del padre de Carmen y la compra de un departamento para la pareja sin hijos.

Esto reactualizaba el conflicto presente en el momento del establecimiento de la alianza, cuyo antecedente había sido la muerte del hermano de él.

Llama la atención la repetición de un lapso temporal (3 meses-3 años) que media siempre entre la pérdida de parientes consanguíneos y lo que denominamos: el pasaje a una "posición diferente".

La alianza implica el pasaje a una "posición diferente" que desplaza el peso de los lazos consanguíneos hacia los lazos conyugales.

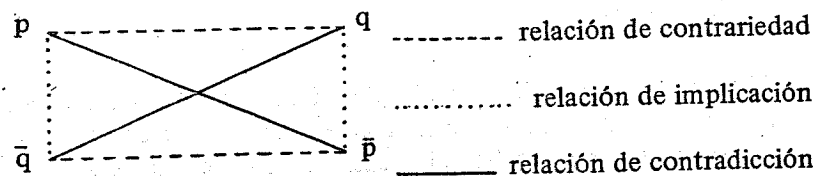
En ellos esta situación tuvo el carácter de una ruptura narcisista difícil de tolerar, lo que los obligaba, cada vez que la alianza se hacía evidente a realizar una operación a través de la cual permutaban la posición diferente por la conservación de la posición anterior.

Utilizaremos, para dar cuenta de esta operación, el modelo de estructura elemental de la significación propuesto por Greimas (6) el que a su vez es un reenfoque del modelo formal abstracto denominado en matemáticas "grupo de Klein".

Diremos, muy esquemáticamente y sólo en virtud de lo que atañe a nuestra exposición, que el modelo consta de cuatro términos: p , $\bar{p}$, q , $\bar{q}$ que poseen entre sí tres tipos de relaciones:

- 1) relaciones de contradicción: $p-\bar{p}$ y $q-\bar{q}$
- 2) relaciones de contrariedad: $p-q$ y $\bar{p}-\bar{q}$
- 3) relaciones de implicación: $p-\bar{q}$ y $q-\bar{p}$

Podemos representar estas relaciones del siguiente modo:



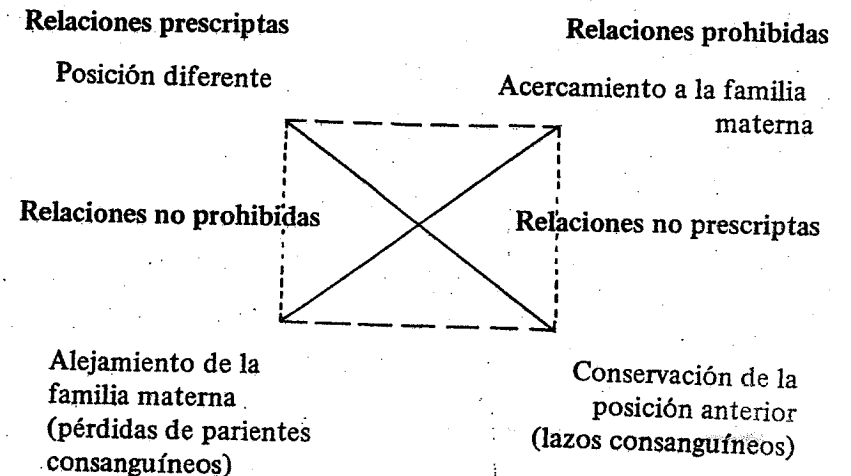
Este sistema cuenta con dos reglas, una de las cuales define la prescripción o definición positiva del sistema y la otra define la prohibición o definición negativa del mismo. A su vez la prescripción admite como término contradictorio una no prescripción y la prohibición una no prohibición.

Se trata de un sistema cerrado, que al permitir operaciones de permutación entre sus términos genera transformaciones en dicho sistema.

Esto supone que el cambio de ubicación de uno de los términos determina el cambio de todos los otros términos del sistema y que, cada operación que va a dar lugar a una transformación de la estructura debe realizarse por el cambio de los términos dos a dos.

Los cuatro términos que vamos a tomar en consideración son los siguientes: **posición diferente** que está en relación de contradicción con la **conservación de la posición anterior**, **alejamiento de la familia materna** cuyo término contradictorio es el **acercamiento a la familia materna**.

Esto daría lugar a la siguiente representación:



Tal como dijimos la relación de alianza (posición diferente), está en relación de implicación con el alejamiento de la familia materna, integrando ambos el espacio de lo prescripto. A su vez el acercamiento a la familia materna implica la conservación de la posición anterior y su integración dentro del espacio de lo prohibido.

En virtud de la intolerancia que ello tenían a esta situación, recurrieron a una operación inconsciente de permutación entre

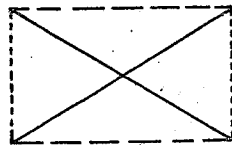
La relación de alianza

los términos contradictorios del sistema; por medio de la cual la conservación de la posición anterior que implicaba el acercamiento a la familia materna pasaron a integrar el ámbito de las relaciones permitidas y el alejamiento de la familia materna con su implicado: posición diferente constituyeron el ámbito de lo prohibido.

Relaciones prescriptas

Relaciones prohibidas

Conservación de la posición anterior



Alejamiento de la familia materna

Acercamiento a la familia materna

Posición diferente

La relación de alianza

Conclusiones

Pensamos que la relación de alianza debe ser entendida como el eje semántico que subsume dos términos polares: los dictados por la ley del tabú del incesto y los que responden a la ley del cumplimiento del deseo. En este sentido es siempre una formación de compromiso.

Como señala L. Strauss, todo matrimonio es un encuentro dramático entre la Naturaleza y la Cultura, entre el amor familiar y el amor conyugal. El himno hindú del matrimonio, citado por este autor, dice: "¿Quién entregó a la novia, a quién la entregó?".

Si la estructura elemental del parentesco incluye la pareja conyugal en su relación con la familia materna, postulamos que la relación de alianza como formación de compromiso reúne en sí las contradicciones aportadas por los cónyuges y por la familia materna. Podemos observar en el material analizado, que la familia realizó una semi-entrega de una mujer a un hombre que por sus características no se la iba a llevar.

Es explicable así el acercamiento a la familia materna cuando determinados acontecimientos adquieren un significado que desequilibra tal compromiso. Para finalizar y en conexión sistémica con lo anterior pensamos que: cuanto mayor predominio tienen en una familia las relaciones narcisistas, menor es la función del padre como el articulador que permite el pasaje de la Naturaleza a la Cultura, de la endogamia a la exogamia.

BIBLIOGRAFIA

1. Ahlin, G.- La pareja en espejo. Un tipo particular de pareja. Revista Argentina de Psicología, No 22. Buenos Aires, 1977.
2. Lévi-Strauss, C.- Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires, Paidós, 1969.
3. Lévi-Strauss, C.- Antropología estructural. Buenos Aires, Eudeba, 1969.
4. Berenstein, I. - Familia y enfermedad mental. Buenos Aires, Paidós, 1976.
5. Freud, S.- Introducción al narcisismo. O.C. Tomo 1. Madrid. Biblioteca Nueva, 1967.
6. Greimás, A.J.- En torno al sentido. Ensayos semióticos. Madrid. Fragua, 1973.

Articulación del enfoque familiar en el proceso terapéutico de un paciente discapacitado

SUSANA BARILARI
STELLA MARIS MOLINA
IVONNE ROZENBERG

** (Una comunicación preliminar fue presentada en las Primeras Jornadas del C. I. E. P. sobre "Tratamiento de la Psicosis" los días 1, 2 y 3 de septiembre de 1978 en Buenos Aires.*

Antecedentes y evolución del paciente.

La discapacidad de Esteban que actualmente tiene 30 años, fue producto de la parálisis infantil que padeció a los 5/6 años y fue vivida por la familia como algo secreto o que debía ocultarse. Esto llevó a su segregación interna, tanto es así que lo privaron de la rehabilitación psicofísica y social que pudiera brindarle una institución especializada como fue en ese momento el Instituto de Rehabilitación del Lisiado. En este Instituto se trabajó con el concepto de rehabilitación integral donde un equipo de especialistas daba al paciente y a la familia información y tratamiento.

El recorrido de este paciente para lograr su rehabilitación fue diferente. La familia se encargó dentro de la casa de inventar aparatos, poleas, etc., para permitirle moverse. Pero no le proveyeron de sillón de ruedas hasta los 18 años, debiendo moverse precariamente hasta entonces mediante una silla común con ruedas fabricada por el padre. De esta manera quedaba segregado de sus pares lisiados y privado de una readaptación adecuada. La familia así lo mantuvo en rígido cerco que reforzó la simbiosis familiar y la endogamia, no permitiendo la individuación.

Terapia Familiar, 4, 1980

19

S. Barilari, S. M. Molina y I. Rozenberg

Hasta ese entonces la ayuda brindada por los padres y los logros del paciente fueron precarios. A raíz de iniciar su hermano Juan un tratamiento psicoterapéutico empieza a tener conciencia de la posibilidad de ayuda fuera de la familia que le permita más independencia. Se acerca a ella luego de la ruptura de su primer intento de pareja que le demuestra por un lado que es capaz de salir solo con una mujer, de tener relaciones sexuales y de moverse sin el acompañamiento de los padres y por otro lado le demuestra "todo lo que le falta". Se pudo pensar en un buen pronóstico porque llega al tratamiento con una clara necesidad de individuación: tiene como primer proyecto la compra de un auto para moverse solo; también proyecta estudiar y trabajar fuera de su casa.

Todos estos planes son interrumpidos por una crisis psicótica del hermano y la consecuente movilización familiar. Esta pasa a ser su temática en el tratamiento. El paciente se ve abocado a entender "qué pasa en la familia y qué le pasa a él, con lo que pasa en su familia". Al percibir la gravedad del drama familiar y sentirse parte de él, arbitra inicialmente mecanismos de defensa que lo protejan de sus fantasías de contaminación de la psicosis.

Habiendo sido Esteban, el miembro más indefenso de la familia, se ve enfrentado a la enfermedad de los otros. Aparece primero el temor a la psicosis, esto lo lleva a no negar la problemática, pero arbitra mecanismos de defensa evitativos, tratando de poner distancia y de protegerse solo. También teme la desprotección en que lo sumen, la enfermedad de los familiares, de los que había dependido, y la exigencia que representaba para él que el "hermano sano" de la familia ya no lo fuese más.

Más adelante al mismo tiempo que comprende la trama familiar hace denodados esfuerzos para no quedar atrapado en ella, prestando apoyo sin pretender reemplazar al padre, dando ayuda sin quedar sometido, creciendo como individuo sin paternalizar su rol de hijo. Esto implicó un duro y doloroso proceso en el que tuvo que postergar el cumplimiento de sus proyectos individuales pero realizando un crecimiento más sólido y seguro que le permitió desarrollar sentimientos de solidaridad y la capacidad de proteger y protegerse, hacer por los demás y por sí mismo.

El proyecto familiar era que ambos hermanos fueran conta-

20

Terapia Familiar, 4, 1980

dores trabajando Juan afuera y Esteban dentro de la casa. Este, en cambio, se dedicó a dar clases particulares, inicialmente para alumnos primarios, luego secundarios y actualmente preparando ingresos a la universidad. Trabaja en la casa, totalmente independiente, y proyecta en este momento comprarse un departamento que tomará como lugar de trabajo y futura vivienda.

Significación de la parálisis en el contexto familiar.

El mantenimiento de la situación de dependencia e incapacidad del paciente, nos habla de que esta parálisis, tiene un significado especial para la familia. Pareciera que constituyó un intento de depositar e inmovilizar en un miembro paralizado y segregado internamente conflictos familiares no resueltos.

La enfermedad del hijo mayor debe haber despertado en los padres, una intensa culpa, acompañada de una fantasía de irreparabilidad, que motivó su segregación interna (Pichon Riviere). Pero además debe haberse desencadenado un antiguo temor de que en el seno de la familia ocurrieran situaciones tanto o más dramáticas y para impedir su reiteración recurrieron a la paralización tanto de los conflictos irresueltos como de los recursos sanos grupales e individuales. Se defendieron dentro de una estructura narcisística y simbiótica, de las fantasías de muerte y psicosis que más tarde se concretaron. De este modo esta familia simbióticamente paralizada se defendía así del sentimiento de despersonalización impidiendo en consecuencia la individuación y exogamia de los hijos.

Los hijos tuvieron dificultades para lograr una buena identificación, a causa de que los roles parentales estaban confundidos. La inseguridad de los padres, no permitió brindar a los hijos figuras de identificación claramente delineadas, probablemente porque no elaboraron el duelo por sus propios padres.

Hemos referido cómo Juan y Esteban inician tratamiento individual. Pero la familia no toma conciencia de la enfermedad grupal hasta que Juan hace una crisis psicótica que requiere su internación en un servicio psiquiátrico, y allí comienzan un tra-

tamiento familiar. Esta terapia es muy resistida por la familia. Es el hijo discapacitado el que lleva a los padres a las sesiones: "Todos los choferes de taxi pensaban que ellos me llevaban a mí y yo era el que llevaba a mi familia".

El padre hace una crisis melancólica. No quiere salir de la casa, y deja de trabajar. La crisis económica de la familia es lo que alarma a la madre. Durante la crisis del padre por primera vez se acerca y habla a Esteban que ya no es el "inválido" para ella. Luego el padre mejora. La madre hace un cuadro clínico confuso y no bien diagnosticado (posible encefalitis o meningitis con secuelas) y muere luego que el hermano sale de la internación.

Cada vez que alguien mejora, otro miembro de la familia hace una crisis grave, que a su vez moviliza a otros miembros en una verdadera espiral centrípeta que parece llevar a la psicosis o a la muerte. Cada miembro, a su turno no tolera la soledad que implica la individuación. Así mientras un hijo intenta diferenciarse, otro juega el rol complementario y refuerza su ligadura simbiótica (Esteban mejora y se produce la internación de Juan).

Rota dramáticamente la simbiosis paralizante, que no permite el crecimiento emocional, quedan al descubierto las profundas carencias de los padres. Los hijos a pesar uno de su discapacidad y el otro de sus limitaciones emocionales, desempeñaban de algún modo los roles parentales para esos padres narcisistas que no podían, por sus carencias, establecer entre sí y con sus hijos una relación de objeto protectora y reaseguradora. Los padres proyectan en los hijos aspectos deseados de sus padres infantiles tratando de que cubran sus necesidades regresivas, debido a que los progenitores no pudieron elaborar el duelo por los propios padres ideales evitando así el dolor de la separación que podría llevarlos a una mejor individuación. En esta atmósfera de proceso primario compartido, cada miembro puede asignar un papel parental inconscientemente deseado a otro; con lo que establecen una estructura interconectada de maniobras conservadoras de objeto.

El material obtenido a través de la terapia individual, coincide con el perfil que nos brindara el terapeuta familiar.¹ En ambos hay aspectos oscuros e indescifrables, que hablan de un secreto

(1) Dr. Daniel Wiebel

familiar no develado. La familia se presentó con una marcada actitud de aislamiento, temor a la gente y confianza sólo en sí mismos. Se estructuraron en torno a la enfermedad de Esteban tratando de depositar el rol de hermano mayor en Juan.

A pesar del hermetismo de los padres en la terapia familiar, Esteban nos procuró la posibilidad de reconstruir parte de la historia familiar a través del material aportado en la terapia individual.

La madre no toleraba el crecimiento y separación de los hijos. Daba mientras dependían de ella y si los hijos se alejaban los abandonaba. Sus padres murieron cuando era pequeña y fue criado por sus hermanos.

El abuelo materno fue un "dandy" que permanecía mucho tiempo fuera de la casa. La abuela materna una especie de mucama del padre. La hija era una de las menores y a su vez como la madre mucama de las hermanas e igualmente sometida.

En la familia materna se castigaba con el encierro sin explicar la causa. Parecía que había cosas de las que no se podía hablar, la madre lo evidenció con su hermetismo y angustia.

El padre pierde fortuna abruptamente en el año 1974. Es una figura débil, pasiva; transmite una sensación de impotencia, de carencia. La abuela paterna muere luego de una prolongada internación en un hospital psiquiátrico. Su enfermedad marcó indeleblemente el clima familiar. El padre era renuente a visitarla y cuando lo hacía a instancias de la madre se deprimía y angustiaba mucho. El abuelo paterno vino de Italia escapando a un rol muy denigrado y sometido en su propia familia de origen, donde se destacaba la figura de un bisabuelo aparentemente fuerte y autoritario.

Este abuelo debió ser rescatado por los padres de Esteban y Juan de las profundas depresiones en que caía a raíz de la enfermedad de su esposa.

Actualmente el padre continúa con crisis depresivas y se tienen que ocupar de él. Entre los cónyuges la madre era la que decía lo que había que hacer. Muerta la madre, el padre no tiene quién lo mueva y queda también paralizado. Se unieron por un perfil similar de sometimiento y de represión de la agresión del cual se defendían de maneras distintas.

En la familia paterna, a raíz del episodio de la separación del

abuelo de su propia familia, quedan como alternativa para sus hijos la ruptura o el aislamiento. En cambio en la familia materna lo predominante antes de la ruptura de la simbiosis fue el encierro endogámico y el silencio utilizado como castigo o como encubridor de secretos.

Podemos pensar que las carencias de los padres, su debilidad yoica y sus mecanismos regresivos y paralizantes están determinados por la herencia psicológica de sus propios padres. Estos "restos fósiles familiares" son determinantes de una predeterminación siniestra de tipo melancólico que los padres de esta familia no han podido desenterrar para elaborar y que sí tratan de hacer los hijos. Llamativamente el que ha conseguido hasta el presente más logros es el hijo discapacitado segregado internamente en un comienzo.

Nos hemos preguntado si la ruptura de la simbiosis paralizante en esta familia fue causa de la depresión melancólica del padre y de la misteriosa muerte de la madre. O sin la movilización y crisis de los dos hijos que culmina en un tratamiento familiar no impidieron que algo que ya estaba muerto anteriormente se manifestara. 1

Actualmente la familia puede ver más claramente cómo la mejoría de uno de los miembros lleva como consecuencia la crisis de algún otro. Esto que ha sido elaborado por Esteban durante su tratamiento puede abordarlo Juan ahora; y ante la amenaza de una crisis del padre pueden unirse los dos hijos ya sin rivalidades ni competencias y planear juntos una estrategia ante el cuadro actual del padre. Esto indica un cambio real en el equilibrio homeostático de la familia. Es la primera vez que no hay fuga, ni muerte, ni encierro.

(1) Pensamos que la estructura familiar donde la muerte y las pérdidas irreversibles determinan un clima melancólico no implica una causalidad lineal sino circular con respecto al surgimiento de una parálisis o de cualquier otra enfermedad irreversible. Agradecemos la comunicación personal del Dr. Alfredo Canevaro.

La articulación de la terapia individual con el contexto familiar real. Objetivos y modalidad técnica.

Cuando hablamos de "Proceso Terapéutico" lo entendemos como el Dr. Jorge García Badaracco siendo "el conjunto de transformaciones que puede experimentar un individuo a través del tratamiento. ... (Y) constituye necesariamente una unidad que consiste en una sucesión de cambios que pueden presentarse o darse en realizaciones variadas pero que tienen una coherencia interna y un sentido progresivo de desarrollo hacia una condición humana de mayor integración de la personalidad y mayor madurez y equilibrio emocional".

Las distintas corrientes de la terapia individual psicoanalítica centran su tarea en la relación bipersonal, teniendo en cuenta fundamentalmente el encuadre, la transferencia y el mundo interno del paciente. Esto es a los fines de que el sujeto modifique su estructura intrapsíquica y pueda cambiar su modo de relación con las personas actualmente significativas para él a medida que madura emocionalmente.

El tratamiento familiar, fue breve y dificultoso, muchas veces saboteado por alguno de los padres. Luego de una sucesión vertiginosa de acontecimientos que culminan con la muerte de la madre, continuaron reuniéndose los hijos con el padre e incluyendo a un tío y una tía maternos, pero con tan poca fuerza que el tratamiento terminó extinguiéndose.

A nuestro juicio el tratamiento familiar resultó fallido porque no se pudo elaborar el duelo por la muerte de la madre, y porque existieron siempre secretos familiares no develados por ella. Seguramente fueron sucesos o fantasías vividos como siniestros; fue así como el secreto real para la madre quedó enterrado en su propia tumba.

A pesar del intento de tratamiento familiar frustrado, quedó la alternativa en el tratamiento individual de trabajar con el contexto familiar real y la constelación interna del paciente.

El tema familiar aparece en todo tratamiento psicoanalítico individual y provee material para el análisis de identificaciones, objetos internos y relaciones de objeto del paciente. Pero creemos

que la familia y la estructura familiar están presentes e inciden en el paciente y en la relación terapéutica de diversas maneras:

— como una estructura relacional de la que el paciente forma parte por relaciones de consanguinidad, filiación y en el caso de los padres de alianza, de acuerdo a reglas inconscientes que determinan las características fenoménicas del sistema e inciden profundamente en la determinación de la estructura psicopatológica de cada miembro;

— con la resistencia consciente e inconsciente del grupo familiar al cambio del paciente por la función compensadora de su "enfermedad" en la homeostasis familiar.

En el caso que presentamos, fue necesario trabajar aspectos vinculares del paciente con su familia, en la terapia individual. Esta manera de modificar el contexto permitió a la terapeuta disminuir el alto monto de angustia con que él concurría a su sesión en el momento de la crisis familiar. Esteban no sólo logró entender qué es lo que a él le ocurría dentro de su mente con su familia interna y poder pensar para conocerse a sí mismo y elaborar sus conflictos, sino que también comprendió qué es lo que le ocurría a sus familiares a los que tan simbióticamente estaba unido.

Trabajando los pares antitéticos paralizado-paralizante se logró disolver el núcleo simbiótico, ese aspecto "parálisis" que no sólo existe en él sino también en su familia.

Aún contando con otras fuentes de información en esta terapia individual y trabajando sobretodo con el discurso del paciente, pudimos entender la estructura familiar a la cual pertenece, entender el lugar que él ocupa en ella y los vínculos complementarios con otros miembros de la familia. La interpretación de estos aspectos permitió la elaboración del paciente y la repercusión de sus cambios en la familia. De manera tal que, él llegara a decir: "En mi familia parece que las cosas nunca pueden salir bien".

En el caso del tratamiento individual de nuestro paciente discapacitado la familia se impuso en el campo consciente e inconsciente a poco de comenzar de una manera invasora que le impedía todo intento de diferenciación y proyecto individual. Se trataba de una realidad interna y también externa, tan real la una como la otra, que "paralizaban" al paciente en el nivel psicológico

y emocional.

Esta situación nos coloca frente a una disyuntiva: o bien analizamos los aspectos internos del paciente o bien nos ocupamos de una realidad externa acuciante y regresionante que reclama perentoria atención, (referencia al episodio psicótico de Juan e intensa movilización familiar). Tal vez se resuelva esta disyuntiva en una síntesis que abarque y supere las oposiciones: el análisis del mundo interno del paciente en relación con el lugar que ocupa en la estructura familiar. Es decir, articulando la estructura intrapsíquica individual con la estructura familiar y sus vínculos, se pudo entender la complementariedad psicopatológica que "paraliza" no sólo al paciente sino a la familia de la que forma parte.

Jorge García Badaracco caracteriza estas estructuras familiares como narcisísticas, en las cuales no tiene lugar el proceso de individuación y los miembros mantienen la aglutinación y la simbiosis como el ideal de la relación familiar y esto empobrece el intercambio y la realimentación psicológica con el mundo exterior.

Interpretar las relaciones intrapsíquicas y la correspondiente complementariedad psicopatológica con otros de sus miembros aumenta en el paciente la discriminación interna y externa. Este procedimiento puede ser útil en momentos críticos o en episodios regresivos familiares y también con pacientes que pertenecen a familias de tipo simbiótico. La mayor discriminación entre los propios aspectos inconscientes y los aspectos reales conscientes e inconscientes de su familia permite al paciente aliviar su angustia, disminuir el monto de culpa omnipotente y acceder a la simbolización y posterior elaboración.

El valor de esta estrategia de abordaje reside en recuperar a través de un tratamiento individual la utilidad del "enfoque familiar" en los casos donde se ve frustrada la Terapia Familiar. Además de trabajar el mundo interno del paciente hemos utilizado otros recursos técnicos tales como la interpretación de la estructura familiar a la que pertenece, el lugar que ocupa en ella, los vínculos complementarios y la confrontación de la constelación familiar interna con la real. En todos aquellos casos donde la Terapia Familiar esté indicada y no sea posible llevarla a cabo, creemos que esta técnica puede complementar el enfoque individual tradicional.

BIBLIOGRAFIA

- Berenstein, Isidoro: "Familia y enfermedad mental". Editorial Paidós. Enero 1976.
- Boszormeny Nagy, Ivan y Framo, James L.: "Terapia familiar intensiva". Editorial Trillas. México 1976.
- Bowen, Murray: "Psicoterapia familiar de la esquizofrenia en el hospital y en la práctica privada". Cap. 5 de "Terapia familiar intensiva" de Boszormeny Nagy y Framo.
- Framo, James L.: "Fundamentos y técnicas de la terapia familiar intensiva". Cap. 4 de "Terapia familiar intensiva" de Boszormeny, Nagy y Framo.
- Freud, Sigmund: "Lo siniestro". Ediciones Noe. Agosto 1976.
- García Badaracco, Jorge: "La familia como contexto real de todo proceso terapéutico". *Revista Terapia Familiar* N° 1. Marzo 1978.
- Pichón Riviere: "Del psicoanálisis a la psicología social". Tomo II. Cap. "Grupos familiares un enfoque operativo". Editorial Galerna. Abril 1971.
- Mahler, Margaret: "Simbiosis humana: Las vicisitudes de la individuación. Ed. Mortiz, México 1972.

Estudio de la composición familiar de las internas condenadas en la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Aplicación del Familio-grama.

SUSANA MORAN DE GIUDICE

*El presente trabajo ha sido realizado en el Departamento de Investigación del ex- Centro de Estudios Criminológico (actualmente Dirección de Asuntos Penales), Mendoza.**

En los últimos años se han realizado diversos aportes en lo que hace a las nuevas formas de asistencia en el campo de la salud mental. Entre ellos se destaca la valoración del grupo primario del ser humano: la familia, considerándolo como unidad vital intermedia de lo social, formadora e informadora básica, sustento de la personalidad, elemento primordial de socialización.

Nos interesa éste último aspecto ya que nuestro campo de trabajo (Criminológico) nos conecta directamente con las conductas sociales ilícitas, por eso decidimos enfocar el estudio desde la perspectiva familiar y así lograr una descripción más amplia de la situación vivencial de la mujer que ha delinquido, a partir del conocimiento de su grupo primario.

Si bien son múltiples los factores que influyen en la etiopatogenia delictiva, el presente trabajo centraliza el estudio en el área familiar.

El marco de referencias de este trabajo está basado en las experiencias realizadas por los investigadores y terapeutas familia-

Susana M. de Giudice

res que utilizan como método para el tratamiento de los conflictos psíquicos, no ya al paciente individual sino a la familia como a una estructura, un todo orgánico en el cual el "paciente designado" sería un síntoma que nos remite a una situación amplia, totalizadora: su grupo primario de pertenencia.

De esta manera se relacionan los problemas psicológicos con los psicosociales de la familia y la comunidad.

Partimos de las siguientes hipótesis:

1) Si el proceso de socialización que permite al ser humano aprender roles, estilos y conductas sociales se lleva a cabo fundamentalmente dentro del seno familiar, en las personas que delinquen (índice de perturbación individual y social) ese grupo básico debe haber sido insuficiente como para proveer valores, estilos, normas y conductas apropiadas.

2) Si la estabilidad emocional requiere un lugar nutricional para crecer y desarrollarse en armonía psicofísica, la inestabilidad del grupo primario puede ser factor de descontrol emocional, inseguridad y desconfianza en las relaciones sociales posteriores.

Estas hipótesis se pueden resumir en una:

el grupo familiar opera directamente en el proceso de socialización del ser humano por lo tanto la perturbación del grupo familiar potenciaría la perturbación social de cada miembro, siendo la conducta delictiva un signo que nos remite a un grupo familiar enfermo. No es nuestra intención derivar la responsabilidad individual sino favorecer la comprensión de quien ha cometido una conducta delictiva.

De tal manera que la HIPOTESIS CENTRAL es la siguiente:
EL ACTO DELICTIVO SERIA UNA REACCION SOCIAL INCONTENIDA COMO LO FUE EL PROCESO DE SOCIALIZACION PRIMARIO DE QUIEN DELINQUE.

Siendo el delito una forma de acción social, llamamos reacción social a la re-activación de los estímulos desfavorables que se encuentran internalizados desde los primeros años y que re-viven en un momento determinado ante una situación adversa. Decimos incontinido, por la incapacidad de controlar y refrenar impulsos.

Llamamos familia sana a aquel grupo primario que como unidad operativa consanguínea promueve el desarrollo, biopsico-social transcendente de sus miembros, actúa como proveedora de

valores y objetos apropiados para el logro del crecimiento individual y grupal; permite que los roles bien definidos sexuales se complementen como para satisfacer las demandas de una interacción favorable, usando ante el conflicto recursos para retomar la cohesión y el equilibrio.

De tal manera que, de acuerdo a esta definición aquella familia que por circunstancias adversas esté imposibilitada de responder a estas necesidades vitales del ser humano, es enferma.

El presente trabajo tiene varios objetos que comparten su importancia:

a) Conocer la realidad psicosocial de las internas condenadas para corroborar las hipótesis anteriormente presentadas, sirviendo éstas de semilla gestadora de nuevas hipótesis.

b) Presentar un modelo de representación gráfica del grupo familiar (familiograma) de las internas para que sea incluido no solamente en la ficha, historia clínica o legajo administrativo sino primordialmente en el espacio mental de las Autoridades Penitenciarias, agentes de seguridad, el terapeuta e investigador criminológico y finalmente toda persona que tenga relación con la rehabilitación psicosocial de la persona que ha delinquido para facilitar la comprensión de la conducta social ilícita.

En realidad estas dos intenciones se confunden en un mismo interés: ampliar el campo diagnóstico para operar en la raíz misma del conflicto y por lo tanto favorecer la recuperación individual y social como asimismo la reinserción en la comunidad de las personas que han delinquido, siendo de esta manera el pronóstico más optimista debido a la cantidad de variables con las que se trabajaría terapéuticamente.

El familiograma es una técnica de representación gráfica de la familia basada en el modelo biológico, que permite visualizar los vínculos de las personas que integran el grupo familiar y al que se incorporan los datos mediante símbolos previamente acordados. Incluimos una muestra del mismo al final del trabajo.

METODOLOGIA:

El equipo de trabajo estuvo formado por cuatro (4) licenciadas en Psicología, actuando una de ellas en calidad de coordinadora. *Terapia Familiar*, 4, 1980

Susana M. de Giúdice

ra, y una estudiante del último año de la carrera de Psicología. La tarea pasó por las siguientes etapas:

1) Análisis y evaluación del programa de investigación: era nuestro deseo conocer la situación familiar de la totalidad de las internas condenadas pues, valorando la influencia del grupo primario en el proceso de socialización suponíamos que nos íbamos a encontrar con familias enfermas.

2) Distribución de las internas: debido a que trabajamos con la totalidad de las mismas (21) internas, no se realizó selección distribuyéndose por orden alfabético (5) internas por ayudantes de investigación.

3) Encuadre: Las entrevistas se llevaron a cabo en el pabellón de mujeres de la Penitenciaría Provincial de Mendoza. Las mismas eran de cincuenta (50) minutos de duración con un promedio de cinco (5) entrevistas por interna. Las entrevistas eran alternadas a fin de darles tiempo a las internas para la comprensión de la consigna como asimismo para completar los datos con los familiares a través de las visitas que recibían las internas.

Este trabajo comenzó en noviembre de 1977 y concluyó en junio de 1979, ocupando un período de 18 meses.

Realizábamos reuniones de equipo completo, en principio, las mismas estaban centradas en lograr el mejor acercamiento posible a las internas para obtener una buena relación de entrevistas, para ello, efectuamos técnicas especiales (role-playing y dramatizaciones) poniéndonos en lugar de la interna para conseguir el modo de aproximación más favorable.

De esta manera cuidadosa, elaboramos la consigna que entre otras cosas explicaba el sentido de la investigación, el modo de realización y la importancia de este trabajo consistía en fundamentar científicamente una nueva forma de operar terapéuticamente con las personas que habían tenido un problema social.

Generalmente en las reuniones semanales se evaluaba las entrevistas llevadas a cabo con las internas y se proyectaba la evolución del trabajo; además se replanteaba el objetivo de la investigación ya que debido a la fuerte tendencia a ejercer el rol asistencial el grupo caía en la tentación de efectuar psicoterapia ante la evidencia de la necesidad de ayuda psicoterapéutica por parte de las internas como también de recibir asesoramiento por parte de las celadoras.

Si bien nuestro objetivo central no era la intervención terapéutica, tuvimos la satisfacción de evacuar múltiples consultas, derivando las necesidades a quién podía dar la solución de fondo dentro de la Institución Penitenciaria.

4) Después de obtener los datos a través de las entrevistas elaboramos el familiograma. A través de su lectura, evaluación y control posterior con cada interna pudimos conocer el proceso de socialización primario de cada una de ellas y elaborar las conclusiones que son las siguientes:

- La mayoría de las internas (80,95 por ciento) proviene de una familia de baja posición socio-económica-cultural. (Llamamos baja posición socio-económica-cultural a factores como: vivienda precaria - inestabilidad laboral - escasa educación sistemática.

- La relación con sus padres ha sido desfavorable en un 95,23 por ciento de los casos (sólo 1 interna no aportó datos de su infancia y familia).

Llamamos relación desfavorable a aquellas que por razones de carencia, inestabilidad o conflicto, el grupo familiar no ha podido brindar un marco apropiado de seguridad para satisfacer las necesidades básicas psicosociales.

- La incapacidad de los padres de hacerse cargo de sus hijas da lugar a la inestabilidad y a la movilidad geográfica. En 66,66 por ciento de los casos fueron criados por otras personas o instituciones.

- En un 71,42 por ciento (15 internas) proviene de una familia numerosa de más de 4 hermanos.

- De las 11 internas que cometieron homicidios 9 fue por conflictos de pareja, (81,81 por ciento).

Del total de homicidios cometidos (11 internas) en 6 casos (54,54 por ciento) fue cometido por una relación triangular ya sea por una nueva relación amorosa de la interna, caso en que el homicidio es cometido en la figura de la primera pareja, ya sea en el caso de una nueva relación de su pareja con otra mujer.

- La mayoría de las internas sólo han alcanzado el nivel primario (Ver el cuadro adjunto a la nota).

- Relación heterosexual temprana (de 12 a 19 años, en un 66,66 por ciento (14 internas).

- Contraen matrimonio posterior al delito 5 personas (23,80 por ciento).

- Mantienen contacto con los miembros de su familia:
 - a) en relación directa por visitas: 16 internas (79,19 por ciento).
 - b) en la relación indirecta, (por correo), 3 internas (14 por ciento).

Dos internas no tienen contacto con ninguna persona. Tanto los porcentajes que se observan en el cuadro referente a los ítems evaluados como las conclusiones del proceso de socialización primario corroboran las hipótesis que sostienen que si el proceso de socialización primario efectuado a través de la familia es perturbado, también lo serán las posteriores relaciones y actitudes sociales.

Por lo tanto se hace evidente la necesidad de incorporar en el proceso terapéutico (de quién padece una perturbación social cuya manifestación o síntoma sería la conducta social ilícita) al grupo familiar a fin de que desde él se reestructuren las situaciones que provocaron el conflicto.

Curar o rehabilitar el síntoma (delito) no es curar la enfermedad. De no operar en la enfermedad reincidiría el síntoma.

El aspecto profiláctico de esta medida está centralizada en la tarea de reordenar y reparar los intercambios distorsionados para lograr no solamente un reingreso armónico del miembro excluido, sino también y principalmente evitar las mismas perturbaciones sociales, consecuencia de nuevas incontinencias.

CONCLUSIONES:

- 1) En los casos estudiados: (la totalidad de las internas de la Penitenciaría Provincial de Mendoza) observamos que:
 - a) La mayoría de las internas (95 por ciento) provienen de familias severamente perturbadas.
 - b) El acto delictivo puede ser interpretado como una reacción social incontinida como lo fue el proceso de socialización primario de quien ha delinquido.
 - c) Coexisten por lo tanto, en los casos estudiados un proceso de socialización primario incontinido y una reacción social incontinida.
 - d) Al carecer del alimento psicosocial elemental que son las

necesarias introyecciones primarias de afecto, cuidados y control parental, la actuación social posterior es poco resistente, intolerante a la frustración y lábil.

- e) La reacción adulta social ilícita respondería a una actuación de lo recibido pasivamente en la infancia.
 - f) La agresión contenida que no se permitió revelar hacia las personas significativas en el proceso de socialización primario, se despliega en figuras posteriores que reviven la situación dolorosa.
 - g) La conducta delictiva puede ser interpretada como un fracaso ante la tendencia a reparar en una relación social adulta la primaria relación perturbada.
 - h) El desequilibrio psicosocial puede producirse cuando las posibilidades de estabilidad y afecto negadas en los primeros años y esperadas en las tempranas relaciones heterosexuales, no se concretan desalentando toda perspectiva de satisfacción individual y social.
- 2) La técnica del familiograma es sumamente útil para visualizar la conformación familiar y las vicisitudes de las relaciones, facilitando de esta manera la valoración diagnóstica y pronóstica.
- 3) La incorporación de un servicio de asistencia familiar, en los centros de rehabilitación de conductas sociales ilícitas, atendido por especialistas en esta área, respondería a las necesidades observadas en ésta investigación.

TERMINOLOGIA

ABANDONO: Toda ausencia de cuidado maternal y/o paternal por cualquier circunstancia.

ADAPTACION: Cualquier cambio en un organismo ya sea en sus formas, en sus funciones que le hace más capaz para observar en vida o perpetuar su especie.

AMBIVALENCIA: Coexistencia de impulsos y emociones contra-

Susana M. de Giúdice

dictorias hacia el mismo objeto. Generalmente se refiere a la coexistencia de amor y odio.

BIOPSICO-SOCIAL TRASCENDENTE: Características propias del ser humano, biológico, psicológico, social y trascendente.

CONFLICTO CONTENIDO INCONTENIDO: La acción de contener se refiere a la posición madura de poder hacerse cargo de: apoyar, sostener, receptar.

DESARROLLO: Acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral.

DIFICULTAD DE COMUNICACION: Inconvenientes que impiden conseguir hacer participar a otro de lo que uno tiene o desea.

ESPACIO MENTAL: Llamamos espacio mental a la apertura (en el campo de la mente) hacia perspectivas propuestas.

En este caso, lugar en la mente para dar cabida a la inclusión del grupo familiar y sus vicisitudes ante cada ser humano que delinque.

ESTILOS: Uso, costumbre, prácticas, modo, manera, forma.

FAMILIA: Unidad operativa consanguínea que promueve el desarrollo biopsicosocial trascendente de sus miembros.

FAMILIOGRAMA : Técnica gráfica que permite visualizar la composición familiar y las relaciones entre sus miembros. "El delito es un hecho social. Una conducta del hombre que ocurre en la comunidad e irrumpe contra sus leyes y pautas de convivencia".

Elías Neuman

"El delito es una forma de acción social enlazada subjetiva y objetivamente a una situación, a una condición, a un sistema de valores y a un orden jurídico legítimo".

Dr. Manuel Lopez Rey Arrojo

"El delito es un síntoma que remite a una configuración social

particular, estrechamente relacionada con sus primeras interacciones (familiares)".

Susana Morán de Giúdice

REACCION SOCIAL INCONTENIDA: Siendo el delito una forma de acción social llamamos re-acción social a la re-activación de los estímulos desfavorables que se encuentran internalizados desde los primeros años y que re-viven en un momento determinado ante una situación adversa. Decimos incontenida a la incapacidad de controlar y refrenar impulsos.

PROCESO DE SOCIALIZACION PRIMARIO: Suceso mental mediante el cual adquieren los individuos hábitos socialmente deseables a través de su grupo básico de pertenencia.

PROMOVER: Iniciar una cosa procurando un logro. Levantar o elevar a una persona a una dignidad o empleo superior al que tenía. El proceso (mecanismo o defensa) de reducir la culpa por medio de acciones diseñadas para "arreglar" el daño que imagina que ha provocado a un objeto ambivalente. El proceso de recrear un objeto interno que en la fantasía ha sido destruido.

PROFILAXIS: Medidas protectoras contra la enfermedad.

UNIDAD: Propiedad de todo ser en virtud del cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere.

TERAPEUTICO: Ayuda.

ROL: Actuar un personaje.

SOCIALIZACION: Proceso mediante el cual adquieren los individuos hábitos socialmente deseables y quedan capacitados para vivir como miembros de un grupo social.

VALORES: Grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar.

Susana M. de Giúdice

PADECER: Estar poseído de una cosa nociva.

FRUSTACION: Condición del sujeto que ve negada o se niega la satisfacción de una demanda pulsional.

DIFICULTAD DE COMUNICACION - IDENTIFICACION: Es el proceso con el cual una persona tanto: a) extiende su identidad hacia otra persona, b) adquiere su identidad con alguna otra persona.

MIEMBROS: Parte de un todo unida con él.

NORMAS: Reglas que se deben seguir.

OPERATIVA: Que ejecuta diversas acciones o trabajo.

PERTURBACION: Estado emotivo caracterizado por confusión, inquietud, preocupación e incapacidad para llegar a conclusiones que conduzcan a una acción aceptable. Cualquier interrupción en el curso ordenado de un proceso o trastorno en una formación condenada.

POTENCIAL: Reforzar.

PROCESO: Modo como se efectúa un cambio. Cualquier suceso mental considerado como un cambio o serie de cambios.

MADURO O INMADURO: Un individuo maduro es aquel en el cual el desarrollo está completo; un individuo inmaduro es uno en el que está incompleto; un niño es inmaduro y una persona crecida es madura.

Agradecemos a la doctora Ana María Pagnotto de Guisasola su colaboración al mostrarnos el modelo biológico de representación familiar.

Aclaración de las abreviaturas usadas en el siguiente cuadro:

Dificultad de comunicación: (DC)

Muerte: (-)

Abandono: (A)

Casada en primeras nupcias: (P')

Separación: (S)

Directa: (D)

Indirecta: (I)

A)

Edad: 37 a.

Nivel socioeconómico familiar: Medio

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No

Hogar de familia numerosa (+ 4 hnos.): No

Delito Tipo: Homicidio (en relación triangular)

Figura: Esposo

Padres Padre: (+) en la infancia

Madre: (DC)

Pareja: (DC), casada en (P') y (S)

Escolaridad: Secundaria

Relaciones actuales con la familia: (D) madre

Diagnóstico psicológico-psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad psicopática con estructura subyacente de carácter histérico-psicopatía primaria perversa.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la muerte temprana del padre (cuando la interna tenía 4 años)

B)

Edad: 33 a.

Nivel socioeconómico familiar: Medio

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No

Hogar de familia numerosa (+ 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio (en relación triangular)

Figura: Concubino

Padres Padre: (DC)

Madre: (DC)

Pareja: (A)

Escolaridad: Secundaria

Relaciones actuales con la familia: (D) madre, hermana, hijo

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad normal con rasgos obsesivos. Buen nivel intelectual.

Socialización: Proceso de socialización primaria perturbado por la rigidez del padre y reiterados abandonos heterosexuales.

C)

Edad: 44 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 13 a.

Hogar de familia numerosa (+ 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio (con relación triangular)

Figura: Concubino

Padres Padre: (DC) alcohólico

Madre: (DC)

Pareja: (DC)

Escolaridad: Sin escolaridad

Relaciones actuales con la familia: No tiene

Diagnóstico psicológico - Psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad primitiva con rasgos egoístas y ego-céntricos. Coeficiente intelectual posiblemente bajo.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por relaciones conflictivas con su padre alcohólico,

Estudio de la composición familiar

por las carencias socioeconómicas y el precoz abandono de su hogar (10a.).

D)

Edad: 43 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 18 a.

Hogar de familia numerosa (+ 4 hnos.): No

Delito Tipo: Hurto
Figura: Terceros

Padres Padre: (+) infancia
Madre: (+) infancia

Pareja: (DC)
Escolaridad: Primaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) hijas.
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
No tiene

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por carencia de cuidados parentales, dificultades socioeconómicas-culturales que impidieron un adecuado desarrollo psicosocial.

E)

Edad: 41 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 16 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio (en la figura de la pareja)
Figura: Concubino

Padres Padre: (A) infancia
Madre: (A) infancia

Susana M. de Giúdice

Pareja: (A)

Escolaridad: Primaria

Relaciones actuales con la familia: (D) hijos

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

No tiene

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por el temprano abandono de sus padres. Relación heterosexual conflictiva y con reiterados abandonos.

F)

Edad: 28 a.

Nivel socioeconómico familiar: Medio

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): No

Delito Tipo: Homicidio (en relación triangular)
Figura: Terceros

Padres Padre: (DC)
Madre: (DC)

Pareja: (A)
Escolaridad: Secundaria
Relaciones actuales con la familia: (D) padres y hermanos.
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad de tipo histérico hiperemotiva.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la dificultad de comunicación familiar y por la rigidez de las normas y valores imperantes.

G)

Edad: 25 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 12 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Propagación enfermedades venéreas
Figura: Terceros
Padre: (DC)
Padres Madre: (A) en la infancia
Pareja: (DC)
Escolaridad: Primaria
Relaciones actuales con la familia: (D) padre, hija.
Diagnóstico psicológico extraído del legajo:
 Caracteropatía histérica con bajo cociente intelectual y conductas psicopáticas.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por el abandono de la madre y la no aceptación de la nueva pareja del padre que inciden en la precoz relación heterosexual (12 a.).

H)
Edad: 28 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): No

Delito Tipo: Homicidio (en la figura de la pareja)
Figura: Concubino
Padre: (A) infancia, alcohólico
Padres Madre: (DC)

Pareja: (DC), casada en (P')
Escolaridad: Primaria
Relaciones actuales con la familia: (D) madre
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Personalidad de tipo esquizoide, con rasgos de inhi-

bición y depresión de las emociones y agresividad.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por relaciones conflictivas entre los padres. Padre alcohólico abandona el hogar cuando ella tenía 16 a.

I)
Edad: 38 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): No

Delito Tipo: Tentativa de homicidio
Figura: Terceros
Padre: (-) en la infancia
Padres Madre: (A) en la adolescencia

Pareja: 1° (A); 2° (DC)
Escolaridad: Primaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) hijos
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Personalidad primitiva con marcada agresividad y rasgos de necesitada de estima.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por carencias importantes en su etapa de crianza. Padre muere a los 6 meses de ella. A los 5 a. su madre es internada en un hospital.

J)
Edad: 26 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 17 a.
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí
Delito Tipo: Homicidio

Delito **Figura:** Terceros

Padres **Padre:** (A) infancia
 Madre: (A) infancia

Pareja: (A) casada en (P°)
Escolaridad: Secundaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (I) madre
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Personalidad inmadura con rasgos histéricos
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por el abandono de sus padres a los 3 a.

K)
Edad: 22 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 17 a.
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito **Tipo:** Robo
 Figura: Terceros

Padres **Padre:** (A) infancia
 Madre: (A) infancia

Pareja: (S)
Escolaridad: Secundaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) padre, hijo, madrastra
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Personalidad caracteropática inmadura con rasgos obsesivos. Dificultad para controlar la impulsividad.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por el abandono de la madre e internación a los 7 a. en un colegio religioso.

L)
Edad: 22 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito **Tipo:** Corrupción de menores
 Figura: Terceros

Padres **Padre:** (A) infancia
 Madre: (A) infancia

Pareja: No tiene
Escolaridad: Primaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) padres, hermanos
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Personalidad normal y perversión sexual.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la carencia de cuidados parentales, lo que provoca un sentimiento de abandono y dificultad en la adquisición de identificación sexual.

M)
Edad: 45 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 17 a.
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito **Tipo:** Homicidio (en relación triangular)
 Figura: Esposo

Padres **Padre:** (DC)
 Madre: (DC)

Pareja: (DC)

Escolaridad: Primaria
Relaciones actuales con la familia: (D) hijos.
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Temperamento altamente psicopático. Personalidad psicopática, histérica, neurótica.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la precariedad y primitivismo del ambiente socio-económico.

N)
Edad: 38 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 14 a.
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: partícipe de homicidio
 Figura: Terceros

Padres Padre: (DC)
 Madre: (DC)

Pareja: (DC)
Escolaridad: Primaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) concubino
Diagnóstico psicológico psiquiátrico extraído de l legajo:
 Personalidad histérica de base esquizoide con rendimiento intelectual bajo.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado debido a relaciones conflictivas con sus padres y el precoz abandono de su hogar (12 a.).

O)
Edad: 30 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 12 a.

Susana M. de Giúdice

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio (en relación triangular)
 Figura: Terceros

Padres Padre: (A) infancia
 Madre: (A) infancia

Pareja: (A)
Escolaridad: Secundaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: (D) madre
Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:
 Cuadros ansiosos reactivos que en algunas oportunidades han desencadenado crisis de tipo histeriforme.
Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por serias dificultades parentales.

P)
Edad: 21 a.
Nivel socioeconómico familiar: Bajo
Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 18 a.
Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Hurto
 Figura: Terceros

Padres Padre: (A) infancia
 Madre: (A) infancia

Pareja: (S)
Escolaridad: Primaria incompleta
Relaciones actuales con la familia: No tiene
Diagnóstico psicológico psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad inmadura fácilmente influenciable y de rasgos histéricos.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por el abandono de sus padres y por la necesidad de realizar tareas remuneradas a una edad precoz debido a la precaria situación económica.

Q)

Edad: 35 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 15 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio

Figura: Terceros

Padre: (-) adolescencia

Padres

Madre: (DC)

Pareja: Casada en (P')

Escolaridad: Secundaria incompleta

Relaciones actuales con la familia: (D) madre, hermanos

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad inmadura, con rasgos histéricos.

Socialización: Proceso de socialización primaria perturbado por la temporaria separación de madre, por la precaria situación económica familiar por la que debió trabajar. A la muerte del padre internación en la Dirección del Menor. Precoz iniciación en la prostitución.

R)

Edad: 24 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Susana M. de Giúdice

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 16 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Hurto

Figura: Terceros

Padres Padre: (DC)

Madre: (DC)

Pareja: (S)

Escolaridad: Primaria

Relaciones actuales con la familia: (I) padres, hermanos

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

No tiene

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por las relaciones conflictivas con los padres debido al alcoholismo de éste. Contrae matrimonio a los 16 a. y abandona el hogar.

S)

Edad: 52 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 16 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Homicidio (en la figura de la pareja)

Figura: Esposo

Padres Padre: No hay datos

Madre: No hay datos

Pareja: (DC)

Escolaridad: Primaria

Relaciones actuales con la familia: (D) hijas

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad histeroepileptoide posible disritmia cerebral. Elementos melancólicos, pasando por un cuadro depresivo reactivo.

Socialización: El único dato significativo constatado ha sido : la interna padeció meningitis a la edad de 4 a.

T)

Edad: 54 a.

Nivel socioeconómico familiar: Bajo

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): No

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): Sí

Delito Tipo: Aborto
Figura: Terceros

Padres Padre: (-) infancia
Madre: (DC)

Pareja: Casada en (P')
Escolaridad: Primaria incompleta

Relaciones actuales con la familia: (D) esposos, hijos, hermana

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad histérica con rasgos depresivos de tipo reactivo.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la temprana muerte del padre y por compartir la atención y cuidados maternos con 22 hermanos.

U)

Edad: 25 a.

Nivel socioeconómico familiar: Medio

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19 a.): 12 a.

Hogar de familia numerosa (- 4 hnos.): No

Delito Tipo: Robo
Figura: Terceros

Padres Padre: (DC)
Madre: (-) al nacer

Pareja: (S) casada en (P')
Escolaridad: Terciaria incompleta

Relaciones actuales con la familia: (I) padre

Diagnóstico psicológico - psiquiátrico extraído del legajo:

Personalidad psicopática con rasgos de necesitada de estima y marcados componentes histéricos. Agresiva, explosiva, inmadura. Con núcleos depresivos de fondo.

Socialización: Proceso de socialización primario perturbado por la muerte de su madre a los 3 días de su nacimiento. Temprana internación en instituciones y relaciones conflictivas con su padre y madre sustituta. Precoz maternidad a los 12 a.

ESTADISTICAS

Pacientes 6 internadas (- 25 a.) : 28,57%
9 internadas (26-40 a.) : 42,85%
6 internadas (- 41 a.) : 28,57%.

Medio: 4 (19,05%)

Nivel socioeconómico familiar

Bajo: 17 (80,95%)

Relaciones heterosexuales tempranas (12-19a.) 14 internadas (66,66%)

15 internadas (71,42%)

Delitos	Homicidios: 11 (52,38%)
	Robos: 5 (23,80%)
	Abortos: 1 (4,76%)
	Tentativas de homicidio: 1 (4,76%)
	Participación en homicidio: 1 (4,76%)
	Corrupción de menores: 1 (4,76%)
	Propagar enfermedades venéreas: 1 (4,76%)

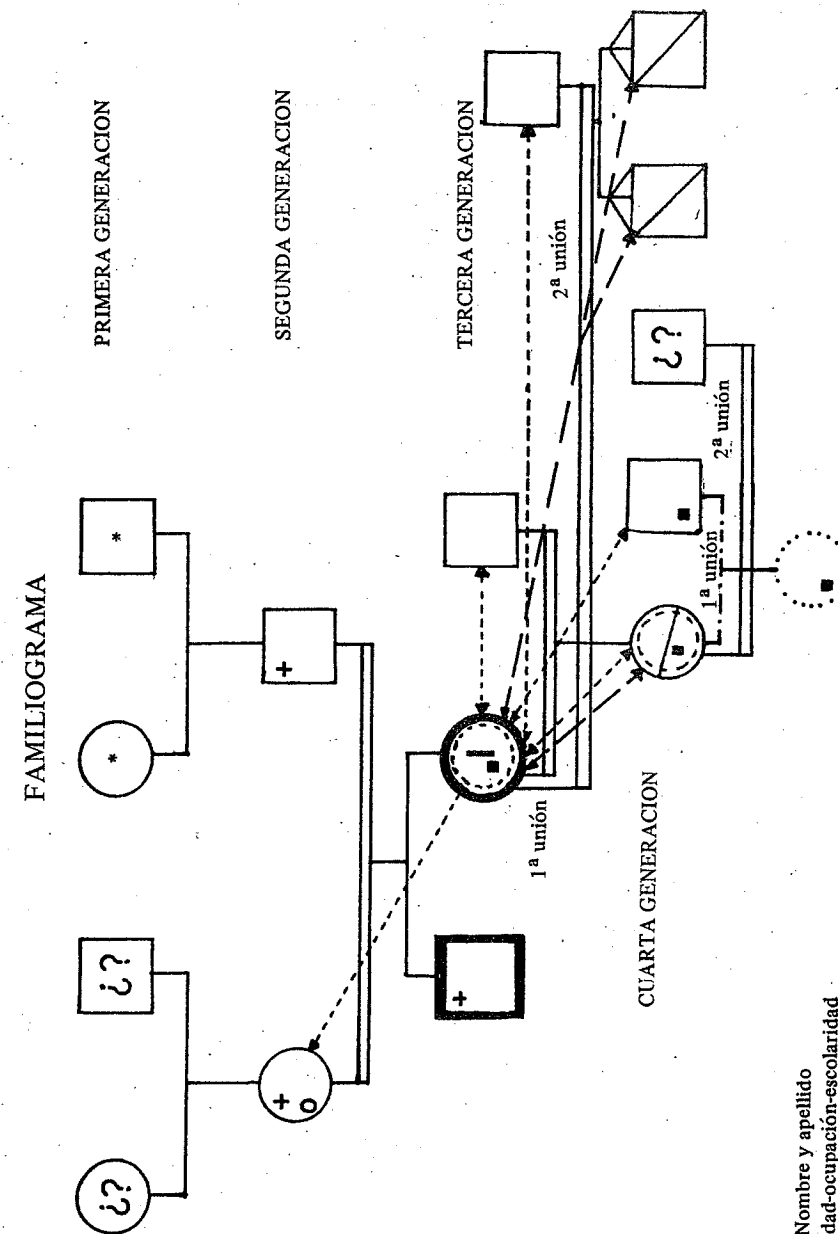
Padres	Padre	(DC): 8 (38,09%)
		(-): 5 (23,80%)
		(A): 7 (33,33%)
Dificultad de comunicación (DC)		
Muerte (-)		(DC): 10 (47,61%)
Abandono (A)	Madre	(-): 2 (9,52%)
		(A): 8 (38,09%)

Escolaridad	Sin escolaridad: 1 (4,76%)
	Primaria incompleta: 6 (28,57%)
	Primaria: 6 (28,57%)
	Secundaria incompleta: 4 (19,04%)
	Secundaria: 3 (14,28%)
	Terciaria incompleta: 1 (4,76%)

Relaciones actuales con la familia	D: 16 (76,19%)
Directa (D)	I: 3 (14,28%)
Indirecta (I)	No tiene: 2 (9,52%)
No tiene	

Socialización	Proceso de socialización primario perturbado: 20 (95,3%)
----------------------	---

**Este trabajo de investigación fue realizado por la Lic. S. Morán de Giudice con las siguientes Ayudantes de Investigación adscriptas: Lic. Ana María Olibano de Casassa, Lic. Susana Montoza de Lanza, Lic. Norma Abbruzzese y la estudiante de Psicología, Elsa Cueto.*



*Nombre y apellido
Edad-ocupación-escolaridad

REFERENCIAS

DATOS

Fecha:	Hombre	Hogar sustituto familiar
Entrevistador:	Mujer	Hogar sustituto instituc.
Nombre del informante:	Interna	Guardería
Actitud del informante ante la entrevistada:	Unión matrim.	Dirección del menor
Domicilio:	Unión extramatrim.	Fallecido
Edad:	Embarazo	Barrio marginado
Fecha de nacimiento:	Aborto espont.	Zona rural
Nacionalidad:	Aborto no espont.	Movilidad
Escolaridad:	Hijo matrim.	Conflictos manifestos
Ocupación:	Hijo extramatrim. reconoc.	Relac. afect. posit.
Delito:	Hijo extram. no reconoc.	Hospital psiquiá.
Víctima:	Hijo adoptivo	No da información
Condena:		
Fecha de ingreso:		
Fecha de egreso:		
Reincidencia:		
Beneficios:		
Conexiones actuales con los miembros de la familia:		
Características relevantes:		
Problema central observado a través del familiograma:		
Sugerencias:		

Sobre mitos y terapias familiares: Ejercicio clínico alrededor de un mito yurok

OSCAR CZERTOK

Doctor en Psicología. Vicepresidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar.

Los trabajos que abordaron la Psicoterapia de la Familia tienen su antecedente en las investigaciones que desde fines del siglo pasado iniciara Freud con sus referencias al Complejo de Edipo, pero el de una TF para el abordaje de las enfermedades mentales y la comprensión del fenómeno psicopatológico individual a partir de un enfoque de los sistemas familiares parece haber sido patrimonio de la cultura de grupos sociales de bien respetable antigüedad.

En los EE.UU. se han desarrollado gran parte de las modernas investigaciones sobre la Terapia Familiar pero antes que el hombre blanco hubiera llegado a esas tierras existían allí entre otras, la tribu de los yurok, que nos describe E. Erickson como "melancólicos guerreros sin armas, pescadores y "recolectores de bellotas de la costa del Pacífico que vivían "en un valle estrecho y eran sedentarios por naturaleza en "un universo con fronteras", es decir, un pueblo que se asemejaría al mundo en que transcurre la vida del actual "hombre blanco" Erickson en su libro *Infancia y Sociedad*, nos cuenta de Fanni, una india yurok que se definía a sí misma y era considerada por los demás como un médico. Según ella en la cultura yurok se considera que las rabietas, la falta de apetito, las pesa-

dillas nocturnas, la delincuencia en los niños y jóvenes (es decir lo que nosotros llamaríamos las neurosis infanto-juveniles) son provocadas por un encuentro peculiar que ella describe así:

“Si después que se pone el sol un niño ve a uno de los miembros del llamado “pueblo sabio”, que es una raza de pequeños seres que precedieron en la Tierra a los humanos, entonces el niño desarrolla una neurosis. Y si no se la cura hasta eventualmente puede morir por ella”.

Este encuentro no solamente tiene para Fanni consecuencias en la conducta sino que abarca problemas somáticos que pueden terminar con la vida del afectado.

Las características del “pueblo sabio” como la descripción del peculiar encuentro patogénico están cargadas de simbolismos:

“Los miembros del pueblo sabio tienen la estatura de un niño pequeño, siempre están en espíritu porque no conocen las relaciones sexuales, son adultos a los seis meses de edad y gozan de inmortalidad, procrean oralmente cuando la mujer come los piojos del varón. El orificio para su nacimiento es vago”.

“Símbolo” designa un objeto cortado en dos que constituye un objeto de reconocimiento cuando los portadores pueden reunir los dos pedazos. Abadi cita en su libro “Renacimiento del Edipo”, una costumbre que tenían los antiguos griegos: “obsequiar a un huésped o amigo con uno de los trozos de un objeto que partían en dos pedazos. Anfitrión y huésped guardaban cada uno de los trozos. Si al cabo de cierto tiempo volvían a encontrarse la unión de los dos pedazos reconstruyendo el objeto era el testimonio de su amistad, eso era el símbolo”. Como psicoanalista me tomé la libertad de sentirme poseedor del otro pedazo que junto con el relato de Fanni ha de otorgarle sentido a este “encuentro con un miembro del pueblo sabio”. Veámoslo como si analizáramos un sueño:

- * **Después que se pone el sol:** Alude a lo inconsciente, lo que no se ve a la luz del día.
- * **Raza de pequeños seres que precedieron en la tierra a los humanos:** tiene que ver con los aspectos regresivos de los padres, que se ponen en evidencia con especial intensidad cuando al ponerse el sol la familia india se recoge en la intimidad apretada de la tienda.
- * **Están en espíritu porque no conocen las relaciones sexuales:** son los aspectos del “espíritu” que influyen inhibiendo el deseo heterosexual de los cónyuges, aspectos que se estructuraron en épocas tempranas de la vida, es decir antes de los seis meses (“Son adultos a los seis meses de edad”). Son las identificaciones primarias, los aspectos del Edipo temprano y que “gozan de inmortalidad” porque son muy difíciles de cambiar.
- * **Procrean oralmente cuando la mujer come los piojos del varón:** La “mujer que come los piojos del varón” implica la existencia de una instancia femenina, representante del continente familiar, que se alimenta de los piojos del varón, la instancia masculina que junto con las bellotas y los peces trae al núcleo hogareño “los piojos”, los contratiempos, los miedos, la angustia del afuera. Entonces, “la mujer comiéndole los piojos al varón” es además de un método de indudable valor higiénico, una poética descripción del rol femenino frente al hombre que acude a su intimidad en la noche. El encuentro de los cuerpos, encuentro simbiótico en que el piojo, molesto morador de las intimidades del varón y que le chupa la sangre, le sirve de alimento a la compañera. Símbolo de la buena pareja de padres en el encuentro corporal: lo que te molesta y te chupa la sangre yo me lo comeré y me servirá de alimento. Pero ojo!, cuando esto ocurre, los miembros del “pueblo sabio” son procreados oralmente: allí nacen los gérmenes de la enfermedad. Cuando la mujer ha de servir de continente a los piojos del varón puede haber un desequilibrio en su homeostasis y los gérmenes de la enfermedad han de nacer “por una procreación oral en que el orificio de su nacimiento es vago”, se perturbará la comunicación y surgirán los metamensajes, o el secreto familiar, lo que no se puede decir sino vagamente... y que por eso genera la enfermedad dice la médica yurok.

Esta interpretación que es tan libre como mi desconocimiento de las costumbres y de la cultura yurok, es sin embargo coherente con la continuación del interesante relato de Erickson: "Las culturas indias de América del Norte parecen tener una sorprendente comprensión de que en ciertas crisis los parientes cercanos carecen ya de utilidad educativa o terapéutica, entonces es cuando acuden a Fanni. **"Toda la familia trae al niño y lo coloca sobre el piso de la sala de la casa de Fanni"**.

Desde nuestro punto de vista de TF. diríamos que es el niño quién trae a la familia a la casa del médico...

Entonces, continúa EE., la hechicera **"aspira el dolor del pequeño, realiza una danza ritual y se va al fondo de la sala para vomitar"**.

Si nos detenemos aquí, veremos que Fanni propone una versión yurok de lo que un psicoanalista debe ofrecer al paciente con su actitud terapéutica. El también ha de ir a los aspectos dolorosos y ha de entenderlos dentro de sí. Comprender el conflicto, y cómo los afectos comprometidos lo hubieran podido atrapar, es decir, los transferido y la contratransferencia para estar suficientemente preparado para la serena comunicación en el aquí y ahora de la sesión. En el síntoma, en el niño depositado sobre el piso hay un pedido de ayuda formulado. Fanni toma a su cargo el dolor, danza y luego se desprende de él. Ha sentido, ahora debe intentar comprender.

Fanni ha de procurar que el grupo realice su catarsis, que verbalice su ansiedad. EE. nombra dos dentro de un repertorio que pareciera que tiene, de pecados, comparables a los hechos típicos que configuran conflictos y que bajo circunstancias ritualistas relaciona con determinados trastornos. Dice:

"veo una anciana sentada en las montañas Peladas y que desea algo malo para otra mujer".

Alude seguramente a las situaciones de odio, rivalidad entre la suegra y la nuera. O bien:

"Veo un hombre y una mujer haciendo cosas (relaciones sexuales) y, aunque el hombre ha rezado para tener suerte y no debería tocar a una mujer..."

Parecería que así consigue que la gente confiese hechos, tendencias, que en vista de la cultura es posible predecir y cuya confesión resulta beneficiosa para cualquiera. En TF. también existen formas

de manejo terapéutico para llegar a la elaboración intragrupal de los acontecimientos traumáticos que obstaculizan mediante su persistencia como secretos familiares, el progreso del grupo, la integración afectiva de la pareja parental, etc.

Para Fanni existe por principio alguna relación entre el niño enfermo y la familia que lo trae. Es decir, no constituyen un sistema escindido entre sanos y enfermos ya que el interrogatorio está mostrándole al grupo que ella ha absorbido un dolor del niño dándole un sentido de mensaje del grupo y no como una dolencia individual en uno de sus miembros. Y esto es consenso cultural: toda la familia acude a la hechicera.

No podemos saber si el grupo condiciona la dolencia o es la dolencia la que está condicionando al grupo, o si ambas cosas ocurren interactuando. Solo afirmamos -con Fanni- que ambos están relacionados y desde allí vamos a trabajar terapéuticamente.

Esto ocurre en Norteamérica, desde la prehistoria de los yurok. En las antípodas, en la península de Indochina, uno de los pueblos más primitivos del Lejano Oriente cuyas costumbres se conservan desde la más remota antigüedad, el de los meos, nos ofrece otro ejemplo de rechazo de la escisión salud - enfermedad en el seno de la familia.

Los meos se ocupan desde tiempos inmemoriales del cultivo de la adormidera. Ellos prohíben con severas penas (exclusión) el consumo de la droga. Solo se han de ocupar del cultivo y de la obtención del producto que luego venden. Solamente los ancianos, cuando ya no pueden trabajar son autorizados a fumar opio. Cuando se comprueba que un individuo de la tribu ha fumado opio el pueblo lo excluye a él... y a su familia a quién culpan de las razones por las que uno de sus miembros se ha entregado a la droga. No solo excluyen al drogadicto sino a toda su familia.

Roberto, sus crisis.

Cuando lo conocí, Roberto tenía 28 años y estaba muy delgado. Psíquicamente muy encerrado en sí mismo, como viviendo un caótico torbellino de fantasías delirantes sumamente terroríficas a las que debía asistir impotente y frente a las cuales nadie podía ayudarlo. Tenía alucinaciones por las cuales las personas ajenas al ámbito familiar de pronto cambiaban de identidad y forma para hacerse peligrosos para él y los suyos, entonces las atacaba. Era muy difícil contactar con él.

Son estos algunos fragmentos de notas tomadas durante la primer entrevista. Faltan los padres. Lo traen sus dos hermanos mayores. Se sientan los tres hermanos frente a mí. Hay un silencio largo y pregunto por los padres. Luis me dice:

— Roberto no quiere venir, así que prefirió que... aunque les dijo que no vinieran, que ellos no vinieran, y como no estaban muy deseosos de venir...

Roberto está muy tenso, me escudriña, siento que controla una fuerte agresividad que surge frente a cada palabra que se pronuncia. Además los hermanos le han endilgado la ausencia de los padres, por eso les digo:

— Sus padres... no quieren venir.

Hablan de la historia de la familia: Enrique, el hermano mayor, fue siempre "el aventurero". El dice que en sus asuntos nunca daba ingerencia a sus hermanos; acostumbraba a irse de la casa. Es 10 años mayor que Roberto. Recuerdan cosas de la infancia; éste que parece una piedra por momentos se moviliza frente a los recuerdos que traen los hermanos y pronuncia algunas palabras que no se entienden. Les pregunto cómo son sus relaciones entre ellos. Enrique no quería saber de nada con sus hermanos. Ellos eran menores, él tenía sus propios intereses. Le "molestaba" estar con ellos. A su vez Luis, el hermano del medio nada quería saber de Roberto, 5 años menor, con quién no podía compartir ni los amigos, ni los juegos, ni el colegio. Les digo:

— Roberto ahora está solo y excluido como cuando era chico

y se quedaba solo, asustado ¡como ahora que no se mete en la conversación aunque parece estar muy atenta a ella.

Luis agrega a mi señalamiento: —Sí, se ponía muy mal cuando me iba al colegio; le daba como un ataque de desesperación, se ahogaba, se ponía morado. Me parecía que se iba a morir cuando se ponía así. Enrique aprueba y Roberto sigue en su mutismo. Les pregunto desde cuándo Roberto está así.

Me cuentan que en los últimos cinco años ha sufrido varios accesos similares al actual pero las crisis se han agudizado en su peligrosidad. Tuvo cuatro internaciones en clínicas psiquiátricas con tratamientos biológicos de insulina y electroshocks. El primer episodio hace 5 años fue con motivo de un "exceso de trabajo". Roberto se había peleado con Enrique en el taller que tenía la familia y el padre le dijo que debería irse del taller. Roberto entonces se fue a instalar en otra ciudad lejos de la familia y fue este su primer intento en la vida de alejarse del hogar. "Trabajaba 20 horas por día y desde ese episodio, desde esa primera crisis no puede trabajar más".

En un momento de la entrevista en que hablamos de los amigos de Roberto se enoja e intenta golpearme. Saliendo de su mutismo me grita que si me encuentra por la calle me va a matar.

La concepción de síntoma como expresión de una transacción intrapsíquica (impulso y defensa) se complica y se enriquece en la medida que ha ido derivando hacia el concepto de que el síntoma es la resultante de una multiplicidad de líneas de fuerza psíquica que se conjugan en el individuo en tanto participa de su grupo primario y de otros grupos sociales. Así, no buscaremos la esquizofrenia sólo en el esquizofrénico. El hombre es él y su circunstancia. La búsqueda se orienta hacia la interacción de la persona y del medio.

Voy a seguir exponiendo algunas circunstancias y episodios del ámbito familiar que tienen relación sincrónica con los brotes o crisis de Roberto.

... Toda la familia trae al niño y lo coloca sobre el

piso de la sala de la casa de Fanni...

Después de las primeras sesiones en las que estaba ausente luego de aquella vez que me amenazara de muerte, Roberto, convenientemente medicado, y con su familia en tratamiento conmigo, comenzó a asistir a las sesiones. Mejoró rápidamente de su crisis, dejó de estar deprimido, de vomitar, pudo empezar a comer bien, fue asumiendo su carácter una extraña bonhomía. Esto se comenzó a notar francamente apenas transcurridos unos treinta días de comenzado el tratamiento. Unos meses después inició su terapia individual.

... Los miembros del pueblo sabio procrean oralmente
cuando la mujer come los piojos del varón...

Luis cuenta:

— Nuestra madre era una mujer muy nerviosa. Había guerra y tenía miedo que nos alejáramos de casa. Cuando bombardeaban nos acostaba a los tres en la cama junto a ella; decía que si caía una bomba, nos salváramos o nos muriéramos, todos íbamos a estar juntos.

Esta imagen de la madre abrazada a sus hijos en la cama en ausencia del padre frente al peligro de las bombas es un modelo de inseparabilidad simbiótica: con mamá todo, el amor, la seguridad, el alimento, sin mamá: el caos y la muerte. Mamá y la cama significando el caos y la muerte cuando no está el padre para calmar la ansiedad materna, ansiedad generada por reales circunstancias traumáticas, que esa mujer tuvo que vivir a lo largo de su existencia.

Desde sus primeras ideas sobre el Complejo de Edipo a fines del siglo pasado, Freud enuncia elementos psicológicos importantes que nos permitirán entender estructuras normales y patológicas en el grupo familiar. Explica que existen dos causalidades que influyen o confluyen para determinar la elaboración total de dicho Complejo y su posterior naufragio o disolución: junto a la filogénica, en que el Edipo habrá de desaparecer conforme a una trayectoria predeterminada, sitúa la ontogénica, constituida por

sucesos causales como el nacimiento de hermanos, el rechazo de los padres, etc. La Familia, instituida al amparo de esa ley universal en todas las culturas que es la prohibición del incesto, es testigo y constructora de dichos caminos filo y ontogénicos en sus miembros.

Pienso que la ansiedad de la madre, de la que Roberto fue presa y objeto a lo largo de su vida, fue decisiva para sus regresiones. Bowen nos habla de la simbiosis madre-hijo, desde la que el crecimiento del bebé implica una de las mayores amenazas que pueda sentir la madre, desencadenando en la madre narcisista un aumento de exigencias y amenazas de retaliación el pasaje de un nivel al otro del desarrollo. O como esta madre muy a menudo proyecta en el niño su propio sentimiento de inadecuación e invalidez dedicándose entonces a cuidarlo no por sí mismo sino por la imagen de sí misma que proyectó en él.

— Veo una anciana sentada... que desea algo malo para otra mujer.

Rosa, la madre de Roberto, tuvo que convivir y compartir su casa con la suegra largos años hasta que ésta murió de arteriosclerosis senil poco antes de emigrar la familia a la Argentina. Enrique era el preferido de esa abuela. Cuando ella se iba de visita a la casa de sus otros hijos, se lo llevaba consigo.

Así vemos que el recuerdo de Enrique (ver la primera entrevista) de que se iba de la casa porque tenía sus propios intereses afuera, lejos de los hermanos, es un recuerdo encubridor del hecho que el mismo era un interés propio de la abuela, opuesto al de su madre, recuerdo encubridor representativo del conflicto entre la madre y la abuela. La madre pagaba entregando a Enrique y a su intimidad con el padre el haber tomado el hijo a su suegra. Consecuentemente además se aferraba a Roberto. Por su parte Luis el hijo del medio, logra unirse al padre; es el único que tiene estudios superiores y el único que parece haber escapado a las luchas por la posesión de los hijos que se libraron entre las dos mujeres del hogar.

Roberto hacía con Luis el mismo cuadro de desesperación y rabia que su mamá reprimía cuando la abuela se llevaba al nieto o

cuando el padre se iba. Además, Roberto, unido a su madre hacía como el padre que nunca se pudo separar de la suya. La muerte de la abuela coincidentemente con otras pérdidas de bienes materiales, de amigos, desencadena en el padre de Roberto una fuerte depresión, estado en que emigra. Roberto poco tiempo después a raíz de ser despedido por el padre del taller donde trabajaba hace su brote de esquizofrenia...

“Los miembros del pueblo sabio tienen la estatura de un niño pequeño. Siempre están en espíritu...”

Freud nos enseña que los delirios “se cocinan” con fragmentos de la realidad del pasado.

En la familia se murieron antes que naciera Roberto varios hijos, entre ellos uno también llamado Roberto, fallecido a los ocho años de edad poco antes de nacer el segundo Roberto. El episodio de su muerte, según el relato de la madre, es penoso y conmovedor: el niño había enfermado y cuando el padre por la guerra tuvo que irse de la casa comenzó a rechazar el alimento. Cuando querían darle de comer les repetía que hasta que el padre no volviera no iba a comer; lo que lograban meterle en la boca lo vomitaba y así murió “porque papá no pudo regresar a tiempo”. Años más tarde, durante los brotes, Roberto no come, vomita todo, y así adelgaza alarmantemente. En la mitología familiar ha quedado impresa esta terrible historia, y el padre ha quedado prisionero del mito intensamente culpógeno.

Los hijos tienen su destino fijado por los padres ya desde su concepción cuando no antes. El mismo nombre, recibido como un encargo de ser el reemplazo como una nueva edición, es demostrativo del fallido intento de elaborar el duelo. Un manejo narcisista del hijo tomado como cosa que influye sobre su identidad: más que un “tendrás que ser como soy” hay un “tendrás que ser lo que yo quiero que seas”. J. García Badaracco dice: “Muchas veces antes de nacer los hijos representan objetos internos muy prefijados y cristalizados, idealizados dentro del mundo interno de los padres... el hijo debe cumplir el rol asignado y al que se le exigen realizaciones particulares fijadas”. Lewis B. Hill “(citado por Lyman Wynne y otros)”.

un número de casos en que el rol que se esperaba del hijo quedaba simbólicamente representado en la elección de su nombre. En la vida posterior el hijo nunca parecía poder dejar de lado esta temprana asignación del rol.

Hemos visto las reacciones que tenía Roberto cada vez que su hermano Luis se iba al colegio: esos ataques debían tener relación con el conflicto entre la madre y la abuela, y con la sensación de muerte que habían implicado para la familia los alejamientos del padre. Las relaciones humanas están teñidas de afecto y de angustia y es principalmente a través de ellas expresadas en lo metacomunicado, que los seres humanos transmiten el mensaje de sus impulsos. Lo primero que advierte el bebé, lo que decodifica, no es la palabra de los padres sino el afecto, la angustia que la acompaña. El es el forzoso testigo selectivo (ya que en un principio la palabra no es inteligible para él), de esa ecuación entre impulso y represión que le plantean los padres, cuyo resultado se le hace evidente a través de lo metacomunicado. La madre, como tantas otras madres en su lugar, hizo partícipe a sus hijos de las angustias por la guerra y la separación del compañero. Pudimos ver en las sesiones que las sucesivas separaciones, desde entonces y hasta nuestros días, provocaron a la madre picos de intensa ansiedad y serios cuadros hipocóndricos.

Fanni realiza una danza ritual...

Muchas veces en T P suceden las cosas como si se hablara en idioma desconocido. Entonces la manera de traducir es utilizar recursos de acción, utilizar la expresión a través de gestos, movimientos. En familias conflictivas no se saben expresar sentimientos ni de amor ni de enojo. Es como si tuvieran escotomas para ellos. Con la familia de Roberto me sirvió que Pedro y sus hijos supieran jugar a las cartas. Entonces, hacerles jugar partidos en sesión nos permitió poner en evidencia fuertes sentimientos de rivalidad, odios, envidias.

En la TF la transferencia está en acto, plasmada en el mosaico de vínculos que se despliega en la sesión. Enunciar los psicodinámicos hallados en un adecuado “timing” es una táctica terapéutica que permite movilizar no ya al paciente síntoma, sino a

los sistemas totales vigentes comprometidos en la estructuración del síntoma. El "timming" está dado por múltiples factores a tener en cuenta, básicamente el grado de madurez de los miembros, sobre todo de los padres y abuelos, a quienes les va a ser útil comprender como se estructuró el síntoma, porque estarán entonces en las mejores condiciones de aceptar las influencias de sus propias series complementarias, sus propias privaciones en la infancia, las carencias de que fueron objeto por sus propios ancestros, entenderse como eslabones de la cadena, liberándose entonces de la culpa que por dicha responsabilidad les cabe por sus hijos y por sí mismos, responsabilidad que muchas veces inmoviliza la capacidad de pensar.

Esta familia estaba muy aislada como grupo social. Igualmente en el sentido de la economía familiar, tenían un trabajo poco remunerativo. Trabajaban todos los hermanos y los padres en un cuarto pequeño, poco aireado y sin luz natural muchas horas del día, desde que habían llegado al país hacía 15 años. Los padres no frecuentaban otras amistades que un tío materno y su familia. Y los hermanos de Roberto iban a un club muy de tarde en tarde. Luis decía que había ido a ese club hasta que conoció a su mujer, y después no volvió más.

Es decir, la estereotipia, el encierro y el autismo mostrados por Roberto eran cualidades de todo el GF. Un día, en una sesión en que jugaban a las cartas, el padre comenzó a contar de sus costumbres de antes de la guerra, en que solía pasarse muchas horas en el boliche de su pueblo jugando con los amigos. La sesión terminó cantando viejas canciones del país. Esto fue el punto de partida para largas conversaciones a las que asistía Roberto muy interesado en las cuales pensaron entre otras cosas, las primeras actividades comerciales que luego les llevarían a la prosperidad.

Con la introducción de una modalidad lúdica olvidada, nuestro rol terapéutico se completaba funcionando como parteros de aspiraciones, esperanzas ahogadas por muchos años de pérdidas masivas de objetos que llenaron de pesimismo a esta familia de inmigrantes.

Fanni aspira el dolor del pequeño... y luego se va al fondo de la sala a vomitar.

La capacidad para hacer transferencias es una modalidad de la interacción humana. Se puede observar con mayor comodidad en el tratamiento psicoanalítico del GF, cuando más que en él se favorece la regresión.

En la sesión de TF por la presión de las transferencias continuamente se mezcla fantasía con realidad. Lo subjetivo con lo objetivo. Y las subjetividades presionan, influyéndose entre sí entre los miembros del GF.

Una misión del TF es distinguir la realidad. Discriminar esas distintas subjetividades en juego, comprender en su intimidad los sentimientos y los fenómenos transferenciales que se dan en los familiares entre sí, y los que surgen entre los familiares y el TF. Todos estos sentimientos cruzados generan una intrincada distorsión de la realidad, una red transferencial y contratransferencial en la que pueden quedar presos no solamente los familiares sino también el TF por la complejidad del campo intersubjetivo. La realidad que él distinga no será otra cosa que "su" realidad.

Con Roberto, su Terapeuta Individual se incorpora periódicamente a las sesiones del GF actuando en coterapia conmigo. Al término de cada sesión practicamos evaluaciones de la marcha del tratamiento individual y familiar.

Cuando estuvo internado —Roberto requirió hasta ahora dos internaciones— se realizaron reuniones del equipo terapéutico en el que intervino el personal de la clínica. Este es el lugar en que los distintos agentes del tratamiento se encuentran para intercambiar información de la que son portadores, no solamente con sus conocimientos conscientes sino con sus impresiones y percepciones inconscientes que se analizan en la reunión del equipo. Esta reunión sirve para evaluar la posición contratransferencial en que cada uno ha quedado, y consecuentemente integrar las distintas partes disociadas del grupo familiar y del paciente de las que no pudimos hacer cargo. La coterapia y las tareas de control y evaluación del equipo van en pos de una indispensable complementación de los agentes comprometidos en el tratamiento de pacientes psicóticos y de su GF, por las tendencias disociadoras generadas en las complicidades inconscientes interactuantes que sabotean la tarea como modalidad resistencial frente al proceso de la terapia.

Alfredo Canevaro señala que cuando el grupo familiar se encuentra en dependencia con el T. uno de los fenómenos que surgen es la transferencia idealizada; más intensa cuanto más dependiente esté el grupo del T.

Luego la necesidad de desidealizar al T. ha de convertirse por momentos en una de las fases más importantes del tratamiento.

Según dice A.C.: "El peligro surge cuando llega el momento de la desidealización, momento generador de "acting outs graves, si no se tiene en cuenta que la transferencia idealizada cubre vacíos emocionales y dolorosos. Por eso el T. tiene que acompañar al GF. como una madre nutricia a su bebé"

Este grupo familiar, desde el primer momento adquirió intensa dependencia hacia el T. Ella fue necesaria, diría indispensable, para promover los importantes cambios que modificaron el rostro de este grupo tan pesimista, tan autista. Así como la estrecha dependencia entre el bebé y la madre se hace en un momento necesaria para el buen crecimiento del bebé, dependencia que resuelve en parte mediante objetos transicionales, el GF debe ser también una estructura transicional imprescindible para el crecimiento de sus individuos, para el pasaje de la endogamia a la exogamia y es una necesidad de la situación terapéutica la dependencia del GF, pero comprendida como una estructura transicional, permanentemente en elaboración.

Veamos este ejemplo:

Roberto trae a una sesión un aumento de honorarios pedido por su TI. Se lo discute encarnizadamente. Se lo rechaza. En cambio a mí, TF, me aumentaban los honorarios sin yo pedirlo, indexándome los. Pudo mostrarles que era una manera de retribuirme cuánto de bien sentían que la TF les hacía... pero también, sentir tan discutibles los honorarios del TI era una manera inconsciente de coartar el crecimiento individual de Roberto.

La terapia debe aspirar a promover las indispensables experiencias compartidas que van a llenar los vacíos dejados por carencias ancestrales favoreciendo la elaboración de los duelos por los que cada familia debe pasar; esta es la tarea que nos espera a los modernos "brujos" que transitamos por los caminos del psicoanálisis y de la terapéutica del G.F.

Sincronismos significativos

Roberto tuvo varias recurrencias, durante las cuales, las cosas se daban de tal manera que invariablemente parecían favorecer la posición de determinados miembros de la familia. ¿Era una forma de manejo familiar?

La primera recurrencia fue cuando se iba a ir de viaje su hermano Luis. Mejoró inmediatamente que éste volvió del viaje. Este brote también pudo ser capeado sin internación. La segunda fue con motivo del empeoramiento de las relaciones conyugales de Enrique su hermano mayor, quién estuvo a punto de separarse de su mujer y partir al exterior donde quería rehacer una nueva vida. La crisis de Roberto le hizo quedarse en el país y arreglarse con su esposa. La tercera fue con motivo de que Enrique había decidido instalarse en el exterior con su mujer. Luego de un tiempo las cosas le fueron mal así que deseaba volver, así lo escribía en sus cartas a la familia. Esta vez la crisis fue una vía regia para que Enrique fuera acogido como el hijo pródigo.

Se podría comprender todo esto, el empeoramiento de las relaciones conyugales de Enrique y su posterior decisión de instalarse con su mujer en el exterior, más la psicotización de Roberto, como una especie de estampida de varones para dejar solo a Luis que empezó a analizarse y le dió un fuerte impulso a los negocios de la familia: lo dejaron solo, para no obstaculizar sus logros... Luis por su lado pudo descubrir cómo sus ingentes capacidades estaban comprometidas en conflictos con los hermanos. ¿Coincidencias?. ¿Facilitación inconciente de la familia?. ¿Resultados de la TF?.

Cuando muere la abuela paterna la familia emigra a la Argentina y la madre vive por primera vez sola con su marido y sus hijos. Hasta aquí, Roberto es un muchacho feliz que trabaja junto con sus hermanos y la madre también es quizá más feliz que nunca, en su hogar, y además contribuyendo con su esfuerzo a la par de todos los hombres de la casa. Pero algo interrumpe la atemporalidad de la situación para ella. El casamiento de Enrique la transforma de madre en suegra y más tarde con los hijos que tiene Enrique, en varias veces abuela; por entonces su propia madre fallece casi centenaria en Italia. Por entonces sobreviene su menopausia.

Se cierne sobre ella el fantasma de su suegra. ¿Reencarnaría ella también el destino de locura y muerte que deparara a la abuela su arteriosclerosis?.

Contemporáneamente, Roberto se pelea con Enrique y se aleja del hogar y posteriormente, se psicotiza. Se psicotiza para deshacer lo que había hecho Enrique con su casamiento?.

Aparecen dos diadas que será necesario atender en el curso de la TF. **Roberto y la madre:** Es necesario que esté al lado de su madre para que nada cambie para ella. **El padre y la madre:** "No te puedes ir y dejarme sola (como con el primer Roberto) porque si no se muere nuestro hijo". Roberto está preso de esta situación desde su nacimiento. Y su historia revela un deficiente desarrollo yoico, dificultades en la escuela, carencia de amistades, etc., que apuntan hacia una psicosis infantil larvada.

Todo nos hace pensar en una constelación patognomónica familiar en que el hijo menor se psicotiza y los padres quedan adheridos a él, el hijo de la vejez en una situación regresiva atemporal donde para siempre es el bebé de la familia, no pudiendo establecer con él la interacción que le permita crecer, como durmiendo un sueño interminable en la cuna. En esa cuna en que los bebés sueñan las fantasías de la madre, tiemblan con sus terrores y sonríen con sus alegrías... Desde allí vigila los intentos de crecimiento familiar; desde el vientre de su madre, como diría Bion..., la misma madre que vigila su propio crecimiento.

Con todo, a lo largo del tratamiento las crisis, aunque se reproducían, eran cada vez más leves. Dice García Badaracco: "La regresión no es necesariamente patológica, lo patológico es la esteireotipia". Las regresiones fueron disminuyendo en sus componentes paranoides y se hicieron más depresivas. Concordando con los conceptos del Proceso Terapéutico de JGB el paciente "iba llegando a un estado de depresión melancoloides en que despojado de sus componentes omnipotentes le quedaba un sentimiento de vacío, de inermidad, como una gran impotencia y progresiva conciencia de sus carencias afectivas.

... tienen la estatura de un niño pequeño... son adultos a los seis meses de edad y gozan de inmortalidad.

La fuerza de Roberto está invertida en los sistemas familiares que obran como cerrojos afectivos para su crecimiento. Las identificaciones son como los cauces naturales por donde fluye el afecto. Y todos esos son ríos que van a dar a la mar... como diría el poeta; a la madre como diría el TF.

Se diría que Roberto ha estado tan ocupado con su madre, que no ha podido ocuparse de sí mismo. La familia que debe ser un lugar para el crecimiento e independencia se fagocita la capacidad creativa, la libido de sus miembros y todos quedan fijados, fosilizados. El tiempo se detiene y cuando algo amenaza cambiar, tiemblan las estructuras. Es difícil decir si es la familia la que se fagocita a Roberto, o Roberto que se fagocita la familia. Todos constituyen el sistema paralizado-paralizante, donde la tendencia básica es suspender el tiempo. Cuando la Esfinge le pregunta a Edipo: —Qué ser tiene cuatro pies, dos pies y cuántos más tiene es más débil? Esta pregunta a mi entender están condensando otra: —Cuál es la condición humana, el enigma esencial en la vida del hombre, cuyo conocimiento lo diferencia de los animales? Y cuando Edipo responde a la Esfinge le dice que él conoce que el hombre está sometido al paso del tiempo. El tiempo lo hará crecer, madurar y morir. Es una ley inquebrantable; desconocerla es hacerse merecedor de la muerte, es ser un muerto en vida. La leyenda yurok así, viene al encuentro del oculto significado de la pregunta de la Esfinge, cuyo desconocimiento condena a muerte. La esquizofrenia es en sí una renuncia a la vida, a la propia vida, deteniéndose el paso del tiempo para el niño que "a los seis meses no crece más, es adulto y goza de inmortalidad", inmortalizando a la madre y preservándolo de la sensación de envejecer y de morir; pero entonces la madre se hace Esfinge y muere como continente apto para el crecimiento de su niño que ya no ha de hacerse hombre.

PHILIPPE CAILLE

Médico Director del Centro de Asistencia Familiar de Sagena, Drbaksgt 1. Oslo, 4 (Noruega).

Traducción: Lic. Stella M. Molina.

El empleo de la expresión "psicopatología de la familia" implica para nosotros que es definido como enfermo todo el grupo familiar. El hecho de que un miembro de la familia presente un síntoma psiquiátrico es aprovechado por la familia para tomar contacto con nosotros, sin que por eso el portador del síntoma deba ser colocado en una posición particular. De acuerdo al pensamiento sistémico, la aparición de un estado psicótico en una familia a menudo es el resultado de un sistema familiar cerrado y rígido en cuyo interior todos los implicados sufren en medida igualmente intensa aunque de forma distinta. En consecuencia la situación no puede mejorar para nadie sin que todos sean aliviados por un cambio en las reglas que organizan su relación interna.

Encuentro con una familia

Cuatro individuos están presentes, una familia de tres personas y el médico. El padre tiene 50 años. Es un vigoroso agricultor, prudente y sobrio en discursos y en gestos. La madre es maestra.

(1) Texto originalmente publicado en noruego en la revista "Tidsskrift for den Norske laegeforening", n.31, 1977, pags. 1621 a 1624, publicado con permiso del autor.

Philippe Caillé

Lleva sus 46 años sin debilidad, se viste sin afectación y se expresa de manera concisa y directa. La hija, de 25 años, ligeramente obesa, parece un poco agitada y se expresa febrilmente. Su curriculum educacional comprende los estudios primarios y un curso comercial. Sin embargo estos últimos años estuvo en varias ocasiones imposibilitada por episodios psicóticos que la condujeron a internaciones prolongadas en institutos psiquiátricos. El rasgo más notable de su sintomatología fué la idea de ser una actriz célebre. Vive por el momento con sus padres y trabaja durante el día en un "taller de entrenamiento industrial". Desde el comienzo de la entrevista ella expone su intención de solicitar la admisión a la Escuela Teatral de Oslo y su esperanza de poder luego obtener un papel en una película. Por otra parte es fácil notar el antagonismo entre los padres. La madre no se dirige nunca directamente al padre. Le informa de entrada al médico que el padre no la ayudó jamás, no mostró nunca interés verdadero ni por ella, ni por su hija. Por un egoísmo muy arraigado, él siempre tuvo una actitud negativa y crítica con respecto a ellas. El padre asegura al médico que es inocente y que desea sinceramente ayudar a su hija y a su esposa. Le dice a ésta en un tono lastimero y triste que ella lo rechaza constantemente y no lo comprende aunque él diga las cosas con la mejor intención. La esposa no responde, pero sonríe con desprecio. La hija interviene exclamando que el padre le hace perder el valor y trata de hacerle penosa la vida.

Muestra luego los formularios de admisión que le entregaron en la Escuela Teatral, donde consta que se exige como mínimo los estudios secundarios, pero ella espera con optimismo poder obtener una dispensa. Comienza a hablar encendidamente de su intención de seguir la carrera de actriz cuando haya terminado su educación.

El médico requiere la opinión de los padres. El padre piensa que todo eso es quimérico. Su hija no tiene ni estudios secundarios ni experiencia escénica. El puede por medio de relaciones conseguirle un empleo en un banco local, que le significaría seguridad en el empleo así como posibilidades de progreso. La madre opina que únicamente cuenta que la hija tenga una perspectiva que le dé fortaleza y ánimo. La hija exclama que odia al padre quién le quita la fe en sí misma.

Más tarde en el curso de la conversación, la madre desliza que un trabajo como empaquetadora o una ocupación semejante convendría quizás a la paciente. El padre, la madre y el médico se ponen de acuerdo en que el trabajo es importante para ella y que es de esperar que continuará frecuentando por el momento el "taller de entrenamiento industrial". Sus rendimientos han mejorado últimamente y cabe suponer que conservará esta actitud positiva.

Luego de la entrevista y camino de la casa, la hija se pone cada vez más confusa y agresiva. Debe ser traída de nuevo al Servicio de Psiquiatría donde queda internada una vez más.

Cómo entender que vivimos?

La mayoría de nosotros somos concientes del hecho que lo que percibimos está teñido siempre por nuestras representaciones internas y por teorías sobre el modo en que las cosas se organizan. Si los acontecimientos corresponden a lo que esperábamos, si nuestras intervenciones dan el resultado aguardado, suponemos que nuestra teoría era correcta. En el caso contrario, buscamos un nuevo modelo explicativo que se adapte mejor a los problemas planteados y tenga mejores posibilidades de resolverlos.

Desde 1950 en adelante varios sistemas de referencia hicieron su aparición en el campo de la psiquiatría. ¿Qué hemos de descubrir en este ejemplo clínico? ¿Una enferma prepsicótica con un vacilante yo que causa la discordia entre sus desdichados padres y vuelve difícil la relación conyugal? ¿Una poderosa madre esquizofrenógena, una figura paterna apática y periférica y su producto común, un individuo psicótico cuya débil identidad se compensa con representaciones maníacas? ¿O bien, padre, madre e hija como desdichados participantes de un sistema humano destructivo? Las reglas despiadadas de la familia aseguran así cohesión y continuidad, pero no permiten ni desarrollo individual, ni expresión de necesidades propias. El sufrimiento individual se manifiesta de diversas maneras. Llamamos comportamiento psicótico a una de las expresiones de sufrimiento.

La experiencia de nuestro trabajo fuera del medio hospitalario con grandes posibilidades de contacto con el entorno del enfermo

nos hace pensar que ese último marco teórico que toma como unidad de observación a la familia o a todo otro grupo natural humano presenta un gran número de ventajas. No queremos negar de ningún modo la justificación del empleo de otros modelos en situaciones de trabajo diferentes. (3)

Teoría de los sistemas

El pensamiento básico es que todo sistema, sea tanto de orden animado como inanimado, es más que la suma de sus elementos y no puede en consecuencia ser explicado por el análisis de cada uno de sus componentes (2). La familia que hemos presentado no puede ser comprendida por el análisis psicológico únicamente del padre, de la madre o de la hija. Del mismo modo la naturaleza particular de un valle tampoco puede ser aprehendida por el estudio por separado del río, de la población de la flora, de la industria local, etc. Lo que caracteriza al sistema es la relación entre los componentes. Nuestro modo de pensar tradicional basado en la reducción, el análisis, la deducción, debe ser dejado de lado en provecho de una comprensión ecológica, inductiva que tome en consideración la totalidad y las reglas que la organizan.

El equilibrio del sistema es su homeostasis. Esta es muy estable en los sistemas físicos en los que lleva precisamente el nombre de equilibrio. En los sistemas biológicos, como la regulación de la glucemia, la homeostasis es más lábil. La glucemia mostrará en el curso del día algunas desviaciones moderadas respecto de la media óptima. En los sistemas humanos, el punto de equilibrio se modifica no sólo porque la composición del grupo se modifique sino también debido a que el hombre tiene un ciclo de vida que implica cambios en la aptitud física, la capacidad y la personalidad.

Una manera de describir un sistema humano es esclareciendo las reglas que ordenan la relación interna entre las partes. Esas reglas son el fundamento de la homeostasis del sistema. Están basadas en negociaciones sutiles en el plano no-verbal de las que a menudo no tienen conciencia los interesados. Este fenómeno se puede observar fácilmente en un grupo en formación. Poco a poco todos pueden llegar a predecir dónde va a sentarse cada uno, quién hará propuestas audaces, quién esgrimirá la prudencia. Las reglas

alcanzan a todos. Ninguno de los partícipes puede ser objetivamente señalado como el responsable pues todos, de una manera o de otra, contribuyeron a su formación.

Sin embargo, en ciertos casos puede parecer que un miembro de la familia, por ejemplo la madre de nuestro ejemplo clínico, impone las reglas a la familia. Según el pensamiento sistémico, se trata de una regla familiar. En realidad ninguno de los participantes tiene el dominio unilateral de las reglas. Todos participan en su elaboración y en su mantenimiento. Los miembros del grupo familiar son elementos de un círculo relacional cerrado. La pertenencia sistémica influye en el mismo grado a todos en cuanto a sus posibilidades de desarrollo propio y de individualización. Por el contrario, el modo en que se manifiesta el sufrimiento individual en un sistema disfuncional es muy variable entre los participantes.

La repetición de secuencias de comportamiento o de comunicación da al observador la posibilidad de comprender las reglas del sistema. (1). La madre se dirige al médico enarbolando una acusación contra el padre, éste trata de excusarse con respecto a la madre, la hija interviene con sospechas hacia el padre. Si tal secuencia se repite suficientemente, testimonia sobre una regla de la que la familia no tiene la menor conciencia. Menos aún podrían descubrirla o modificarla. Por el contrario una persona neutra puede estimular la capacidad del sistema para cambios internos y contribuir a que las reglas se modifiquen.

Para alcanzar esto hay que abandonar el razonamiento tradicional dicotomizador que termina clasificando toda solución como justa o falsa, buena o mala. Se debe aceptar hasta las consecuencias más profundas la significación paradójica de los fenómenos homeostáticos en el interior de los sistemas humanos. La homeostasis asegura pertenencia, seguridad, previsibilidad, pero implica al mismo tiempo una restricción, y hasta un abandono, de ciertas aptitudes individuales auténticas. Toda ligadura emocional a otro ser humano tiene de la misma manera aspectos positivos y negativos a la vez. La solicitud de los padres hacia el hijo es una seguridad al mismo tiempo que una sujeción. La autoridad de un padre puede ser considerada tanto bajo su aspecto educativo como bajo el represivo. La mayoría de nosotros tenemos una comprensión intuitiva de esta doble naturaleza de las relaciones humanas. Poner el acento

sobre uno de los aspectos de la relación nos lleva automáticamente a pensar en el aspecto opuesto. Cuando ciertos padres insisten en su preocupación de impedir que el hijo sea expuesto a toda forma de peligro, la importancia dada al aspecto de la protección puede hacernos preguntar si el hijo no corre el riesgo de ser demasiado controlado o inhibido. Por el contrario, si los padres están siempre ansiosamente preocupados por dar al hijo suficiente libertad e independencia, será cuestión de saber si están suficientemente seguros de asegurarle una protección y un control adecuados.

La estructura y las reglas de un sistema funcional son vividos como más o menos satisfactorias, jamás como perfectas o totalmente inaceptables. Se producen períodos de transición en que los participantes deben redefinir su relación interna, y así cambiar las reglas del sistema. Son seguidos por períodos en que la estructura es vivida como satisfactoria y capaz de brindar sensación de seguridad y estabilidad. A título de ejemplo podemos mencionar que una familia habitualmente atraviesa tres períodos de crisis. Los dos primeros son el pasaje del estado de pareja sin hijos al de familia con hijos pequeños y el siguiente es el pasaje al estadio de la familia conformada por adultos y adolescentes. El tercer momento de crisis se produce a menudo cuando los hijos dejan definitivamente el hogar y los padres deben restablecer una relación diádica. Cada familia tiene además su propia historia con sus crisis propias que también hacen necesaria una modificación de la relación interna. (7)

Bien diferente es la dinámica interna de los sistemas disfuncionales. En ellos el sufrimiento individual es pronunciado y el sistema está por eso expuesto al peligro de su disolución. En respuesta a esta amenaza se forman importantes automatismos homeostáticos. Todo cambio es considerado como una amenaza. Se hace lo imposible para que las reglas sean inalterables y eternas. La familia se comporta como si viviera en una vieja casa en ruinas donde el hecho de cambiar un libro de lugar podría ser suficiente para que se desplomara el techo. La necesidad de negociar la naturaleza de la relación interna debe ser negada. Y para eso hace falta borrar las necesidades individuales de cada uno. Los sentimientos que los participantes tienen los unos hacia los otros son definidos de una vez por todas como buenos o malos. Las alianzas y las opo-

siones parecen definitivas y eternas. Se constituye así un círculo vicioso. El sufrimiento individual aumenta, y paralelamente se acentúan los mecanismos homeostáticos. En los casos extremos, la existencia de conflictos importantes, por ejemplo entre el padre y la madre será considerada como una característica estable, un rasgo particular original del perfil familiar. Esos conflictos no serán jamás relacionados con la existencia de síntomas en uno o varios de los miembros del grupo familiar.

Tales deficiencias en el pensamiento lógico son necesarias y caracterizan al sistema disfuncional o cerrado. Se puede comprender cada palabra pronunciada en el curso de la conversación, pero puede ser difícil otorgar significado a lo que se ha dicho. Esto puede deberse al bajo nivel de precisión en el modo de expresión, a un antagonismo entre el contenido verbal y el no-verbal, o simplemente al hecho de que el que habla se contradice abiertamente. El comportamiento hogareño debe regirse por un cierto número de complejos rituales. El que intenta oponerse a alguno es considerado agresivo y maligno, o aturdido y enfermo. A menudo se identifica de un modo mágico a los diferentes miembros de la familia con diversos ascendientes más o menos alejados. (4) La cohesión familiar es puesta a prueba por tradiciones complicadas en cuya observancia todos deben participar. Sin embargo tal sistema a menudo tiene necesidad de un "traidor" o de un "chivo emisario" que enfrente esta complicada legislación. El hecho de que los participantes se sientan a pesar de todo ansiosos e insatisfechos recibe así una explicación. Entonces el comportamiento del disidente es lo que impide que la existencia de cada uno sea feliz y serena.

El sistema "abierto" o funcional se caracteriza en contraste por tener reglas poco numerosas, fácilmente comprensibles y con fundamento lógico. Las expresiones de opinión son claras y abiertas. Se reconocen diferencias individuales de gusto y de necesidades. Las reacciones emocionales son toleradas. La familia es receptiva en cuanto a la información lógica. La adquisición de conocimientos y las recomendaciones podrán eventualmente provocar un cambio en las reglas y en los roles.

Esta presentación dicotomizadora en sistemas "abiertos" y "cerrado" seguramente resulta de una simplificación artificial, que se vuelve necesaria por el empleo del lenguaje cuya estructura es

Philippe Caillé

lineal y obliga al pensamiento, a la búsqueda de la relación causa-efecto y al análisis. En realidad no existe tal polarización sino solamente una diferencia de nivel entre función o disfunción. Este nivel varía también con el tiempo. Un grupo humano puede ser relativamente funcional en un determinado momento, relativamente disfuncional en otro.

Volvamos a nuestra familia

Ya estamos en situación de poder reconocer los rasgos característicos de un sistema cerrado.

La comunicación entre los participantes en el curso de la sesión se desarrolla según un modelo complicado e ilógico. No existe ninguna concordancia entre el rol que cada uno dice tener con respecto a los otros y el contenido actual de la conducta del interesado. La madre, de quién se supone que protege a la hija y es su verdadera aliada, la alienta en sus planes quiméricos. El padre, que es el "perseguidor" de la hija, le da de hecho consejos aceptables y le propone una ayuda concreta. La madre y la hija sostienen que el comportamiento del padre es una explicación suficiente de la desdicha familiar. La hija ha sido víctima de varios episodios psicóticos. En los sistemas cerrados, el sufrimiento individual se expresa a menudo por medio de síntomas psíquicos. Como es un modo de comunicación ambiguo es por eso mismo aceptable.

Cada uno tiene la convicción errónea de tener el control de la situación y de estar así protegido del riesgo de abandono de los otros dos. La madre tiene tanta fuerza y autoridad que nadie osará romper con ella. Nadie puede ser más conciliador y humilde que el padre, lo que le garantiza también aparentemente un lugar en la casa. En cuanto a la hija, su posición como intermediaria entre la madre y el padre es capital en tanto no existan relaciones directas entre ellos. ¿Qué pasaría si el vínculo entre los cónyuges diera muestras de mejorar? ¿Sería la hija definitivamente abandonada a sus propios recursos después de haber sido víctima de los conflictos conyugales durante 24 años? Con su mensaje psicótico ella advierte amenazadoramente: "Lo que ustedes esperan de mí sin duda hubiera sido razonable si yo hubiera sido vuestra hija."

Sin embargo yo no soy vuestra hija sino una actriz célebre. Hubiera podido ser vuestra hija si ustedes hubieran sido distintos". Para impedir que ese mensaje angustiante se exprese de un modo menos ambigüo, los padres deben mostrar signos de solicitud y devoción con respecto a su hija, quién recibe así una confirmación a su creencia de tener el control de la situación relacional.

Encontramos la misma ambigüedad en el pedido que la familia hace al terapeuta. Traen un problema, la hija enferma, y piden al médico que la cure del síntoma. Al mismo tiempo, el terapeuta está inhibido de aportar ningún cambio a la relación familiar pues ésta es definida como sin problemas, o si hay conflictos, éstos son definidos como sin solución. El terapeuta podría sentirse tentado de sugerir que el estado de la hija es el resultado de la mala relación entre los padres. Podría tratar de obtener que el padre y la madre traten de abordar las razones profundas que están en el origen de su desentendimiento. El resultado probable sería el abandono del tratamiento por la familia. En el mejor de los casos, la familia revelaría con sutiles muestras, aún fuera de las sesiones, su antagonismo y su escepticismo con respecto al terapeuta. La homeostasis del grupo sería así prioritaria de nuevo a expensas del sufrimiento individual y volvería imposible la tentativa de tratamiento. El problema sería entonces tratar de ayudar a semejante familia sin desencadenar reacciones homeostáticas indeseables.

¿Se puede cambiar un sistema cuando las reglas de éste se oponen a todo cambio? La respuesta debe ser tan paradójal como el requerimiento de la familia al terapeuta. Puede consistir en una "aceptación" de que nada en la relación familiar puede ser objeto de crítica, acompañada por el mandato de no efectuar por el momento ningún cambio (6). La madre debe continuar criticando al padre y alentando los planes de carrera cinematográfica de la hija. El padre debe continuar defendiendo su buena fe y dando buenos consejos a su hija aunque sepa que no serán seguidos. La hija debe continuar mostrando su animosidad contra el padre, manteniendo su alianza con la madre y reuniendo informaciones suplementarias sobre la carrera de artista. De este modo se evita infringir ninguna de las reglas del sistema aunque nos desplacemos hacia una modificación de las mismas. Si el sistema quiere mantener su ilusión de control integral, debe oponerse a las instrucciones del terapeuta y

entonces efectuar algunas modificaciones comportamentales. Por ejemplo la hija puede aceptar una proposición del padre y aliarse temporalmente con él. Si el sistema sigue por el contrario el mandato del terapeuta, se somete así a un control externo al sistema, lo que constituye de nuevo un cambio e implica posibilidades terapéuticas.

Principios terapéuticos

Debemos limitarnos aquí a algunos puntos principales de los que parten ciertas líneas de conducta que se deben respetar en intervenciones terapéuticas de esta clase. Naturalmente la estrategia terapéutica está siempre adaptada al grado de disfunción observando en la dinámica familiar. Lo que sigue concierne particularmente a los sistemas humanos de tipo cerrado a los que pertenecen entre otros la mayoría de las familias en que un miembro del grupo familiar presenta trastornos psíquicos graves, una enfermedad psicosomática o un comportamiento netamente asocial.

MANTENER EL CONTROL DE LA SITUACION TERAPEUTICA: El terapeuta debe abstenerse de toda forma de crítica o de juicio. Existe enorme angustia y sentimiento de culpabilidad en estas familias. El terapeuta se alía a las fuerzas homeostáticas que a pesar de todo han mantenido la familia íntegra. Aunque ciertas actitudes puedan parecer amenazantes o extrañas, el comportamiento de cada uno de los miembros del grupo familiar debe ser aceptado como el único posible y necesario en el momento presente. Los aspectos negativos de tales comportamientos son en efecto suficientemente aparentes para todos. Por el hecho de la dualidad intrínseca de la conducta humana que ya hemos mencionado, será suficiente que el terapeuta se concentre en los aspectos positivos de esos comportamientos y trate de valorarlos.

Por las mismas razones, se debe evitar toda prueba de fuerza con el sistema tratado. Los miembros de estos grupos dan mucha importancia a su poder sobre los otros. El terapeuta puede fácilmente caer en el juego. A menudo debe recordar que aunque, tenga un cierto conocimiento de los dinamismos familiares, todavía le

queda mucho por aprender sobre las familias, y de las familias. Si la evolución no es la que se esperaba, es lógico que lleve la entera responsabilidad. Si se espera de él que se produzca rápidamente un cambio determinado, no hará ningún daño a la familia si enuncia que no tiene por el momento ninguna posibilidad de satisfacer ese deseo.

EVITAR SER INCORPORADO POR EL SISTEMA FAMILIAR:

La experiencia nos enseña cuán fácil es ser influenciado por las reglas y las interacciones que aparecen en tales familias. Puede ser relativamente fácil evitar los peligros más aparentes como el de tomar partido o recibir una confidencia de un miembro de la familia para mantenerla en secreto. Un coterapeuta preferiblemente de sexo opuesto al propio puede ser una ayuda necesaria para no sucumbir a otras manipulaciones más sutiles, pero no menos eficaces, que son de hecho el modo relacional predominante en un sistema cerrado. Un observador ubicado detrás de un espejo unidireccional, protegido de esas influencias, podrá contribuir con observaciones inapreciables y proveer así la ayuda considerable de una supervisión en vivo.

TODO PROCEDER TERAPEUTICO DEBE SER SISTEMICO:

Como regla general, todos los miembros del grupo familiar deben participar del tratamiento. Los hijos muy pequeños no deben necesariamente estar presentes en cada sesión. En ciertos casos particulares puede ser necesario aceptar la ausencia de otros miembros de la familia durante ciertos períodos del tratamiento. Sin embargo es imperioso, si no indispensable, reunir a todos al menos una vez en una sesión.

En todo caso, las evaluaciones e intervenciones del terapeuta deben ser sistémicas, tomando entonces en consideración a todos los miembros del grupo familiar estén presentes en sesión o no. Si se describe el comportamiento de alguno de ellos, será también necesario comentar sin ninguna excepción la actitud de cada uno de los otros con respecto al interesado. Si se da una tarea a cumplir a la familia, todos deben tener una parte determinada en lo que debe ser efectuado. Esto puede obtenerse de manera práctica enviando una carta a la familia que se leerá en voz alta cuando estén todos reunidos.

LAS INTERVENCIONES TERAPEUTICAS INTENTAN LIBERAR A LA FAMILIA DE MECANISMOS HOMEOSTATICOS NEFASTOS: NO SON NORMATIVAS: Ya hemos destacado que declaraciones sobre lo que debe ser considerado como normal o deseable no harían sino volver aún más precaria la situación de la familia. Por el contrario el terapeuta debe poner el acento sobre la necesidad de adquirir un conocimiento profundo de la familia que desea ayudar. Las defensas sistémicas se modifican como resultado del sostén paradójico dado por el terapeuta a los elementos estáticos de la dinámica sistémica. La familia llegará poco a poco a proponer cambios que el terapeuta recibirá con un escepticismo no disimulado.

Las leyes sistémicas explican que la familia sea empujada en su propio nombre a un cambio cuando el terapeuta legaliza la continuación del status quo. El terapeuta puede también hacer aparecer la parte de angustia y de frustración presente en cada uno creando así una duda con respecto al hecho de que uno esté más enfermo o perturbado que otro. Poco a poco todos son ubicados de manera simétrica con respecto a un problema común.

Puede ser útil a menudo dar a la familia tareas concretas que puedan tener a la vez un valor simbólico y un valor de comunicación. Un ejemplo lo explicará mejor: Un padre y una madre traen su hija de 10 años a tratamiento. Se quejan de que su comportamiento se volvió difícil e incomprensible en la casa, acompañado además de un deterioro del rendimiento escolar. El terapeuta observa que los padres compiten abiertamente en lo que concierne a explicar lo que ocurre en la mente de la hija, y ésta raramente tiene la ocasión de decir una palabra. Expresa su comprensión por las inquietudes paternas y su interés por la información brindada. Luego concluye diciendo que los padres deben ayudarlo con información aún más precisa. Les da un bloc de papel a cada uno con la instrucción de escribir todo lo que la hija pueda decir hasta la próxima sesión. Esta tarea procuró una mejoría notable en la relación familiar. Los padres fueron confirmados en su rol y les fue confiada una tarea importante. Se encontraron tan ocupados en tomar nota que la hija tuvo al fin la oportunidad de expresarse sin ser interrumpida. Los padres escucharon lo que ella quería decirles y le dieron respuesta. Su comportamiento se volvió normal.

LA NOCION DE TIEMPO TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL: Aunque una intervención terapéutica sea perfectamente elegida y formulada, es necesario cierto tiempo para que el sistema pueda reaccionar a su contenido con un cambio estructural. Si la familia es entrevistada a intervalos demasiado cortos, el terapeuta podrá interpretar equivocadamente la situación y ver en la ausencia de cambio el indicador de una intervención ineficaz. Una nueva intervención, aunque sea exacta en el plano formal, podrá ejercer en esas circunstancias una presión demasiado grande sobre la dinámica sistémica y desencadenar reacciones homeostáticas imprevistas e indeseables. Parece que un intervalo de tiempo de 3 ó 4 semanas es adecuado en terapia familiar de tipo sistémico.

Conclusión

La teoría de los sistemas ha contribuido suficientemente a hacernos comprender la responsabilidad del grupo en la aparición del síndrome psiquiátrico en un individuo. Las implicancias clínicas de tal comprensión son naturalmente numerosas.

En terapia familiar el abordaje sistémico por medio del bloqueo de refuerzos circulares puede detener el avance de una sintomatología psiquiátrica que puede extenderse sobre varias generaciones.

Además nos parece útil remarcar el alto valor ético y humano de esta nueva comprensión de los problemas del grupo humano. No acusa a nadie, no estigmatiza a ninguno y pone el acento sobre la liberación de recursos latentes hasta ese momento inutilizables en el grupo familiar.

Philippe Caillé

BIBLIOGRAFIA:

1. Bateson, G.: "Steps to an ecology of mind"
Intertext books. Londres 1972.
2. Von Bertalanffy, L.: "General system theory"
Penguin Books Ltd., Middlesex 1973.
3. Caillé, P.: "La question des modèles théoriques en psychothérapie de famille"
Ann Psychothérapie 1974, 8, 4 - 11.
4. Ferreira, A. Jo.: "Family mith and homeostasis"
Arch Gen Psychiatry 1963, 9, 457-463.
5. Jackson, D.D.: "The question of family homeostasis"
Psychiatr. Q 1957, 31, 79-90.
6. Palazzoli, M. Selvini et al.: "Paradosso e contro paradosso"
Feltrinelli, Milano 1975.
7. Pollak, O.: "Sociological psychoanalytic concepte in family diagnosis"
J. Green, B.L., ed. The psychotherapies of marital disharmony.
Free Press, New York 1965.

Ensayos sobre la dialéctica de los niveles de comunicación en la intervención terapéutica.

JACQUES RUDRAUF

Médico psicoanalista, 120, Rue d'Assas-75006, París (Francia)

Es harto conocido e incansablemente repetido que "es imposible no comunicarse" (P. WATZLAWIK). Sin embargo HEGEL -también harto conocido...- escribió en el prefacio a la *Fenomenología del Espíritu*: "Lo que es conocido en general, justamente porque es aceptado como conocido, no es conocido. La manera más común de engañarnos y de engañar a los otros en el proceso de conocimiento es dar por supuesto que el objeto es conocido y tolerarlo así; tal saber, sin darnos cuenta como sucede, no se conmueve a pesar de los discursos"

De lo que surge el compromiso de un análisis crítico que prefigura lo que por análisis entendiera Freud, y, por excelencia, la lectura de Freud por Lacan.

En consecuencia, ¿cómo entonces comunicarnos entre nosotros?

Esta participación en vuestra revista la he prometido a su Director, el Dr. Canevaro, desde Septiembre de 1977 en Zurich, y estuve haciéndola esperar, más allá de toda cortesía, para anun-

Jacques Rudrauf

ciarla de nuevo como inminente un año más tarde cuando visitaron París, dos colegas suyos, los Dres. Yaría y Bianucci, visita que fue un encuentro rico de sentido, sin duda por muchas razones.

Pero yo quisiera detenerme en esto, que concierne más precisamente a nuestra área: las dificultades de comunicación en este encuentro ligadas al no conocimiento recíproco de los idiomas, se transformaron incontestablemente en apertura de otra comunicación más rica y más eficaz. No me arriesgaría a decir más profunda, pero no dudo en asumir el riesgo del malentendido del "léxico" ni la paradoja de una comunicación "más eficaz cuanto más difícil". HEGEL acaba de hacernos oír, pienso, que al dejar en suspenso lo "conocido" se abrirá el camino hacia el conocimiento. En este caso, "trabar conocimiento".

Debo precisar que no hubiera logrado escribir estas líneas de no haber tomado conciencia bruscamente de un obstáculo puramente ilusorio, ni siquiera imaginario, menos aún de orden real y por lo tanto de valor simbólico. Era como si hubiera tenido que hablaros en ese francés desintegrado, que se acostumbra llamar "petit nègre", y que uno cree generalmente tener que practicar cuando trata vanamente de hacerse comprender por el extranjero. Y de súbito, me dí cuenta que me podía permitir simplemente el uso de mi idioma familiar. Volvéroslo inteligible es vuestro problema, un simple problema de lectura directa o de traducción.

Que hubiera además otros obstáculos en la puesta en marcha de este encuentro, remitía sin duda a alguna Resistencia, y no hizo sino dar sentido a nuestros esfuerzos por superar y levantar resistencias (siempre la *Aufhebung* hegeliana).

Y fue así como llegamos a hablar del silencio como vehículo de la comunicación significativa.

Se habló de los problemas planteados por el abordaje terapéutico de un sordo-mudo por un terapeuta: ¿cuál de los dos se encuentra más obstaculizado? Las manos hablan. Y hablan mejor ciertamente, a aquél que no dispone del "conocimiento" de las palabras circulantes.

De acuerdo a lo que se me dijo, Salvador Minuchin no teme de ningún modo presentar videograbaciones de sesiones familiares a un público de lengua extranjera. Es mejor así, sin dejarse fascinar por los contenidos verbales, se está más dispuesto al análisis directo

de las interacciones. Si las manos hablan, el ojo escucha. Y el silencio es de oro.

Así, de tema en tema, si recuerdo con certeza, llegamos a referirnos al cine mudo, después a casos clínicos que nos preocupaban a unos y a otros. ¿La terapia familiar no nació de la suspensión y de la superación de la imposibilidad de la comunicación entre esquizofrénico y terapeuta, gracias a la toma en consideración de ese conjunto escénico, doblemente dramático, en el que el paciente designado es súbitamente retirado de la entrevista clínica para ser devuelto a los suyos, como uno de los autores-actores de una historia familiar donde reina lo no-dicho? Inclusive las palabras alucinatorias, palabras claves, no adquieren sentido hasta que no recuperan su lugar en otra escena. Pues finalmente, lo no-dicho, el silencio, la pantomima y las expresiones fisonómicas son a pesar de todo un lenguaje, y es un lenguaje adecuado que será necesario recuperar para que haya proceso terapéutico. Nosotros como terapeutas no renunciamos a la cura por la palabra (talking cure) ni a ese "discurso que parece no serlo" del que Jacques LACAN nos habló.

Y el deseo surgido de una conversación tanto más rica cuanto más difícil, era el de llegar a superar las barreras lingüísticas, de aprender las lenguas de los hombres (¿y la de los ángeles?), en esta espera de promover los intercambios por medio de traducciones, de terminar al fin con la maldición de BABEL; vuelvo aquí a los sordo-mudos con este título de la obra del Abate de la Espada (1776): "Institución de los sordos y mudos por medio de signos metódicos, obra que contiene el proyecto de una lengua universal utilizando signos naturales supeditados a un método".

Sí. Pero no olvidemos que el descubrimiento de un idioma diferente se acompaña siempre con un enriquecimiento de la comprensión de nuestra propia lengua, y sobretodo con el aporte de formas de pensamiento definitivamente no traducibles, que marcan un nuevo paso en el juego de las interacciones y de las comunicaciones, y que condenan por eso mismo como fuente de empobrecimiento toda veleidad de reducir el tesoro lingüístico humano a un idioma universal.

La conversación, que había tomado el aspecto de una charla familiar, se prolongó largamente en la velada, nutrida por el inter-

cambio a propósito de casos clínicos. Nuestros pacientes más difíciles de comprender se convirtieron en los mediadores naturales de nuestra propia búsqueda de comunicación. Nos separamos con la promesa de que yo consignaría aquí la historia de un proceso psicoterapéutico acerca de un niño, que llamaremos Bernardo, en homenaje a la Regla del Silencio.

Tres motivos confluyen en este proyecto: Hemos hablado mucho de él, él no me ha hablado nunca, y su familia, a quien él reservaba la exclusividad de sus palabras no me ha dado muchas ocasiones de medir la dificultad y el valor del abordaje familiar.

La historia de Bernardo y de su familia sería un pobrísimo ejemplo en favor de las técnicas de la terapia familiar. Pero los lectores de "Terapia Familiar" no tienen necesidad ciertamente de ejemplos convincentes, y los que un colega francés pudiera proponerles no les aportarían, pienso, nada nuevo.

Bernardo no me ha entregado, al menos, la llave de su silencio: tengo razones para creer que el día que lo haga, esta llave cerrará más puertas que las que abra. Un problema resuelto ya no es más un problema, mientras que la desaparición de un síntoma no agota la cuestión del sujeto, tal como se reduce el atractivo de las palabras cruzadas una vez llenado el último casillero.

Bernardo se las arregla para mantener la relación emprendida, habiéndome elegido como único y último partenaire de su silencio: único partenaire también, parece, con quien el mundo de sus fantasmas y de la otra escena se entreabre y se elabora.

Sin embargo, le sucede a veces tener que decirme algo por medio de palabras. En ese caso, él escribe, por ejemplo el nombre de un objeto dibujado que yo no reconocí.

El año pasado tenía 7 años y 8 meses cuando respondió a un pedido de novedades acerca de su madre enferma tomando un lápiz, recortando un rectángulito de papel sobre el que escribió: "mi mamá murió". Un tiempo antes, la familia me lo había hecho prever, pero no me había aún informado del acontecimiento.

Sin embargo, desde la primera entrevista a causa precisamente del hecho que Bernardo, que entonces tenía 5 años y medio, era totalmente mutista fuera de su familia, y como en la escuela despertó preocupación, propuse abordar el problema por el camino de una terapia familiar, y obtuve al menos que el grupo familiar

entero viniera a verme de tanto en tanto, con el fin de estudiar el problema en el mismo lugar donde se presentaba: en el de la comunicación.

La madre de Bernardo - llamémosla Sra. Clement - se recuperaba en ese preciso momento de una histerectomía. Toda la familia me afirmó que no existía malignidad. La reciente operación la había dejado delgada y demasiado fatigada para que yo insistiera directamente en que viniera frecuentemente.

El Sr. Clement, de un parecido físico sorprendente con Bernardo, es un hombre rechoncho, que pesa por su anchura y por su silencio. Cada noche acostumbra cerrar él mismo las verjas del jardín que rodea la casa de la familia. Trabaja en un banco, y en las primeras entrevistas, su mujer contribuyó a defender su aislamiento con esta definición de cobertura de su modo de relacionarse (relationship): "A él gustan los contactos con la clientela, en el banco".

La familia está constituida además por tres hijas mucho más grandes (de 23, 21 y 18 años cuando Bernardo tenía 6 años) y que vinieron regularmente a las sesiones familiares hasta el período dos años más tarde, en que la Sra. Clement se enfermó de nuevo. Se agregaban numerosos niños de los que la Sra. Clement era nodriza y, en el vecindario, los parientes del Sr. Clement, a los que nunca pude ver pero con los que se mantenía un conflicto también pesado.

Las sesiones familiares permitieron que las hijas mayores expresaran sin remilgos reproches a su padre, propuesto como obstáculo en la comunicación: "¡se habla, pero no se habla!". Paradoja banal, la facilidad con la cual esos reproches la expresaban señala por el contrario una soltura metacomunicativa que confirmaría más tarde la apertura de la menor de las hijas, la que se parecía más físicamente al padre, cuando tomaría el rol de ama de casa, después de la muerte de la madre.

Paralelamente, un contrato personal - sin duda tácito, pero fielmente mantenido - fue establecido con Bernardo: vendría a verme al C.M.P.P. (Centro Médico-Psico-Pedagógico de cura ambulatoria) una vez por semana, con el objeto de mantener entrevistas destinadas a ayudarlo a comunicarse, pero él tendría el derecho de callarse, como el de hablar según su conveniencia y si así lo sentía.

Lo que quiso hacer con este contrato, lo explicitó mucho más tarde con su hermana en la semana anterior a la muerte de la madre. Después de una prolongada abstención de la familia, recibí una visita de estilo un poco protocolar: el Sr. Clement y la jovenita venían a participarme del inminente duelo, como si no se hubiera hecho nunca terapia familiar. Me contaron -anecdóticamente, o como el signo discreto de que, detrás del silencio o los silencios, todo el mundo sabía que es imposible no comunicarse- que Bernardo había dicho a su hermana que conmigo no hablaba "porque tenía el derecho de no hacerlo".

La relación con él se desarrollaba y se desarrolla aún con el juego ritualizado entrecortado con pantomimas. Pero los franceses estamos atrasados con respecto al progreso, y somos terapeutas sin video; no sabría entonces transmitirlos exactamente el tenor de esas secuencias. Por otra parte, no es ése mi propósito. Más tarde llegará sin duda el momento de retomar y repensar la terapia de Bernardo. Me propongo, cuando se presente la oportunidad, reanudar el abordaje del sistema familiar, que convendrá circunscribir según la elaboración del trabajo de duelo en el sistema tal como tienda a reconstituirse.

Empiezo a darme cuenta de que los silencios de Bernardo tienen que ver con un trabajo de duelo muy anticipado con respecto a la realización del duelo por la madre. Creo que una de las claves hacia donde tiende todo el proceso, se rebela en la evidencia de la identidad estructural entre trabajo psicoterapéutico y trabajo de duelo (1). En el caso de Bernardo, el trabajo se lleva a cabo (se elabora: *Durcharbeitung*) a través de lo que muestran algunas de sus producciones gráficas que tienen por tema desplazamiento, voracidad, explosión, nacimiento y muerte. La muerte real de la madre es anunciada por la eclosión del tema de los pájaros saliendo del huevo, en un contexto de violencia despedazadora que hace pensar que el destino conceroso de la matriz de la cual nació, se inscribió en el discurso inconsciente de Bernardo mucho antes de que cualquiera de sus allegados hubiera soñado con saberlo. Y el Sr. Clement insistía, luego de la muerte de su mujer, sobre la anterioridad

(1) C.F. Erna Furman. "A child's parent dies" - Yale Univ. Press, 1974.

de la negativa a hablar de Bernardo con respecto a la eclosión de la enfermedad materna.

Pero ya son demasiadas hipótesis y el momento de concluir no llegó en tanto Bernardo no nos lo advierta.

Por otra parte sería arbitrario valorar este aspecto en detrimento de otros mucho más "obstinados": juegos escénicos y corporales, dibujos y otras producciones gráficas o plástica inspiradas en el "Squiggle" de WINNICOTT, etc., repetitivamente consagradas a temas de despedazamiento, penetración y eyección anales y orales y reconstrucciones defensivas.

Entre los vehículos de significación "sin palabra" no podría omitir el empleo que hago de los personajes fotográficos del test de SZONDI. Deberemos volver sobre el lugar que ocupan en el juego interaccional, en el proceso hacia un conocimiento de orden diagnóstico, en la emergencia de los "significantes que representan un sujeto para otro significante" y sobre todo para el "sujeto-paciente-designado". Nada se opone a que yo precise aquí que la evocación el Diagnóstico Experimental de las Pulsiones (el test de Szondi según su definición técnica) me surgió como un eco de la de ese sadismo anal, por el cual los perfiles de elección reunidos en esta transacción son particularmente...evocadores.

Esta otra triangulación que introduce la referencia al Análisis del Destino con respecto a las del Psicoanálisis y de la Terapia Familiar sistémica, también fue aludida en nuestra conversación en idiomas entremezclados.

No es sin motivo que esta presentación tenga un carácter parcelado, inacabado, aún alusivo.

En toda terapia, individual o familiar, en todo análisis quedan zonas oscuras y devenires imprecisos. Ahora bien, es precisamente por haber observado los efectos familiares, felices o desgraciados, de intervenciones llamadas "individuales" que concentré mi atención cada vez más sobre diversas aproximaciones de terapia familiar.

¿Qué vías nos abren entonces los silencios de Bernardo Clement?

Venimos de enfrentarnos a la espinosa cuestión del diagnóstico tal como parecía imponerlo la gravedad de los síntomas en la *Terapia Familiar*, 4, 1980

primera entrevista, en Noviembre de 1975 y a la que parecía remitirnos de nuevo el recurso al "Diagnóstico Experimental de las Pulsiones".

La primera vez que recibí a solas a Bernardo, algunos días más tarde, fue bajo el presupuesto de "estado psicótico": "silencio y paz, tales que llego a preguntarme si Bernardo no es sordo". La atmósfera familiar pesadamente fóbica reclama un proceder prudente, al menos no-contrafóbico. Y he aquí constituido un campo interaccional, el del "sistema terapéutico": paciente designado-familia-equipo terapéutico- que tiene como efecto primario volver caduca la cuestión de un diagnóstico, en provecho de la cuestión de "lo que ocurre" entre todos esos intervinientes. Aufhebung: supresión - superación de la cuestión del diagnóstico. Con la familia Clement, el telón se levanta -a lo Pirandello- sobre una organización de una ingeniosa complejidad de la que Bernardo, el del silencio, es el portavoz privilegiado. El está ahí, preso entre toda una serie de bloques solidificados con los cuales tiene la tarea de identificarse: una madre que va a morir de un cáncer uterino -tres hermanas adultas de las cuales cada una podría abrir tantas vías a la investigación psicológica, psicoanalítica, o interaccional, y que, como el coro antiguo, van a acusar al Sr. Clement, su padre y el de Bernardo: "él creía que habíamos de su propia madre de quién resultó la copia fiel". Pues también estaba esta abuela paterna, muerta hace 3 años, pero que vivía en la casa. Y la madre comentó, en una de las primeras reuniones familiares: "yo debí ser suficientemente dócil para soportar esto 20 años". Y para colmo, luego de la muerte de esta abuela vino a reemplazarla en el hogar la abuela materna.

Pero el esquema sistémico no termina ahí pues también tuvo lugar la presión escolar, que constituye en síntoma el silencio de Bernardo.

Ahora bien, tal como se desarrolló después la historia, y a pesar del valor incontestable que tomaron las sesiones familiares, fue siempre Bernardo quién se mostró más apto para movilizar esos efectos de masas. Pero para encarar la demostración haría falta retomar en lectura psicoanalítica, la enorme producción "no verbal" de 4 años de sesiones individuales semanales.

¿La lectura más esclarecedora no consistiría en evaluar en tér-

minos de "delegaciones de fidelidades" el esfuerzo de Bernardo por decir todo imponiéndose la regla del silencio?

I.BOSZORMENYI-NAGY, M.BOWEN y luego H.STIERLIN nos remiten del mal o buen grado al Análisis del Destino: lo he explicado en otro lugar. (1)

La primera persona del equipo que intentó aproximarse al niño había observado lo siguiente viendo a Bernardo hacer un dibujo con los marcadores que llenaría toda una hoja, sin un blanco (¿sin un silencio?): "(. .), se detiene, con la mirada perdida; después toma el naranja. Esas zonas de color progresan en laberinto. Encuentro muy interesante la progresión de sus elecciones. Es como la historia de sus pulsiones acuarteladas, ahogadas, reprimidas..." Ahora bien, este analista no se refiere a los conceptos szondianos. Pero se confirma que la lectura szondiana del problema familiar de Bernardo pone en primer plano una complicada intrincación de factores raíces entre los cuales prevalece la acentuación cuantitativa de la tendencia, dejando como válvulas sintomáticas el vector paroxísmico y sobre todo el del contacto, es decir, la problemática de las relaciones de objeto. Esta situación vivida tanto por cada uno de los miembros de la familia como por el sistema familiar como tal, encuentra una de sus expresiones clínicas en una de las primeras entrevistas familiares por la descripción del padre como "aquel que no quería que se hablara la copia fiel de su madre- no se podía explicar nada sin exponerse a una explosión de cólera" (14-6-76).

El 15 de Noviembre de 1977, entre otras producciones de excepcional riqueza, Bernardo construyó en plastilina un autito con su chofer que atacó violentamente casi hasta destruirle plantándole muchos lápices. Enfrente, un cartel demasiado pesado para sus soportes, sobre el cual-graba: "Peligro" (sic).

El 24 de Noviembre, por primera vez dibuja una casa perfectamente coherente con un árbol, un sol, macetas con flores, con un trazo claro y meticuloso. Yo sigo sin novedades de la familia. Para no agregar un no-dicho, le pregunto por la salud de la mamá. Es cuando me responde sobre un papelito como fue dicho anteriormente:

(1) Coloquio de IFSA - Pamplona, 1978.

Yo escribo estas líneas en abril de 1979 y el trabajo continúa. Desde el punto de vista de la evolución clínica y de la inserción escolar, familiar y social, parece que Bernardo "salió del paso". Pero no se termina ahí el objetivo terapéutico que es el de rescatar todo lo que se pueda. Y si yo soy el único a quién Bernardo aún no habla es sin duda en parte el resultado de una especie de compromiso moral que hizo consigo mismo, pero también y sobre todo es porque aún tiene demasiado que decir, demasiado que elaborar, antes de renunciar a ese modo privilegiado de comunicación.

CONCLUSION

En realidad no concluiremos.

Bernardo nos llevó más lejos de lo que yo pensaba, y no me oculto la dificultad para un lector no advertido, de descubrir el hilo conductor, el trazado regulador (1) de este ensayo.

A los lectores de Terapia Familiar debo intentar proveerlos de ciertas "instrucciones". El proceso que traté de presentar se caracteriza por una especie de lectura múltiple simultánea: se trata de recibir al mismo tiempo tanto como sea posible todos los niveles de comunicación, mensajes y metamensajes sin eliminar como incompatibles los que se oponen o parecen excluirse.

Este proceso es semántico y dialéctico. El hilo conductor se reencuentra en el camino directo que va del Sócrates platónico a los diversos autores que cité, con la mención especial de HEGEL, y sin olvidar los "non Aristotelian Systems" de KORZYBSKI.

No se trata de preocupaciones culturales ni de filosofía abscóndita.

Las personas y las familias que vienen a pedirnos ayuda tienen el derecho a ser escuchadas según todas las dimensiones de su propio ser, corporal, psicológico, familiar, social. El texto que nos aportan exige múltiples niveles de desciframiento. Es "bien conocido" también que el cambio terapéutico implica el cambio de

(1) Término tomado de la estética matemática (Cf. Matila C. Ghyka - El número de oro, etc.

“tipo lógico” (RUSELL, BATESON, WATZLAWICK).

La lectura de la historia Clement (Bernardo y los otros) para no estar limitada a una decodificación unilateral debe ser multidimensional: estereofónica, estereoscópica, pero también polifónica -es decir que la multiplicación de los canales está determinada por una preocupación por poner de manifiesto. El escollo del riesgo de confusión no es más peligroso que el de una proyección unilateral deformante. Y no es complicar la recepción de T. V. dar simultáneamente imagen y sonido...

El desarrollo de los abordajes sistémicos familiares contribuyó mucho a esta apertura simultánea de la mirada y de la escucha en la realidad ampliada del ser en el mundo. Conviene estar atento a superar a integrar los contrarios sin crear escotomas ni desconocimiento sistemático. Así, por ejemplo, el punto de vista comportamental y sistémico, cibernético, no vuelve más caduca la óptica freudiana, que la electrónica no lo hace con la teoría de las palancas.

Por lo mismo, el carácter orgánico o somático de un síntoma no le impide ni de ser un lugar de transacción familiar, ni de jugar en el plano de los sistemas significantes. Apelo al “Nudo de Borromeo” de Jacques LACAN, entre los campos de lo Real, de lo Imaginario y de lo Simbólico.

Los silencios de Bernardo así como las dificultades lingüísticas que se interponen entre interlocutores de diferentes países actúan en favor de la puesta en acción de canales de comunicación, de niveles de escucha demasiado a menudo velados por obstáculo de lo “conocido”.

Una última aclaración para ubicar quizás mejor el viso que ha tomado este intento de comunicación: la referencia a HEGEL fue introducida en razón de otra dificultad de traducción, la de la palabra alemana varias veces mencionada: Aufheben: suprimir, pero también superar, poner de manifiesto, levantar, elevar, quitar. Esta palabra clave de la dialéctica hegeliana fue empleada con esta referencia y sin duda con toda su fuerza por H. STIERLIN y la necesidad de volcarla al francés se impone con la traducción en curso de la obra de este autor: “La primera entrevista familiar”.

Así se ilumina a la luz de la negación, de la Verneinung freudiana, la cuestión de lo “conocido”: si es imposible no comunicarse

Jacques Rudrauf

¿se puede verdaderamente comunicarse?. Pues no hay que disimular que en todo intento de comunicación hay riesgo de malentendido y que un mensaje no adquiere sentido más que del eco que produzca y del Feedback que quizás vuelva a quién lo emitió.

Traducido por Stella Maris Molina

Terapia de la familia a transacción esquizofrénica. El control terapéutico del supra sistema.

MARA SELVINI PALAZZOLI

Directora del Centro para el Estudio de la Familia, Milán (Italia).

PREMISA

Este seminario propone a discusión la tentativa de poder dar una explicación teórica-cibernetica de nuestra praxis, que nos fue revelada empíricamente como positiva; el poder interrumpir, después de cada sesión, la relación con la familia por espacio de un mes.

El objeto de este análisis es el sistema familia-terapeutas o sea la resultante sistémica de la interacción entre dos sub-sistemas en el contexto del tratamiento. Referiremos a continuación las diversas hipótesis explicativas que en el curso de nuestra investigación le hemos conferido a este dato empírico.

La hipótesis explicativa actual, que aquí presentamos, está inspirada por numerosas observaciones clínicas, especialmente de algunas modalidades repetitivas de resistencias presentadas por algunas familias, y que se avalan del modelo cibernético, precisamente por algunas hipótesis formuladas por Ashby en "Proyecto para un cerebro" (1). Adoptando tal modelo, llegamos a la convicción que el riesgo más grave, a los fines del cambio terapéutico

Mara Selvini Palazzoli

que amenaza al supra-sistema familiar-terapeutas, es aquel, de organizarse de un modo estrechamente ligado. La praxis por nosotros empleada nos parece útil para poder combatir eficazmente dicho riesgo, mediante dos modos operacionales simultáneos de los terapeutas.

a) Introducir en el sistema familiar información terapéutica que permaneciendo invariable, actúen como constantes no funcionales de la organización en el preciso instante.

b) Interrumpir la relación familia-terapeuta por un tiempo prolongado considerado indispensable para el acúmulo de retroalimentaciones observables.

Al comienzo de 1972, nuestro equipo planificó un proyecto de investigación en la terapia de la familia, que presentaban como pacientes designados, anoréxicos y esquizofrénicos. Adoptando el modelo sistémico decidimos, como primera medida su aplicación rigurosa. Debimos estudiar, como evitar a cualquier precio la contaminación ecléctica con otros modelos conceptuales. En lo que concierne al ritmo de las sesiones no nos impusimos ningún estilo metodológico. Por algún tiempo continuamos con el uso de las sesiones semanales. Fue por una casualidad, que un fenómeno muy interesante nos llamó la atención. Algunas familias que por necesidad, venían citadas a intervalos más largos, presentaban de sesión en sesión cambios muchos más marcados que los de las familias citadas semanalmente. Se trataba de familias que habitaban en regiones del centro y sur de Italia, y que no podían afrontar con frecuencia viajes largos y costosos. Tal observación nos obligó a buscar una explicación. Aquella que en este momento nos pareció obvia para motivar al cambio a esas familias: fue el displacer que producía el viaje, a veces nocturno, sobre trenes repletos y sin vagones camas; era el test de una motivación inequívoca que explicaba los resultados. A los fines de poner a prueba la validez de tal hipótesis explicativa, decidimos de alargar el intervalo entre las sesiones incluso a familias que residían cerca. Los resultados nos permitieron de aceptar aquella primera hipótesis. Embarcarse en un viaje displacentero no constituía por cierto una discriminación de la motivación de la familia al cambio. Formulamos enton-

ces una segunda hipótesis. Los mejores resultados obtenidos debían atribuirse a un mayor empeño nuestro. De frente a una familia que venía "por un tiempo relativamente largo" era obvio que nos sintiéramos obligados a una observación más intensa y a un esfuerzo más grande de fantasía, para obtener intervenciones originales. Tuvo así comienzo, en nuestra investigación, una fase que llamaremos intervencionista. Debíamos aplicarnos y a inventar intervenciones cada vez mas "potentes". Fue en aquél período (1972-75) que escogimos los rituales familiares y las prescripciones paradójales sistémicas. Pero debíamos tener en cuenta que por debajo de tal empeño, se encontraba un error conceptual. Aún sabiendo bien, intelectualmente, que en el contexto del tratamiento terapéutico, familia y terapeuta no pueden ser considerados separadamente, de hecho continuamos poco a poco a mantener una separación. Veíamos por cierto cómo nosotros mismos, éramos una especie de curanderos empeñados a forzar a las familias al cambio. En cuanto a las familias empeñados como estábamos, sólo en el trato con familias rígidas y mecánicamente autocorrectivas, reteníamos que los largos intervalos necesarios para obtener un cambio, fueran específicos para ese tipo de organización. Finalmente algunos fenómenos que se verificaban repetitivamente, incluso con familias menos rígidas en su organización, nos obligaron a repensarlo. Se trataba de los siguientes fenómenos:

- a) Si después de una intervención paradójal al cierre de la sesión, no nos despedíamos inmediatamente y por el contrario permitíamos y concedíamos a las familias el poder discutir con nosotros la intervención venía descalificada y perdía eficacia;
- b) Si una vez lanzada la "bomba" inmediatamente nos despedíamos fijando la fecha de la sesión sucesiva, venía después de unos días una telefonada en la cual con diversos pretextos (por ejemplo el empeoramiento del paciente designado) se nos pedía anticipar la sesión fijada;
- c) Si abandonando una vez el "furor intervencionista" pedíamos una sesión de por sí significativa sin hacer ningún comentario y sin dar ninguna prescripción, limitándonos a fijar la cita sucesiva, un cierre así inesperado y críptico provocaba en la familia cambios importantes, observables en la sesión siguiente. Una serie tal de constataciones espíricas nos obligó a reconsiderar el contexto del

tratamiento como un supra-sistema, cuyo control a los fines del cambio, debe quedar solamente en manos de los terapeutas. Como primera cosa, nos aplicamos a explicar por que jamás la resistencia de la familia se expresarán en la tentativa de prolongar o dilatar la interacción directa con los terapeutas, o en el apuro de volver lo más rápido posible. Nos parecía claro que la familia, tratase, con ésto anular los efectos de nuestra intervención. Y que lo lograra fue constatado a continuación de una llamada telefónica y que habíamos ingenuamente concedido anticipar la cita (1). Habíamos tomado conciencia del hecho que el conceder una sesión anticipada, equivalía a descalificarnos a nosotros mismos y a nuestras intervenciones. La táctica por la familia usada para obtener una cita adelantada, era para después presentarse a contar problemas del todo distintos de aquel que debía ser focalizado. Pero incluso cuando la familia no llegaba a esto, surgía un otro comportamiento repetitivo. Familias que en el momento del contrato, habían expresado alivio, al saber que serían solo diez sesiones, con intervalos de un mes, y habían encontrado elevado el costo de la sesión, después de haber "embolsado" algún resultado terapéutico, invertían de improviso la postura. Amablemente nos rogaban de no tener en cuenta lo anterior: estaban dispuestos a venir más seguido y que no tenía importancia el costo!...

A los fines de clarificar el problema que teníamos delante, recomenzamos en un cierto sentido desde el principio: en varias reuniones de equipo decidimos examinar la peculiar posición de los terapeutas en el contexto del tratamiento. No aparecía claro que los terapeutas, por ser tales, debían entrar en el sobre-sistema como miembros aceptantes y aceptados. Pero también nos resultaba esencial que los terapeutas debían tener el control en sus manos, del contexto y de la definición de la relación (posición meta). Ellos debían descubrir los más rápido posible ciertas reglas del juego familiar en el momento, sin dejarse envolver en la misma modalidad organizativa. El juego de la familia, al contrario nos

(1) Con la experiencia aprendimos a servirnos de las llamadas telefónicas para obtener clarificaciones que casi siempre evidenciaban un carácter de pretexto del pedido y que nos permitían no encontrarnos envueltos en las maniobras familiares.

resultaba, aquel de confundir a los terapeutas envolviéndolos en sus propias reglas, para así constituir incluso con ellos, un sistema autocorrectivo establemente ligado y a prevalencia homeostática. Un lindo artículo de Lynn Hoffman (3) que apareció en el 1975 en la revista *Family Process* ofrece nuevos puntos para la elaboración de nuestra teoría. En tal artículo refiriéndose a Ashby y precisamente al clásico "Proyecto para un Cerebro" se encuentra este argumento: las familias disfuncionales son sistemas demasiado estrechamente ligados, que en cierto modo recuerda el mecanismo y la lentitud de adaptación del homeostato. Incluso ése en terapia puede cambiar rápidamente "para explicar el hecho del cambio es necesario hipotetizar las relaciones entre las partes. Esta observación supone en la terapia familiar ciertas maniobras capaces de crear límites entre subsistemas, diferenciando los individuos entre sí y bloqueando las secuencias habituales de interacción". En nuestro caso tal hipótesis debía incluir incluso a los terapeutas. Llegados a considerar el sistema familia-terapeutas como una unidad supra sistémica teníamos que explicar en términos cibernéticos, ya sea nuestras maniobras terapéuticas, ya sea las contra-maniobras familiares. La hipótesis explicativa nos vino de Ashby. Como sabemos, él había elegido su homeostato como modelo para la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Todavía el homeostato en cuanto es un sistema ultra-estable completamente ligado, tenía tiempo de adaptación y por lo tanto de aprendizaje, mucho más largo que aquellos que el cerebro humano. A los fines de explicar la enorme rapidez de adaptación del cerebro, Ashby formuló 2 hipótesis:

- a) que si se lograran verificar momentos de uniones parciales dinámicas entre las partes del cerebro. En tales partes temporariamente unidas, debía tener lugar cambios parciales con posibilidad de acumulación de los mismos;
- b) que tales uniones fuesen obtenidas mediante la introducción, en la cadena interactiva, de constantes y no-funciones destinadas a interrumpir temporariamente el flujo de la información. Se puede ejemplificar con un artificio empleado en neurofisiología experimental: el congelamiento de un segmento de la médula, reacciona como la introducción de una constante y como no-función, en cuanto al segmento congelado no interacciona con

el segmento siguiente, bloqueando la transmisión de la información. La médula viene así temporariamente unida o puesta en dos subsistemas independientes, obligados a adaptarse independientemente, si usando tal hipótesis retomamos los problemas de terapia familiar arriba expuestos, debemos sobre todo considerar al sobre-sistema familia-terapeutas, a la similitud en un aparato cibernético, en el cual, el máximo peligro, en lo que concierne a los fines del cambio, es aquel de ligarse en modo muy estrecho, rindiendo difícil o imposible a los terapeutas el mantenerse en posición meta. Sirviéndonos de tal hipótesis tratamos nuestras maniobras terapéuticas. La primera maniobra es aquella de introducir en el sistema familiar una información o im-put a efecto entropía negativa (negentrópico). Tal in-put (señalamiento) a pesar de configurarse como veremos con distintas modalidades, representa siempre una información alternativa y por lo tanto una posibilidad de aprendizaje. Viendo la prescripción de rituales familiares, observamos como tácitamente sustituyen reglas nuevas, a las reglas que perpetúan la disfunción. La familia que sigue tales rituales, experimenta sobre el nivel concreto comportamiento alternativos, por de pronto excluidos de su propio contexto de aprendizaje. Así incluso un cierre de sesión a los fines de redefinir paradójicamente convicciones y relaciones, se constituye como una epistemología alternativa que descoloca el universo ontológico y perceptivo de la familia. La segunda maniobra terapéutica consiste en el hecho que los terapeutas después de la intervención, rápidamente se retiran cortando por un tiempo establecido la relación con la familia. Tratemos de analizar los efectos de esta maniobra, teniendo presente las dificultades de explicar separadamente lo que en realidad es concomitante. El efecto de la primera maniobra en cuanto se refiere a la información, mientras es un impacto sobre todo el sistema, no puede no ejercer un efecto distinto sobre cada uno de los miembros. Y por qué? Por el hecho de que cada uno de los miembros inevitablemente ocupa, en el retículo de las relaciones sistémicas, una posición distinta.

Haley (2), fue el primero en enunciar este principio: es imposible que dos miembros de un sistema puedan ocupar al mismo tiempo una idéntica posición. En tal sentido la información introducida por los terapeutas representa un significado distinto

para cada miembro de la familia y provoca en cada uno reacciones distintas. Tales reacciones distintas (y diferenciadas) no son otro, que adaptaciones parciales como respuesta a la información. No solo eso. Cada adaptación parcial de un miembro constituirá para cada uno de los otros miembros de la familia una nueva información a la cuál es imposible no reaccionar. Se tendrán en tal modo un acúmulo de efectos parciales, porque como afirma Ashby concedemos a los efectos, el tiempo para trabajar sobre todo el sistema. Lo que equivale a decir que una serie tal de fenómenos retroactivos a la información terapéutica requiere un cierto tiempo para desarrollarse y poder ser observable. De lo cual deriva que si después de un input terapéutico abandonamos a la familia por un tiempo muy breve, el cambio no será suficientemente desarrollado para poder ser observable. Veamos por ej.: el caso de una anoréxica que después de una intervención terapéutica, abandona bruscamente el síntoma, se necesitará un cierto tiempo para que se manifieste la reacción depresiva en uno o ambos padres. Veamos un caso más complejo, de una familia de 4 personas con un hijo varón de 17 años designado esquizofrénico, y una niña de 13 años de comportamiento muy infantil. Si la niña reacciona primeramente a una intervención terapéutica, produciendo una borrascosa rebelión adolescente, se necesitará tiempo para que se produzca una reacción angustiosa de la madre y a su vez el paciente designado reacciones con una inesperada fuga de casa. Si la familia viene abandonada por un intervalo suficiente, el vértice de la retroalimentación recíproca habrá determinado un cambio evidente, que aparece a los ojos del observador con la saliencia de una adaptación escalonada. Y eso obviamente en función del tiempo transcurrido, traduciendo estas reflexiones teóricas en experiencias clínicas, como son los fenómenos que más comúnmente observamos, en una familia dejada por un mes después de un impacto terapéutico.

Con gran frecuencia no dicen que se ha producido un cambio, mientras los efectos y por lo tanto el testimonio del cambio producido asumen la siguiente modalidad: una forma de presentación depresiva de cualquier miembro, muy común en uno o en los dos padres, decepción y falta de confianza en la terapia, y agresiones comunes frente a quien más cambia. Familia de psicóticos

crónicos, han llegado al punto de declarar su decepción por que el paciente designado en la cuarta sesión todavía no se había curado! Pero nuestra operación terapéutica no consiste sólo en esto. He observado más arriba, en qué modo el lenguaje por su naturaleza lineal o descriptiva nos obliga a realizar dicotomías, para exponer como separado, aquello que en realidad es concomitante. Todo lo que hemos expuesto hasta aquí, aparece por cierto como una operación que inviste únicamente el subsistema familiar. En realidad no es así, en cuanto nuestro análisis inviste el supra sistema familia-terapeuta. Veamos por cierto que los terapeutas retirándose inmediatamente, después de la intervención, y suspendiendo la interacción con la familia por un tiempo tratado, y por ellos establecido realizan una operación fundamental que les concierne inclusive a ellos: salen ellos mismos materialmente del supra-sistema. Sobreviene así que la intervención terapéutica, que ya de por sí había descolocado a los miembros de la familia, de su colocación usual, con motivo de las distintas posiciones ocupadas, de los distintos miembros en el sistema familiar mismo, viene potenciado por otra descolocación, esta vez material: los terapeutas cesan de jugar con la familia y salen concretamente del sistema por un cierto tiempo. ¿Cómo reaccionan ante esta descolocación de los terapeutas? ¿Podemos decir con Ashby que la descolocación material de por sí no es suficiente para romper el sistema si contemporáneamente no tiene lugar la introducción en el sistema de constantes no funcionales respecto a su circuito? Nosotros identificamos tales constantes en la calidad de nuestras intervenciones se debe pensar en un ritual repetitivo a un comentario paradójal, consignado por escrito a una prescripción sistémica. Esos permanecen invariables en ausencia de los terapeutas. La presencia de constantes afirma Ashby puede romper en pedazos un sistema. Qué el sub-sistema familiar advierta esto como un riesgo gravísimo para la homeostasis, está demostrado por las retroalimentaciones arriba referidas. Descolocados por los terapeutas, los miembros de la familia advierten agudamente el riesgo de un cambio en las uniones recíprocas. Imprevistamente ninguno sabe más, como reaccionarán los otros al "disturbio" introducido por los terapeutas. Cada uno se siente solo, separado de los otros

por una especie de barrera. Más allá de ella está lo desconocido. Al mismo tiempo, ninguno se atreve a metacomunicarse con los otros sobre todo lo que ha acaecido. La experiencia nos ha demostrado, como los miembros de la familia no discuten o debaten, bien poco entre ellos los comentarios o las prescripciones de los terapeutas. Interrogados a propósito en la sesión siguiente mostrarán, confesarán un silencio persistente. Alguno podrá referir alguna descalificación o cualquier comentario sarcástico de otro miembro delante nuestro. Por lo tanto advertido el peligro del cambio, está presente la resistencia, poder entrar lo más rápido posible en interacción con los terapeutas, descalificar, confundir, neutralizar la intervención. Todo lo expuesto hasta aquí permite formular algunas reflexiones conclusivas. La primera de éstas, se refiere al tiempo necesario del supra-sistema familia-terapeuta, para efectuar un cambio. Nos parece que podemos afirmar que tal tiempo es en primer lugar una variable funcional de la calidad de la intervención terapéutica. Intervenciones "centradas" pueden reducir enormemente el tiempo que un sistema familiar espontáneamente emplearía para lograr cambio. Pero existe todavía otro aspecto que excluye el apuro. Un sistema exige un cierto lapso de tiempo para desarrollarse, como respuesta a una intervención "centrada", como vértice de retroalimentaciones que constituyan un cambio observable. Y por otro lado solo un cambio observable otorga a los terapeutas, la información necesaria para la construcción de una hipótesis ulterior y por lo tanto de una intervención ulterior.

Estamos todavía bien lejanos de poder establecer con exactitud, caso por caso, cuál es el intervalo óptimo entre una intervención terapéutica y la sesión sucesiva. En la práctica usamos distanciar las sesiones por cerca de un mes. Muy raramente hemos abreviado dicho intervalo. Más a menudo y siempre después de haber lanzado un desafío paradójico, lo hemos alargado a más meses, en algún caso hasta un año, con resultados positivos (4). Tal resultado parece confirmar la hipótesis formulada en la premisa.

La interacción en los sistemas rígidos: Un modelo de intervención en la familia con paciente esquizofrénico.

MAURICIO ANDOLFI
PAOLO MENGHI
ANA MARIA NICOLO
CARMINE SACCU

Miembros de la Sociedad Italiana de Terapia Familiar.

Este artículo representa la primera elaboración que forma parte de un proyecto quinquenal de estudio sobre la intervención en sistemas rígidos con particular referencia a familias con paciente esquizofrénico.

Nuestro trabajo ha sido iniciado hace dos años como parte de los programas de investigación de la Sociedad Italiana de Terapia Familiar y se ha desarrollado en el Centro de Estudios de la Comunicación en los Sistemas de Roma.

Sistemas flexibles y sistemas rígidos.

Las hipótesis de este artículo presuponen una evaluación del grupo familiar como "sistema de relación abierto" en interacción dialéctica con otros sistemas.² Como cada organismo intrínsecamente activo sus procesos pueden modificarse, estándole así permitido, "autogobernarse" mediante reglas peculiares que se desarrollan y se modifican en el tiempo y "adaptarse" a las exigencias

de los diferentes estadios del propio desarrollo.⁷ El doble proceso de continuidad y de crecimiento está asegurado por el equilibrio dinámico entre dos funciones propias de cada sistema, tendencia homeostática (H) y capacidad de transformación. (T)

Por lo tanto el grupo familiar para modificarse debe cambiar la relación existente entre homeostasis y transformación a favor de esta última. Para estabilizar y mantener la estructura sucesiva deberá en cambio desequilibrarse la misma relación H-T a favor de la primera. Cada cambio y cada reasentamiento serán entonces precedidos siempre por un desequilibrio temporario en esta relación. Tal desequilibrio resulta tan considerable cuanto significativo haya sido el cambio y la consiguiente estabilización.

La posibilidad de cambiar en el tiempo el equilibrio existente entre homeostasis y transformación cambia en cada sistema y es por lo tanto objetivamente cuantificable. Existen sistemas en los cuales la capacidad de cambio y la de mantenimiento se alternan con mucha facilidad y sistemas en los que esto resulta particularmente difícil. Podemos así distinguir los sistemas familiares en "Flexibles" o "Rígidos", colocándolos en los dos extremos de una escala que va desde un máximo a un mínimo de flexibilidad.

Concretamente un sistema familiar es tanto más rígido cuanto más incapaz resulte para reencontrar nuevos equilibrios con las variaciones de su ciclo vital. Los momentos de ruptura potencial del equilibrio preexistente coinciden con los procesos normales de desarrollo del sistema familiar: crecimiento individual, unión, nacimiento, envejecimiento, muerte, etc. Flexibilidad o rigidez de un sistema no son por lo tanto características intrínsecas a su estructura, sino que aparecen ligadas al dinamismo y a las variaciones de estado en un "espacio" y en un "tiempo definido". Un sistema flexible en el estadio A puede tornarse rígido en el estadio B, etc.

Si el parámetro temporal nos informa sobre el ciclo de desarrollo del sistema y por lo tanto sobre su evolución histórica, el espacial nos proporciona los elementos para evaluar en el aquí y ahora las relaciones entre los miembros del mismo y su nivel de crecimiento y diferenciación individual. La familia tiene que estar entonces en condiciones de mutar en el tiempo los equilibrios entre las "funciones" desarrolladas por sus miembros (estado de cohesión) y el "crecimiento" de cada uno de ellas (estado de diferenciación).

Un sistema familiar se torna rígido cuando un cúmulo de funciones o la incapacidad de mutarlas en el tiempo pesan sobre las necesidades de diferenciación de sus miembros. Desde la reducida expresión del propio yo, causado por niveles crecientes de función se estructuran relaciones rígidas que conducen a una progresiva compresión de las energías disponibles y a un empobrecimiento de la comunicación con el afuera.

En el interior del grupo familiar se instaura de este modo una red intrincada de funciones que se refuerzan recíprocamente y que cristalizan las relaciones en roles estereotipados, en detrimento de experiencias-informaciones nuevas y diferenciadas, vividas como demasiado amenazantes para el equilibrio familiar. La consecuencia es una confusión creciente entre "espacio personal" y "espacio interaccional" de cada individuo, o sea entre el lugar de definición del propio ser dentro de sí y el lugar de los intercambios negociados con el afuera.⁽¹⁾

Esta confusión generalmente es atribuida únicamente al portador de un trastorno mental. En realidad una grave sintomatología psiquiátrica permite a cada uno introducirse en el espacio personal del otro con fines "altruistas" si no directamente "terapéuticos", con el resultado último de un vacío creciente, constantemente negado, del propio espacio personal y de una reducción masiva de intercambios libres (o sea no motivados por el comportamiento "loco" de un miembro): esta carencia se acrecienta en el tiempo permitiendo a contenidos y necesidades sustituir una tras otras aquellos que serían personales.

El vacío personal es así colmado, en una suerte de círculo vicioso, por el rol, determinado por la imagen familiar de la función de cada uno. ⁽²⁾

El espacio personal se reduce y el espacio interaccional se vuelve rígido.

Una situación de este género parece particularmente evidente en

(1) Cualquier espacio, incluyendo el personal, es un espacio que se define y se construye con referencia al otro.

(2) En esta óptica el rol puede ser considerado como la codificación social de la función de cada miembro del sistema.

las familias con paciente designado esquizofrénico, que presentan claramente los límites de flexibilidad que hemos descripto.

Un modelo de intervención: desarrollo de una estrategia.

La diferenciación de sistemas familiares en rígidos o flexibles nace de una exigencia terapéutica y del presupuesto de que la rigidez sea un componente de la patología y un obstáculo para la intervención; es necesario por lo tanto definir cómo se manifiesta concretamente esta rigidez durante la terapia.

Debemos partir de la premisa de que el sistema observable no es el familiar en sí mismo, sino éste en la interacción con el terapeuta.

El "sistema terapéutico" así compuesto está en vías de formación y se dará dinámicamente una estructura cuyas reglas serán definidas en el curso de la terapia.

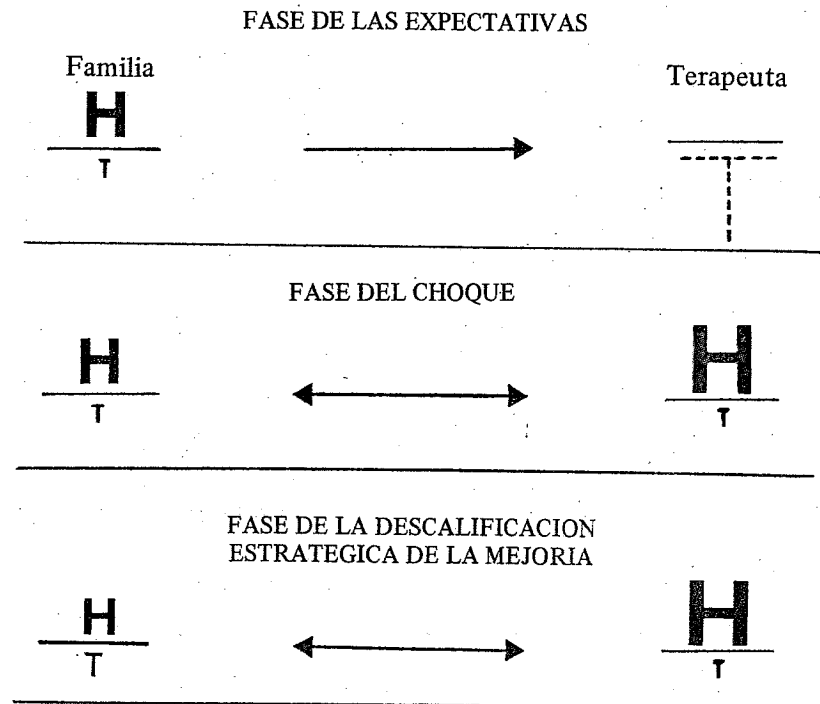
En nuestro trabajo hemos observado que algunas familias interactúan con el terapeuta en modo tal como para atraparlos en la lógica de las propias relaciones, con mayor intensidad que otras. Asistimos entonces a la formación de sistemas terapéuticos "igualmente rígidos" porque incapaces de variar la relación H - T y por ende de modificar en el curso de la terapia sus propios equilibrios. Nuestro objetivo será entonces el de prevenir la formación.

Si el terapeuta interviene en una familia en la cual la capacidad de transformación ya está libre y disponible, o sea cuando la tendencia a una rigidez homeostática no es preponderante, las dos "T", la del terapeuta y la de la familia, se integran fácilmente y se potencializan permitiendo una rápida solución del problema. Si la T del terapeuta en cambio activa un sistema familiar cuya T está sofocada por una rígida reglamentación interna, la T terapéutica será percibida como una gran amenaza y terminará por ser enjaulado en la homeostasis familiar.(4) Cuanto más el terapeuta intente abiertamente contrarrestarla, más el sistema familiar reaccionará para reforzar la estabilidad. Estabilidad extremadamente defendida, también sufrida, en cuanto conservadora de soluciones interactivas consideradas como las únicas posibles, lo mejor que los componentes de la familia puedan obtener, después de años de transacciones seleccionadas a través de un largo proceso de búsqueda y errores.

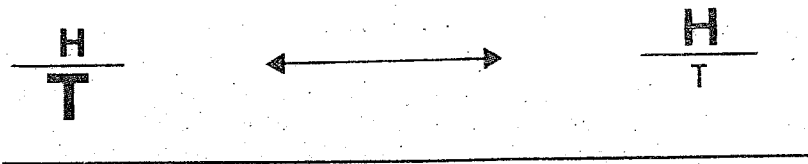
En estos casos el terapeuta puede favorecer el cambio, ya sea

utilizando su propia T, camuflándola de H y secundando así la H del sistema familiar hasta el punto de prescribirla (1) y de sugerir una potencialización. La familia no pudiendo contrastar la T del terapeuta, ahora sintónica con la H familiar, se verá constreñida a cambiar, es decir a liberar la propia T para demostrar al terapeuta que se equivoca al confirmar la tendencia a no cambiar.

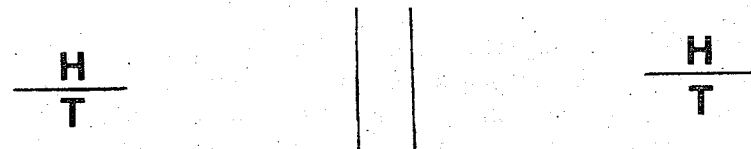
En nuestra investigación hemos intentado aplicar esta metodología de intervención que se articula en las cuatro fases fundamentales, sintetizadas en el esquema siguiente. Después de cada fase transcribiremos a título de ejemplo algunos fragmentos de sesión con un sistema familiar rígido (el diagnóstico precedente había sido de psicosis esquizofrénica) observado longitudinalmente en su evolución.



FASE DE LA VERIFICACION DE LA NUEVA ESTRUCTURA

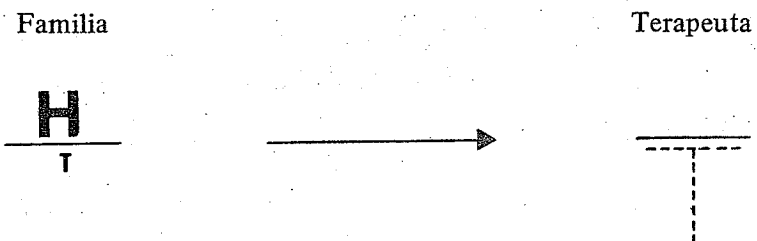


FASE DE LA ESCISION DEL SISTEMA



El esquema evidencia lo que ocurre entre tendencia homeostática (H) y tendencia a la transformación (T) en la relación familia-terapeuta, durante el proceso terapéutico sintetizado por nosotros en cinco fases. La primera fase no forma parte de la terapia propiamente dicha, pero la precede; intenta representar la actitud del sistema familiar en función de la próxima intervención.

FASE DE LA EXPECTATIVA TERAPEUTICA

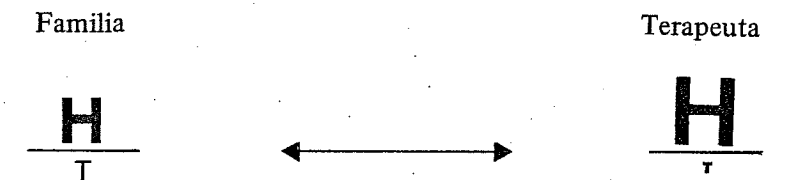


El terapeuta será quién nos dirá que hacer para cambiar, sin cambiar nada.

El pedido de terapia por parte de la familia con paciente esquizofrénico corresponde habitualmente a un momento de crisis, en la cual el sistema familiar permite la amenaza de una descompensación en los propios equilibrios. El peligro de una modificación incontrolada del propio status corresponde a la previsión de un cambio real, que si bien deseado, es obstaculizado por todos por ser demasiado amenazante. La terapia asume por ende el mismo significado de peligro propio de los momentos de ruptura potencial de los equilibrios preexistentes en los que el sistema familiar se encuentra durante su "ciclo vital".

Por lo tanto las expectativas de la familia tienden a reconstituir la estabilidad del sistema con la ayuda del terapeuta. La familia se acerca a la intervención con una percepción de menor estabilidad, pero justamente por esto, más determinada a mantenerla. En el momento del pedido terapéutico presenta una rigidez mayor de la habitual y reclama al terapeuta una tarea imposible: "hacer cambiar una situación dentro de las mismas reglas de relaciones que la han mantenido en el tiempo". La experiencia clínica nos muestra que esta doble expectativa de la familia está destinada a empujar al terapeuta a trabajar para la curación de un grupo compacto que opera para demostrar la inutilidad. Le formará así un sistema terapéutico rígido en el cual la misma dinámica interaccional entre terapeuta y miembros de la familia se estabilizará en roles y funciones siempre más estáticas y previsibles.

FASE DEL CHOQUE



Provocación

Contraprovocación

Ayúdanos aunque no puedas ayudarnos porque es imposible.

Si, los ayudo no ayudándoles.

La familia pide la ayuda del terapeuta para obtener una transformación del paciente designado que, por definición de todos (incluido el paciente) es incapaz, por cuanto loco, de cambiar. Lo prueban todos los intentos fallidos hasta ahora.

El terapeuta se muestra dispuesto a iniciar la terapia "negándose como agente de cambio": no solo se muestra de acuerdo con la familia declarando la imposibilidad de cambiar la situación, sino que señala la necesidad de mantener el "statu quo". Provoca el sistema familiar propio sobre la valencia homeostática, redefiniendo positivamente y "reforzando la función" de la sintomatología actualada por el paciente designado.

El gran acuerdo que habitualmente encubre cada divergencia en el interior de estas familias es que el enfermo, la persona que debe curarse es solamente él: el paciente designado.

El ha sido "llevado" a terapia porque no se le reconoce, por estar loco, ningún poder de decisión, ni él lo reivindica. Su comportamiento en las sesiones parece constantemente vuelto a reforzar tres aspectos fundamentales que la familia entera muestra al terapeuta: la centralización absoluta sobre la sintomatología del paciente que ocupa el universo de la familia, la imposibilidad de atender a todas sus comunicaciones (también las más banalmente congruentes), la consecuente inutilidad de los esfuerzos hechos tanto en el seno de la familia como fuera de ella para modificar su comportamiento.

Sobre la base de esta situación el sistema familiar formula su propio requerimiento: "ayúdanos a curarlo; indicando qué tenemos que hacer para volverlo a la normalidad". No ver la incongruencia entre un pedido de curación y una definición más o menos explícita de la irrecuperabilidad significaría caer en el juego homeostático que determina el mantenimiento del paciente designado en su función de enfermo, tanto central cuanto pasivo, tan importante como inatendible. Como es posible curar una persona que unánimemente es definida como incurable? Si no reparamos en la comunicación paradójica que nos envían y aceptáramos abiertamente un rol terapéutico, antes o después la irrecuperabilidad del paciente se convertiría en el punto de choque entre dos facciones: por una

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

parte el terapeuta empeñado en forzar el sistema hacia un cambio real, por otra el resto de la familia intentando demostrar su propia buena voluntad y la falla del terapeuta.

La exclusión total del paciente confirma su diferenciación.

Hemos intentado entonces considerar como "provocativo" el mensaje enviado al sistema familiar e imaginar una intervención estratégica que constituyera la "respuesta".

La primera respuesta "contraprovocativa" consiste en utilizar como punto de ataque del sistema al mismo paciente designado que se convierte, de algún modo, en la puerta de entrada a la familia. Aquel que por definición es incapaz de actuar activamente un comportamiento adecuado y autónomo es directamente confrontado con el terapeuta en un abierto desafío basado sobre la "negociación estratégica de su comportamiento anormal". Si el terapeuta logra crear un contexto en el cual el comportamiento ilógico e involuntario asume un significado lógico y voluntario, el sistema familiar comenzará a desequilibrarse reduciendo su rigidez. Para obtener este resultado el terapeuta deberá convertir en banal cada intento del sistema de presentar la situación como gravemente patológica. Si la enfermedad es el regulador del sistema rígido alrededor del cual circulan y se integran perfectamente roles y funciones familiares, ella será negada y en consecuencia el cambio deberá ser presentado por el terapeuta como algo temible: el choque será entonces inevitable; pero será un choque que mostrará paradójicamente al terapeuta en una posición más rígida que la de la familia, tal como para poner en crisis el estilo transaccional de esta última. (9)

En esta primera fase el ataque al sistema consiste en privar al paciente de su habitual control sobre todas las relaciones familiares, que dirige en virtud de su comportamiento loco.

Si éste es redefinido (3) como lógico y voluntario, y la función de controlador oficial de la familia sostenida porque indispensable e insustituible (ningún otro miembro de la familia sabría desempeñarlo tan bien), el sistema se verá privado de su propia coartada para continuar un juego de relaciones que necesita un chivo expiatorio para evitar la confrontación. Tal provocación por una parte quita al paciente el poder de desempeñar el rol de "centinela" oficial del sistema, que por otra parte lo revaloriza como persona capaz

de autodeterminarse. Es realmente la contemporaneidad "del ataque a nivel de función y de sostén a nivel del yo" que permite al paciente aceptar la provocación del terapeuta, porque es advertida como un empujón para reproponerse de una manera más auténtica en el seno de la familia.

Redefiniendo positivamente la locura el terapeuta llega a "negar estratégicamente la terapia", por ser demasiado peligrosa para el equilibrio familiar tan bien consolidado en el tiempo. El refuerzo homeostático —"es mejor no cambiar"— resulta imprevisible e inesperado para quienes esperaban un terapeuta dispuesto a hacer todo lo posible para obtener lo imposible.

De aquí las primeras reacciones tendientes a demostrar al terapeuta que se equivoca creyendo que el paciente designado puede comportarse de modo lógico, voluntario y útil para la familia. La teoría sucesiva, ostentada en muchos casos, constituiría la prueba. Si el terapeuta se mantiene consecuente con la línea estratégica, redefiniendo también el empeoramiento como confirmación de la lógica, voluntariedad y utilidad del comportamiento del paciente, tendrá acceso al interior de un sistema familiar donde será posible explorar nuevos espacios y nuevas funciones.

Intentaremos ilustrar cuanto se ha dicho avalándonos en las sesiones terapéuticas efectuadas con una familia con paciente designado esquizofrénico. La misma fue seguida en el curso de 23 encuentros inicialmente semanales y sucesivamente quincenales, por un equipo integrado por los cuatro autores, de los cuales uno estaba directamente a cargo de la sesión y los otros tres observaban detrás del espejo unidireccional. Las sesiones han sido registradas en video.

(3) El comportamiento sintomático, habitualmente considerado como expresión de sufrimiento del individuo y de los otros miembros del sistema familiar, tiene aún indudables ventajas para uno y para otro. El error que a menudo se comete es el de subestimar el enorme poder del síntoma que por su característica de involuntariedad permite a quien lo presente definir y controlar la relación con el otro. El síntoma es así prisión e instrumento de poder al mismo tiempo.

La familia Fraioli llega a nuestra observación después de años de intervenciones infructuosas efectuadas en repetidas ocasiones y con varios métodos. El núcleo familiar vive en una pequeña ciudad del norte de Italia y tiene un nivel socio cultural medio-burgués; el padre, médico, es un hombre severo con una educación rígidamente católica y sexofóbica; la madre, ama de casa por deber y convicción, gesta subterráneamente un rol dominante en la organización de la vida familiar. Una gran diferencia de edad separa los padres, entre ellos y con los cuatro hijos: tres varones y una mujer, la más joven. En la casa, con los padres vive solamente José, el tercer hijo, que es el paciente designado. José tiene 28 años, desde hace algunos años tiende a aislarse cada vez más, a tal punto que ya no sale de casa. El alejamiento progresivo de la realidad externa, la depresión, la agresividad gestada dentro de su casa, son imponentes y culminan en preocupantes crisis de agitación psicomotriz y, a veces en graves intentos de suicidio. El joven ha abandonado ya la esperanza de trabajar a pesar de una diplomatura en Leyes obtenida brillantemente y pasa el tiempo en su cuarto o dando vueltas en la casa, perseguido por fantasías sexuales y de muerte; se masturba ostentosamente con prendas íntimas de la madre a la que ha manifestado el deseo de tener relaciones sexuales con ella.

La vida de la familia está "dominada por la enfermedad" de José.

Han transcurrido apenas 10 minutos desde el comienzo de la primera sesión. Presentes el padre, la madre y el paciente designado.

José, sentado entre los padres, aparece muy tenso y con una mirada casi carente de mímica fija al suelo mientras los padres hablan de él.

T. (volviéndose hacia el padre)
Quisiera lograr entender que ocurre en José porque yo me sentiría muy incómodo en su lugar.

"El terapeuta interpreta y explícito los mensajes no verbales que José envía. La actitud de éstos en otros contextos interpretado como incongruente, es "leído" por el terapeuta como manifestación de un estado de ánimo plausible. El terapeuta demuestra interesar-

J. No me siento para nada incómodo.

La interacción en los sistemas rígidos

T. Pero en este momento pareces muy incómodo...también como estás ubicado...

J. Ahora estoy enculado.

T. mmh...digamos enculado...respecto a estar aquí?

J. (con tono más decidido) No, estoy enculado porque las más son todas putañerías, no necesito ser conmisero por nadie, no necesito ser ayudado por nadie por mis putañerías, puedo arreglármelas muy bien por mi cuenta...

T. Dame un ejemplo de putañería; porque en Roma tal vez el modo de usar este término es diferente de aquel de tus pagos... puede ser que tú hables de cosas diferentes de las que puedo imaginar yo.

J. (con aire provocativo) Yo quisiera culear a las mujeres, pero nunca hice nada.

T. Quisieras?

J. Culear...Pero nunca hice nada.

T. O sea nunca has culeado o nunca tuviste relaciones sexuales?

J. Relaciones sexuales a veces tuve... pero solamente con ciertos métodos... De cualquier modo siempre con prostitutas.

T. "Beh", esas están más dispuestas, no? dónde está el problema?

se por el paciente como persona, por sus sentimientos y por cuánto dice más allá del síntoma".

"El paciente contesta de manera provocativa en las confrontaciones del terapeuta mientras los padres asumen la actitud preocupada dolorida y resignada de quien tiene un hijo enfermo mental"...

"El terapeuta no se retoma frente al lenguaje provocativo de José, por el contrario fija la atención y la vuelve a proponer. La tranquilidad con que es retomada y analizada la frase del joven confiere una connotación de normalidad a su comportamiento".

"El terapeuta insiste por obtener respuestas precisas y concretas tornándose menos original la actividad de José. Esto quita poder al paciente designado y dramatismo al contexto.

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

Hablo de culear...

J. (sorprendido) cómo dice?

T. Quiero decir, son más dispuestas de hecho no? En el fondo tienen una percepción más suelta del propio cuerpo. Tuviste problemas en este caso?

J. No.

T. No entendí donde está la putañería, si no en el sentido literal de ir por putas, pero no entendí que querías decir con esto...puedes explicarme un poco mejor?

J. Tengo una suerte de vergüenza por la que me inhibo, me inhibo siempre.

T. O sea te inhibes en el deseo de culear o en el tener relaciones sexuales más amplias, esto no me resulta claro.

J. Yo hice este año, tal vez también el año pasado algún pedido tan extemporáneo a alguna mujer con resultados constantemente negativos.

T. Sí, pero cual es la putañería? No está claro.

M. (con voz persuasiva) Puedo...

T. (a José) Me dijiste que estás enculado por tus putañerías...creo hay una infinidad de jóvenes de tu edad que desean culear mujeres, no veo donde está... porque eres tan especial; o querrías una superculeada... una cosa muy espe-

"La redefinición implícita del comportamiento incongruente, aceptado como normal, resulta contraprovocatoria para el paciente designado y su familia. A ella José responde con sorpresa".

"Privando a José del sostén de los familiares se le permite confrontarse directamente y explorar nuevos espacios. Esto quita poder al paciente designado y dramatismo al contexto".

cial...entonces tal vez sea esto que te hace estar mal.

J. Yo pienso que hay una cosa que yo no podré obtener nunca.

T. De tí mismo o de las mujeres?

J. Cómo dijo?

T. De tí mismo o de las mujeres?

J. De las mujeres.

T. Estás realmente seguro?

J. Pienso que sí.

T. Porque por como hablas parece que tuvieras problemas contigo mismo.

Después de la intervención sucesiva del padre y de la madre tendientes a subrayar la gravedad del comportamiento de José, el terapeuta comenta:

T. No llego a entender...Uds. hicieron un larguísimo viaje en tren, durmieron en Roma para venir aquí. Si el problema es el de culear, se me escapa la gravedad de la situación.

P. Pero por este problema ha llegado al suicidio.

T. De acuerdo, pero por el momento me faltan los detalles, no me parece un problema digno de tanta atención, de tantos profesores.

“El contexto resulta ahora absolutamente adecuado; la diferencia entre ‘el distinto’ y los otros pierde progresivamente consistencia”.

“El terapeuta niega explícitamente la enfermedad”.

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

Los padres comienzan a referir numerosos episodios para esclarecer el curso de la locura de José. El terapeuta interrumpe y retoma la provocación sobre el joven:

T. Espere un instante señora, porque José está todavía enculado y yo no logro trabajar con una familia en la que hay un hijo de... cuántos años? (vuelto hacia José).

J. Veintiocho.

T. De veintiocho años. Si tuvieras diez años podría aceptar que estuvieras aquí, en silencio, con aire enculado mientras tus padres hablan de tí, pero dado que tienes veintiocho no puedo aceptarlo, por lo que o tenemos que interrumpir o es necesario que hablemos del motivo por el cual estás enculado.

J. Mi estado emotivo depende...

T. Tal vez debo explicarte mejor: una persona puede estar deprimida, preocupada, triste, pero si está enculada seguramente no colabora. Entendido lo que quiero decir? Este es el punto que me preocupa, si estás enculado no puedes ayudarnos. Tal vez papá, mamá y yo, si cualquiera de nosotros estuviese enculado no podría ayudarnos... Si no enfrentamos el problema del enculamiento, no puedo continuar.

Hasta tuve que interrumpir a mamá que me estaba hablando de lo que sucedió en el '72...Puede ser que estés enculado conmigo...

“El terapeuta impide que los familiares repongan a José en la designación del paciente. El ha circunscripto su punto de

“El no aceptar mantener al paciente designado en el rol especial de enfermo para proteger significa no poder siquiera aceptar su silencio. El terapeuta define entonces voluntario el silencio de José como cada uno de sus niveles de participación en la sesión. El esquema - ataque al síntoma, sostén de la persona, será constante para toda la terapia”.

“Es un mensaje preciso para José y el resto de la familia: “aquí es necesaria la colaboración de todos”.

J. (con voz animada) Si, tanto es así, que mientras esperaba para venir a verlo decía: "ahora tengo que ir a lo de ese hinchapelotas".

T. Me gusta porque dices las cosas con las palabras justas, eres espontáneo!

J. Y sí, total...

T. Pero yo quiero entender una cosa muy pequeña... porque estás enculado aquí, hoy.

J. Porque me había hinchado las pelotas?

T. Si, justamente esto.

J. Porque ya esta situación es un peso, un peso tremendo, yo estoy hinchado, estoy enculado, como una bestia porque... por ejemplo, yo rompo continuamente las pelotas a mis padres...cosa que naturalmente no hago en las confrontaciones de mis hermanos y hermanas porque claramente tengo miedo que ellos me tomen por zonzos...entonces no lo hago.

T. Un momento, he entendido todo hasta cierto punto, después no entiendo más porque según mi punto de vista no te tomarían por tonto sino que te mandarían al diablo.

J. Sí.

T. Es diferente a tomarte por zonzos.

J. Por zonzos y contemporánea-
Terapia Familiar, 4, 1980

"José retoma la provocación..."

"Y el terapeuta la redefine positivamente".

"El terapeuta vuelve a estimular la confrontación directa y concreta con el paciente designado".

"El terapeuta va más allá del lenguaje del paciente, cuyo comportamiento está así implícitamente redefinido como adecuado. Inicia aquí la diferenciación entre el comportamiento protector de los padres que presuponen la existencia de un enfermo y el comportamiento reactivo de los hermanos que presuponen el voluntarismo y la responsabilidad de lo que José dice o hace".

mente me mandarían al diablo.

T. No, pienso que te mandarían al diablo porque no les viene bien considerarte tonto.

Esta es una gran diferencia con tus padres que te protegen porque están preocupados y temen que seas un tonto, por lo que no pueden mandarte al diablo.

J. Como dijo, ahora, mis padres temen...?

T. Tus padres en el fondo están preocupados porque no eres capaz de ser adulto, de ser autónomo y piensan que si te mandan al diablo empeoras.

Traemos algunos pasajes de la sesión sucesiva que nos informan de las reacciones familiares.

M. Usted probablemente no fué informado pero después que estuvimos aquí el martes pasado, José los días siguientes...miércoles, jueves, viernes, estuvo peor que antes, siempre mal dispuesto, encerrado en su cuarto.

P. En el aislamiento...Díganos usted.

M. Estaba mucho en casa, tirado en la cama, nosotros estábamos todos preocupados, hablamos con el profesor X sobre la posibilidad de mandarlo a su clínica un tiempo.

J. A la clínica me llevé el código, el librito de procedimiento penal, también buscando de estudiar algo porque ahora para fines de octubre debería jurar como practicante procurador legal y en aquel período

"Es interesante notar como el mismo José tiende a adornarse con una definición de patología".

"El terapeuta no ataca directamente a los padres, destaca como su protección, su estigmatización de José como paciente nace del amor y de la preocupación.

"La familia ostenta, como previsible una gran teoría atribuida a la sesión anterior. El mensaje es claro, "esta terapia no sirve, más aún es perjudicial, pero..."

"...ayúdenos lo mismo".

"Contemporáneamente emerge un comportamiento verdaderamente autónomo de José: pensar en los exámenes, en su futuro laboral como abogado. Es evidente el absurdo implícitamente destacado

evidentemente pensaba continuar desarrollando actividades con mi hermano que es abogado.

T. No entendí quien piensa que en esta situación estés mejor en la clínica?

J. A mí me formula la pregunta?

T. Sí porque tengo la sensación de que tú quieres mostrar que a tu familia le gusta descargarse de tí, mientras en cambio me parece una manera tuya de obtener la victoria de Pirro.

J. O sea en qué sentido, disculpe?

T. Hacer quilombo, querer entrar a la clínica para hacer quilombo, está claro, no?

J. Pero quilombo de qué modo?

T. Quilombo en el sentido de que los padres deben ir, telefonar, ocuparse de un montón de cosas...Estar siempre alrededor tuyo...

J. Pero yo pienso que ellos están igualmente preocupados también cuando estoy en casa, tanto es así que muchas veces...

T. No proyectes sobre ellos.

J. Mi madre muchas veces me dijo que esta situación no se puede soportar.

T. No proyectes sobre mamá...eres tú quien has elegido ir a la clínica.

por José, desde un refugio por él planificado a final de un período normal de estudio".

"El juego está siempre mantenido directamente sobre el paciente designado".

"El terapeuta acentúa la voluntariedad de la hospitalización de José.

Es José el que ha elegido entrar a la clínica, no porqué esté enfermo sino para catalizar la atención de los demás hacia él.

"El terapeuta continúa su operación llevada a privar al paciente del control sobre las relaciones familiares y a impedir a estos últimos invadir los espacios del paciente".

"Le remarca el voluntarismo del comportamiento de José.

J. No es que haya elegido, realmente yo no quería ir, pero de tanto romperme las pelotas, mi hermano y mi primo me han hecho ir.

T. Sabes, yo estoy dispuesto a aceptar tu no colaboración, lo tomo en cuenta, pero la otra vez me pareciste más espontáneo.

J. En qué sentido está dispuesto a aceptar mi no colaboración?

T. En el sentido de que tú juegas el papel de aquel que debe ser sostenido con muletas y hacer jugar a tus padres el papel de aquellos que lo tienen que convencer para que se porte bien...hasta quieres insinuar que deben sentirse con culpa por tu comportamiento.

Al momento Uds. (vuelto hacia los padres) me parecen muy alarmados por el recato de José, que busca matarse, si no le están suficientemente alrededor.

Entonces pienso que no es posible ensayar una terapia familiar a menos que Uds. no modifiquen nada de una situación tan sopesada, sobre lo que están los tres de acuerdo.

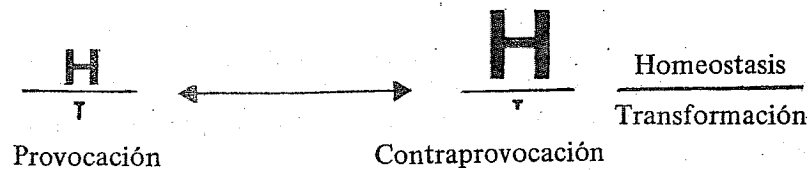
"El terapeuta afirma, de una vez por todas, que, como en un juego de las partes, cada miembro de la familia tiene su propio rol y una función propia que se integran recíprocamente. Por esto el cambio es algo temible; por esto la terapia puede ser muy peligrosa a menos que no se alinee en favor de la homeostasis del sistema, lo que equivale a una negación paradójica de la terapia: "Hago la terapia para no hacerla".

El terapeuta, impidiendo cada intento de réplica, se levanta, saluda a la familia y cierra la sesión.

FASE DE LA DESCALIFICACION DE LA MEJORIA

Terapeuta

Familia



Sigue mejor (analógico) pero sigue peor (verbal). Tu ayuda no sirve, pero ayúdanos más.

"Sigue peor de lo que piensan. Si quieren mi ayuda, colaboren más a no cambiar nada".

El p.d. presenta sensibles mejorías negadas o definidas como peorías por la familia.

La disponibilidad a la intervención parece mayor, si bien esto es definido como contraproducente.

El terapeuta, percibida la mejoría, declara la situación notablemente empeorada para confirmar la propia tesis por la que nada puede y debe cambiar. Requiere un esfuerzo para mantener estable la situación "prescribiendo paradójicamente las reglas disfuncionales de la familia". En esta fase el choque en el interior del sistema terapéutico asume características diferentes respecto del estudio precedente. La familia actúa ahora en sesión una nueva incongruencia. No se presenta más como un frente único, por cuanto el paciente manifiesta sensibles mejorías negadas por los otros familiares, que además subrayan un empeoramiento en neto contraste con la evidencia de los hechos. La familia entonces por una parte señala progresos mediante el portavoz oficial y otra se encuentra en la imposibilidad de definir abiertamente la mejoría.

La prosecución de la terapia está implícitamente alentada por los familiares y en particular por los padres, tanto es así que ellos advierten que el terapeuta, por estar fuera del sistema, puede tener una confrontación directa y explícita con el paciente designado. Esto aparece vedado al interior del núcleo familiar porque requeriría confrontaciones nuevas y la modificación de reglas que disfuncionales en un nivel, protegen la integridad de la familia en otro nivel.

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

De tales premisas surge la estrategia terapéutica dirigida a reforzar pragmáticamente la mejoría a través de la descalificación: lo que está ocurriendo es redefinido como un empeoramiento de la situación, lo que confirma la tesis por la cual es mejor no cambiar nada.

Siguiendo esta línea la provocación terapéutica consiste en solicitar a la familia que mantenga estable la situación, justamente en el momento en que están produciéndose cambios. Esto podrá ser justificado haciendo entrever los peligros implícitos en el cambio. De nuevo el ataque al sistema se produce a través del paciente designado que ahora es desafiado respecto de su mejoría.

Paradójicamente el desafío tiene el efecto de reforzar la tendencia al cambio del sistema. Concretamente esto es actuado con tres intervenciones sucesivas entre ellas:

a) **La no aceptación oficial de la mejoría**, por parte del terapeuta, quien aparecerá inicialmente totalmente insensible a los primeros signos de cambio.

b) **La redefinición de la mejoría como peligrosa**. Hablar de los riesgos implícitos en el cambiar y activar en sesión fantasmas y miedos relativos, permite anticiparlos y hacerles perder su carácter destructivo, favoreciendo ulteriormente el cambio en acción.

c) **La prescripción del no cambio**. La prescripción cuidadosa de comportamientos tendientes a acentuar las reglas disfuncionales del sistema es presentada como necesaria para evitar un cambio demasiado peligroso (8). De este modo se sostiene paradójicamente la mejoría ya en acción y se estimula una cohesión nueva en el interior del grupo familiar. La familia debe ahora luchar para demostrar con hechos que está en condiciones de cambiar. José presenta en sesión un comportamiento mucho más activo y participa como de costumbre.

T. (A pocos minutos de iniciada la sesión) José quisiera preguntarte ahora si ha ocurrido algún problema esta mañana. Veo por tu rostro que estás... menos controlador que de costumbre.

"El terapeuta toma en seguida la iniciativa descalificando la evidente mejoría.

J. Qué quiere decir?

T. Menos controlador; que ha sucedido de nuevo?

J. Un poco de quilombo.

T. No, las cosas normales no me interesan yo entiendo de problemas grandes, cosas extraordinarias.

J. (sorprendido) No, problemas grandes no.

T. Entonces me equivoqué, pero...

P. Hubo una enorme dificultad para traerlo aquí, porque también esta mañana...

T. O.K., pero esto vuelve a entrar en la normalidad de la dificultad...yo tengo la sensación de que tú José estás menos controlador...

J. Qué quiere decir, no lo entiendo.

M. Me permito interferir pero tal vez el Doctor se refiere al hecho de que tú hayas explicado alguna actividad ajena a aquellas, verdad doctor...

T. Ud. señora tiene la condición del sexto sentido.

M. A este propósito deberías decir (vuelta hacia José) que lograste estar en la mesa dos, tres veces...

T. Eso, es justamente aquí que te siento menos controlador.

Terapia Familiar, 4, 1980

"El quiere ir más allá de las fantasías más negativas de la familia. Cualquiera cosa que los familiares digan a propósito de la mejoría estará siempre por debajo de las previsiones del terapeuta".

"El terapeuta continúa redefiniendo en términos preyorativos la mejoría".

P. También si después dijo que todo es inútil, que total no sirve para nada, lo dijiste inmediatamente después no? Que cometerías un acto autolesivo?

J. Yo sé muy bien que si un día me pusiera a hacer lo que hacen mis hermanos, lo lograría muy bien, pero tendría que renunciar a...

T. A la "función".

J. No sé a qué...debería renunciar a un mundo fantástico.

T. A la "función" y siento que eres muy ingenuo porque te ilusiones con que alguien pueda o quiera tener la "función" que tú desempeñas mejor que tú tal vez...Tienes algún nombre para sugerir?

J. Cómo dijo? No escuché.

T. No tienes ningún nombre para sugerir...alguien que pueda tomar tu lugar en casa, ocupándolo con la debida atención como lo hiciste tú?

El terapeuta continúa redefiniendo la diferente actitud de José como inoportuna y peligrosa para la estabilidad familiar. Concluye la sesión con una prescripción que tiende a reforzar en modo provocador las reglas disfuncionales del sistema:

— Los padres deben observar con extrema atención cada comportamiento anómalo de José en el curso del día y por la noche discutirlos juntos y transcribirlos minuciosamente en un cuaderno.

— José tendrá que permanecer siempre en casa durante las dos semanas subsiguientes sin modificar su comportamiento habitual.

"El terapeuta aclara finalmente, pone en guardia a José de la pérdida de la función que explica sobre la familia. Ser menos controlador significa en efecto alentar la vigilancia que el paciente ejerce sobre el sistema, en calidad de centinela.

Es evidente el aspecto provocador del mensaje terapéutico".

Cada comportamiento adulto sea voluntario o requerido por los padres deberá considerarse incorrecto, por cuanto representaría un intento de José de sustraerse a la propia función esencial en el interior de la familia.

— José por una parte y los padres por otra deberán garantizar la correcta ejecución del deber transcribiendo cada eventual incorrección — la sesión siguiente podrá tener lugar solo a condición de que cada uno presente el material escrito solicitado.

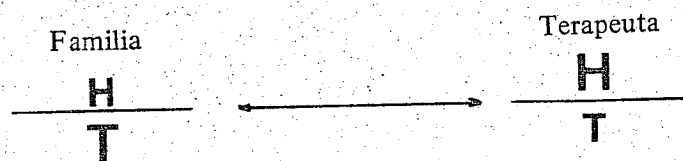
La redefinición de eventuales movimientos autónomos de José como incorrectos respecto de la función que desenvuelve en la propia familia, “fortalece” la alianza del terapeuta con la tendencia homeostática del sistema y le permite reproponerla mediante la prescripción del comportamiento sistemático del joven y de algunas reglas familiares.

Estas últimas están representadas por el control exasperado de los movimientos individuales que los padres y José ejercen recíprocamente. De este modo el terapeuta se propone explicitar la situación de esta familia sin amenazarla y aumentar la carga para cada miembro. Esta línea tiende a una mayor separación de los espacios generacionales y a una creciente autonomía individual.

A la sesión siguiente los padres y José se presentan con una serie de anotaciones escritas que expresan de distintas maneras el desacuerdo con el terapeuta en lo que respecta a la importancia de la “función” de José. El muchacho además fue algunas veces a visitar a un amigo y afirma estar cansado de la continua aprensión de los padres.

El terapeuta se declara muy resentido por la escasa colaboración con la terapia y por la ligereza con que José está disminuyendo la propia vigilancia.

FASE DE LA NUEVA ESTRUCTURA



Estamos en desacuerdo contigo porque en realidad las cosas están cambiando.

“No me fío. Confirmenme el cambio con hechos”.

La familia contesta la definición del terapeuta: “empeora y nada debe cambiar”, reivindicando activamente la mejoría.

Esto no solo se refiere al comportamiento del paciente designado sino que incluye la interacción del interior del grupo familiar.

El terapeuta se demuestra incrédulo frente los cambios estructurales puestos en acción por la familia. “Prevee los riesgos implícitos en la mejoría y se declara dispuesto a aceptarlos solamente después de la verificación” de realidades, nuevas en las relaciones sistémicas.

Ahora aparece más evidente la estructura familiar precedentemente oculta por comportamientos de encubrimiento; o sea que existe una mayor disponibilidad del sistema a manifestarse en la propia realidad relacional y a descubrir las tensiones internas. Resulta por lo tanto más fácil verificar las hipótesis formuladas precedentemente sobre el funcionamiento peculiar de la familia, sobre la composición de sus subsistemas, sobre la diferenciación de las funciones de sus miembros, sobre las características de los límites que los definen. (6). Es propio de esta fase la diferenciación progresiva del paciente designado en el interior de aquellos subsistemas en los cuales vive una realidad casi exclusivamente ligada a su función de enfermo.

La mejoría se revela ahora más manifiesta tanto a nivel de la sintomatología del paciente designado como de las modalidades interaccionales del sistema total. (Los dos casos indivisibles: la mejoría sintomatológica del paciente designado deriva de los cambios interaccionales y a su vez los provoca y los refuerza). En la mayoría de los casos la familia reivindica expresamente la mejoría o sea no permaneciendo espectadora sino sintiéndose activamente envuelta en ese movimiento que el terapeuta ha negado en la fase de la descalificación estratégica.

El progreso es evidente: desde el estado de mejoría efectiva pero negada, al de la reivindicación de una participación directa al movimiento ocurrido. Es del mismo modo evidente la temporaneidad y la fragilidad de un estadio que ve aquello sólo realizable en fun-

ción del terapeuta y de una suerte de desafío iniciado con él. Es decir que nos encontramos en una fase de **nueva anormalidad** que representa un paso adelante hacia una gestión autónoma de las propias incomodidades.

Si el proceso inicial de delegación ha sido suplantado por una activa participación de toda la familia, ello deriva de la posibilidad que ésta ahora posee de desequilibrarse hacia un cambio desde muchos aspectos amenazador, ella puede "prestar" las propias valencias homeostáticas al terapeuta que se ha convertido en responsable, aliviándolo de un gravoso peso. Ahora el terapeuta manifiesta una mayor disposición a aceptar los movimientos del sistema familiar, pero lo subordina a una **verificación concreta**: es decir que requiere un empeño que conduzca a resultados visibles de los cambios jactados.

Tal verificación es actividad durante las sesiones para ser después continuada en la casa. Es ésta una manera de reforzar concretamente el empuje hacia el cambio y una modalidad tendiente a amplificar al proceso terapéutico más allá de la hora semanal de encuentro. Si la familia estará en grado de actuar para el terapeuta modalidades nuevas de comunicación podrá simultáneamente experimentar las ventajas de los cambios entre sus miembros y aprender a funcionar autónomamente. Requerimientos concretos y específicos permiten en efecto trabajar sobre los riesgos y las dificultades implícitas en el cambio y profundizar el conocimiento de las dinámicas interaccionales que puedan funcionar como obstáculo ulterior al alcance de aquello que la familia se propone.

A medida que la estructura familiar se esclarece el terapeuta tiende a mostrar su incredulidad respecto de los requerimientos de cambio, subrayando las ventajas del estatismo y los riesgos de lo imprevisto. La intervención por lo tanto no contiene amenazas relativas a la homeostasis familiar, en todo caso representa un obstáculo para las instancias de cambio; justamente a través del proceso de desmantelamiento de estos obstáculos la familia se aproxima a una mayor autonomía para demostrar al terapeuta lo infundado de sus temores.

Podemos ahora valernos de un abordaje típicamente **estructural**, que permite la activación de nuevas confrontaciones entre los distintos subsistemas y a su interior.(5) Si tal abordaje resulta ahora

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

eficaz este deriva del hecho de que el sistema familiar ha perdido parte de su rigidez a cambio de una flexibilidad nueva.

Traemos a título explicativo algunos trozos de la 13ª sesión con los padres:

M. -Ahora me siente un poco cansada, molida entiende, entonces me he permitido en la incertidumbre un poco de sosiego.

P. Pero yo le puedo hacer la síntesis. En estos últimos tiempos, efectivamente José se ha movido... en casa no se ha quedado. Ha ido un poco a los tribunales con su hermano, se ha puesto a estudiar algo... se lleva libros.

T. Para niños pequeños?

P. No, libros de leyes... en efecto un intento de inserción ha tenido lugar. Es cierto que después si se le pregunta dice: "yo lo hago, pero estoy convencido que para mí todo está terminado, etc.", excepto que antes era coherente, en su postura absolutamente negativa, permanecía en casa, en cambio ahora si su hermano lo llama a Pretoría o a Tribunales va.

T. Yo no confío. Me sorprende que Ud. después de tantas experiencias confíe así ciegamente.

P. Yo no confío, yo le pregunto, lo refiero a Ud.

T. Yo le estoy diciendo que

"En esta fase de la terapia el padre es mucho más activo y responsable".

"La primera intervención del terapeuta es de incredulidad. El estilo es siempre provocador".

no me fío. Yo no esperaba mejorías hoy. A lo sumo mises en scène... o sea nada riesgoso para todos Uds.

M. Para mí, José está dando pasos hacia adelante.

P. Pero no ves que hace un instante el doctor dijo que aún no confía de este intento de inserción. Lo dijo él, dice "yo no confío" y puede darse que tenga sus razones, tanto es así que José mismo dice "tengo que ponerme a trabajar" y después dice "no lo logro".

M. A este punto debo responder una cosa: que desde el 15 al 26... yo aquí lo tengo anotado, han sido días transcurridos positivamente, ha frecuentado el estudio del hermano todas las mañanas y se ha quedado poco en casa.

P. ... no podemos fiarnos; de acuerdo, este muchacho podría hacer una tontería mañana, pero en efecto... entre otras cosas ha habido también un hecho positivo; José ha tenido un éxito en una causa y nosotros hemos llegado a saberlo por casualidad a través de los diarios... ni siquiera sabíamos que se estaba ocupando así. En fin pienso que aún no haciéndonos ilusiones como decía Ud. el mismo Franco (el hijo mayor) que está siempre duro y no se desequilibra nunca, ayer dijo a mi mujer...

"Ahora la mejoría es compartida explícitamente por ambos padres. Parecería que la incredulidad del terapeuta tuviera el poder de reforzar su convicción".

"Ahora parece que los padres intentaran convencer al terapeuta de la mejoría obtenida.

Dar crédito a sus argumentos podría significar un golpe de arresto en este esfuerzo familiar colectivo hacia la "curación"; la incredulidad del terapeuta es un punto firme, un momento reasegurador que permite al sistema desequilibrarse hacia cambios ulteriores".

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

M. Notaba que José se interesa más en su trabajo.

P. Notaba que había cierto interés.

T. No me fío de todo esto, es demasiado riesgoso. José no puede abandonar así su función. No me han dado garantías suficientes.

"El terapeuta hace comprender que sus propias reservas podrían disolverse solo si verificaran cambios más sustanciales".

A pesar de que el terapeuta haya mostrado fugazmente la posibilidad de cambios ulteriores, utiliza el resto de la sesión para proponer una inmovilidad absoluta en las recíprocas modalidades relacionales, evidenciadas en las sesiones anteriores. José en particular es firmemente invitado a mantener el rol de centinela, tan útil para todos y asumido con tanta abnegación. Esto lleva a un aumento de la tensión que el sistema expresa a través de José en la 14o sesión. Transcribimos la explosión final a la cual seguirá la ausencia constante del muchacho en las sesiones siguientes.

J. Esta ambivalencia sustancial de querer ir a lo de un psiquiatra y contar las propias putañerías, No!

A un cierto punto vayan todos al diablo, yo acepto mi vida así como es y no me rompan más las pelotas; en fin, caramba, yo no rompo las pelotas a los demás y que los demás no me las rompan a mí. Y estamos a la par!

T. Yo creo que José a su manera nos dice que esta noche no se siente como para lloriquear. Me complace. No esperaba esto.

La ausencia física de José en la prosecución de la terapia es juzgada positivamente por el equipo terapéutico por cuanto sanciona pragmáticamente un cambio notable en la estructura familiar; precedentemente entre José y sus padres, la madre en particular, no eran soportables distancias significativas mientras que ahora la constante participación de la pareja en la terapia es indicadora de una modificación importante. Simultáneamente se tienen noticias de un notable aumento de la autonomía de José. Después de algunas sesiones utilizadas fundamentalmente para consolidar las distancias adquiridas, el terapeuta envía una carta a José a

través de los padres. Con esta comunicación al paciente designado se busca:

- a) Dar un reconocimiento al empeño que José está empleando para consolidar su propia autonomía;
- b) Reproponer una prescripción sintomatológica de manera provocadora;
- c) Reforzar una clara división subsistémica entre la pareja y el joven;
- d) Relacionar la autonomía de José con la de los padres.

Traemos íntegramente el texto de la carta:

Querido José,

Tomo nota de los esfuerzos que estás haciendo en estos últimos tiempos para convertir tu participación en la terapia familiar en más productiva. Tanto más productiva porque operada a distancia, sin el riesgo por lo tanto de asumir actitudes dependientes y pasivas. Te solicito que no renuncies a la creatividad implícita en tus comportamientos habituales (como el estar prolongadamente en la cama, masturbarte repetidamente, romper los platos, amenazar con actos autolesivos, no desarrollar actividades laborales) hasta cuando no te hayas asegurado perfectamente que tus padres están en condiciones de caminar solos y sin necesidad de tu función.

Junto con la carta se dieron las siguientes instrucciones a los padres:

- La carta deberá ser leída cotidianamente en voz alta por el padre o la madre en presencia de los otros dos.
- A la carta deberá seguir cada vez una discusión sobre las reflexiones que la carta ha provocado en cada uno.
- En el caso de que José rechace participar, la lectura deberán hacerla los padres solos en el horario establecido en otro lugar o fuera de la casa.
- La sesión siguiente podrá tener lugar sólo bajo la condición de que la prescripción haya sido cumplida.

La lectura refuerza y sanciona la línea estratégica de esta fase. Redefine como creativo el comportamiento de José y aclara prescribiéndole las características funcionales del sistema familiar. Pero la carta está dirigida solo formalmente a José: el verdadero destinatario es todo el sistema familiar. De hecho todo el sistema

M. Andolfi, P. Menghi, A. M. Nicolé y Carmine Saccu

reacciona. La tercera condición la que prevee que los padres en ausencia de José cumplan con la lectura fuera de la casa, constituye para el padre y la madre una ocasión ulterior para confrontarse y reforzar su espacio de pareja, desvinculándose de alguna manera del hijo. La participación de los padres solos en la terapia había dado inicio ya a la línea que caracteriza estos últimos movimientos terapéuticos: la línea de la autonomía de los padres del hijo.

En uno de los encuentros sucesivos, después de la lectura de la carta, parecería que los padres hubieran alcanzado una mayor comprensión y más objetividad. Comenta en efecto la madre: "...se podría deducir que somos nosotros, los padres, los beneficiarios de la función de José para caminar solos. En cambio me parece que estamos envueltos y condicionados por nuestro hijo; este condicionamiento cesaría de existir si él asumiese actitudes adultas y lógicas. En todo caso yo, madre, deduzco concretamente que nosotros, padres, debemos esforzarnos en no hacernos condicionar por su función".

Parece que los padres hubieran aquí alcanzado la valiente y extrema determinación de luchar "con la ayuda" del terapeuta "contra" la necesidad de la función.

FASE DE LA ESCISION DEL SISTEMA

Familia

Terapeuta

$\frac{H}{T}$

||

$\frac{H}{T}$

Las cosas han cambiado. Pensamos que podemos continuar solos.

Me han demostrado con hechos que están en condiciones de cambiar. No tienen más necesidad de mí.

La familia no utiliza más al paciente designado que perdió su lugar central. Aparecen aumentados los espacios autónomos de

cada uno ya sea en el interior de los subsistemas familiares como en el exterior del grupo.

La formación de una nueva cohesión familiar permite la escisión del sistema terapéutico. El terapeuta se **congratula** por los cambios reales de la familia.

A través de su progresiva **descentralización** favorece el desprendimiento de la familia y potencializa los procesos de autonomía en acción.

En este estadio final de la terapia los resultados del trabajo realizado son fácilmente evaluables en cuanto a que la diferencia entre la manera en que el sistema se muestra al terapeuta y como es en la realidad cotidiana es ahora sutil.

Esto como confirmación de la ahora consensual homogeneidad del sistema terapéutico y de la reducción de las defensas familiares. No es difícil por lo tanto trazar un mapa detallado de la situación y es sorprendente notar como la familia misma está a menudo en condiciones de cumplir evaluaciones en este sentido con un lenguaje que, si bien, no sistémico, reproduce el significado más amplio. Impresiona el redimensionamiento y la descentralización del paciente designado que se encuentra ahora en una posición menos particular y más personalizada. No solo experimenta una fase de gestión autónoma, aún sufrida, de las propias instancias más auténticas, pero se encuentra actuando en este sentido sin llamar la atención constante de los demás. A ellos les parece ahora permitido vivir en primera persona dificultades y bienestar de la propia situación existencial.

Es evidente que en este momento un sistema "sano" advierte la necesidad de verificar la propia autonomía independientemente del apoyo terapéutico. La fase precedente de "nueva anormalidad" por lo cual cada progreso era factible solo en función del terapeuta, está por ser superada, pero como en cada estadio de transición el miedo a lo desconocido puede favorecer el retorno a situaciones anteriores. Esto es cuanto el terapeuta debe advertir. El se propone por lo tanto reasegurar la familia sobre las posiciones alcanzadas, favoreciendo una visión más clara del proceso de cambio, cada uno estará por lo tanto estimulado a puntualizar y a expresar los progresos cumplidos con el empeño colectivo. El tera-

peuta puede ahora reconocerse abiertamente en favor del cambio producido y congratularse explícitamente con los miembros de la familia por los esfuerzos hechos y los resultados obtenidos.

A la evaluación común de la situación actual debe suceder la planificación autónoma de programas diferenciados, el terapeuta estimulará la creatividad de cada uno para idear soluciones futuras concretamente realizables. El se pondrá como punto de referencia para una verificación periódica de lo establecido.

La aparente simplicidad de las líneas terapéuticas y la ininteligibilidad de las intervenciones propias de esta fase, podrían hacer subestimar la importancia y conducir a errores de superficialidad y ligereza. Los movimientos del terapeuta, en efecto, deben favorecer ahora su progresiva descentralización y una gradual disminución de ese poder que precedentemente había sido el elemento esencial de la intervención.

Si en esta fase final el terapeuta continuara siendo central, en los hechos, bloquearía el proceso de autonomía en la familia con paciente esquizofrénico, el no avanzar para alcanzar cierta paridad entre terapeuta y familiares, es superior que en otras familias, lo que requiere tiempo y prudencia a fin de que la separación no se produzca demasiado bruscamente.

Intentamos ahora sintetizar los movimientos ejecutados por la familia Fraioli en relación con la fase descrita.

Cuanto transcribimos representa la verificación concreta y final de una programación laboriosa desarrollada durante las últimas sesiones:

José provee constantemente noticias de sus propios progresos y define "ahora normal" su propio comportamiento. La sintomatología precedente no se volvió a presentar a pesar de que él afirma no haber aún resuelto completamente sus problemas, agrega que no volverá por éste o cometer actos autolesivos. A veces manifiesta cierta preocupación por el futuro pero se empeña activamente en lugar de retirarse a las habituales actitudes regresivas.

Ganó un importante concurso de habilitación profesional y colaboró en la gestión del estudio del hermano. Además estudia para mantenerse actualizado profesionalmente. En ocasión de las vacaciones ha realizado algunos viajes con amigos y se declara satisfecho de la nueva experiencia.

Entabló una amistad con un muchacho de su edad con el que invierte parte de su tiempo libre. A veces va a visitar a su hermano mayor que vive en una ciudad vecina y con el cual ha establecido un diálogo significativo. Proyecta sus vacaciones del año próximo, en particular está preparando detalladamente y con entusiasmo un viaje al Lacio y a Umbría. Los padres en un primer tiempo comenzaron a pasar solos algunos días más después de la sesión en Roma; posteriormente y por primera vez en su vida, proyectaron y tuvieron vacaciones sin ninguno de sus hijos.

Comprobaron con sorpresa y satisfacción que lograron no hablar de José y no sentirse culpables; y destacaron además como éste había mejorado a consecuencia de su separación de ellos.

Han quedado estufefactos ante el hecho de que José se haya "desenganchado" yendo en excursión a Asís unos días antes del viaje de ellos y afirman "haberse sentido impactados al mismo tiempo".

Simultáneamente surgieron tensiones a raíz de sus características tan diferentes pero declararon sentirse revitalizados por estas discusiones. El padre dice haber "redescubierto" a Juana, la hija adolescente y haber recuperado con ella una relación que, sin quererlo y sin darse cuenta, se había prácticamente perdido.

La separación gradual de la terapia confiere a cada uno de los miembros de la familia Fraioli una mayor independencia y los enfrenta con la necesidad de hacerse cargo y asumir plena conciencia de los cambios producidos. Le abren para cada uno espacios ligados más con la persona que con la función; en este sentido cada uno está operando un balance.

RESUMEN

Los autores describen los sistemas familiares como flexibles y rígidos de acuerdo con la capacidad dinámica de modificar el equilibrio entre homeostasis y transformación durante el ciclo evolutivo de la familia.

La e analizan concretamente las modalidades con las cuales los sistemas rígidos pueden englobar la intervención terapéutica en sus reglamentos disfuncionales y se describe un modelo original de

estrategia. Puesto que la rigidez del sistema se expresa a través de mensajes provocadores para el terapeuta, éste contesta con una contraprovocación para desequilibrar la familia al cambio. Se esquematiza el proceso terapéutico en 4 fases sucesivas e ilustrado mediante el análisis de una familia con paciente esquizofrénico, seguido por los autores en psicoterapia.

VIII Congreso Latinoamericano de Psicología y Psicoterapia de Grupo - Simposio: "Terapia Familiar".*

Coordinador: Doctor Alberto Serrano

Yo soy Alberto Serrano, nativo argentino y hace 22 años que estoy en EE.UU. y es un gusto para mí representar una serie de experiencias de los países del norte, y exponer los conocimientos -no arcaicos- sino más antiguos, con todo lo que se está haciendo en este momento.

El motivo de este Simposio es una feliz combinación de profesionales de enorme experiencia y capacidad de articulación. El problema que tenemos es el tiempo. La posibilidad de diálogo con ustedes está un poquito reducida y hemos creado una estructura que va a ser posible que exista por lo menos con intercambio de información, si bien lo afectivo que ustedes han podido sentir en los últimos dos días no va a ser tan posible.

Sugerimos que debido al volumen de gente que tenemos aquí, no fumen, porque sino en una o dos horas vamos a estar todos tosiendo y eso va a hacer que esté contaminada un poco nuestra atmósfera. Si alguien siente ganas de fumar, hágalo, no queremos que nadie se psicotice (risas). Esta situación evidentemente quere-

Varios

mos evitar a toda costa, pero si de todos modos si alguien se llega a psicotizar contamos con bastantes recursos de salud mental (aplausos).

El grupo que hemos creado aquí, es un grupo distinguido de profesionales con vasta experiencia. Ayer pasamos una hora y media, pensando de qué manera podíamos orquestrar una serie de secuencias, que digamos, sería un menú, que si bien no puede incluir todos los ingredientes, por lo menos, les despierte el apetito, para saber un poquito más de todas estas cosas. La estructura que tenemos, es que cada uno de los panelistas va a hacer una representación de diez o quince minutos. Entonces al final de esto que durará una hora diez, una hora quince más o menos, van a tener un pequeño intervalo. Los urgimos a que no se vayan muy lejos porque lo que queremos hacer es que Uds. puedan escribir preguntas. Si quieren poner quienes son para ser reconocidos, escribanlo, o si quieren mantener el anonimato pueden hacerlo. Entonces vamos a coordinar las preguntas de manera que también tengan cierta secuencia para que no sean desorganizadas, redundantes y que sean contestadas por varios panelistas. En este sentido hemos tratado de que sea lo más constructivo posible.

Los panelistas entonces son: Dr. Jorge García Badaracco, Dr. Alfredo Canevaro, Dr. Miguel Mendez Elizalde, Dr. Santiago Korin, y el Dr. Isidoro Berenstein.

La primera presentación y siguiendo un poquito la secuencia, parte de lo que pensamos hacer en el sentido de ir de lo más general, de lo más pictórico, por así decir, a lo más corriente y tal vez en algún detalle más. Si tuviera algún título o un subtítulo para lo que queremos hacerles: una visión general o un panorama actual de lo que es la psiquiatría de la familia.

El Dr. García Badaracco va a ser el primero en presentar, y es conocido por todos Uds. pero tal vez haya algunas cositas para aquellos que no sepan de la evolución de él. El Dr. García Badaracco es un psicoanalista que ha sido entrenado en Francia y en la Argentina, es un didacta de la A.P.A., profesor adjunto en la Escuela de Medicina del departamento de psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires; ex jefe del Servicio del Hospital Neuropsiquiátrico, ahora corrientemente llamado Borda. Ahí fue donde empezó posiblemente con sus primeros esfuerzos, a organizar una

comunidad terapéutica para enfermos psicóticos, de carácter psicoanalítico. Concomitantemente es el Director de la comunidad terapéutica psicoanalítica y ha continuado arduamente trabajando en este campo, así como en otros campos del psicoanálisis y la salud mental. Lo que él nos va a comentar, como título es: "La familia como contexto real o virtual en todo proceso psicoterapéutico".

DR. GARCIA BADARACCO:

Se hace siempre difícil resumir en 10 ó 15 minutos, un tema tan complejo como éste, y más aún porque cada uno de nosotros hablamos desde una experiencia clínica que no siempre es compartida por los demás en psicoterapia, cada uno ha hecho a veces un desarrollo propio o con su grupo de trabajo y no tiene suficientes oportunidades para confrontar con otros. Las exposiciones uno hace, como ésta por ej.: (yo he hecho muchas) siempre me plantean la misma dificultad: la manera de transmitir algunas cosas porque inclusive la expresión verbal y la expresión conceptual de experiencias psicoterapéuticas, no abarcan suficientemente todas las dimensiones de la misma, y hace por lo tanto difícil la comunicación de la experiencia solamente con palabras.

Yo voy a hacer algunas reflexiones generales, primero; luego voy a decir algo del campo en que trabajo, del que he extraído la mayor parte de estas reflexiones, y finalmente algunas consideraciones que creo que pueden ser útiles para la discusión del tema.

En primer lugar creo que la historia de la psicoterapia está más bien ligada a la idea de una técnica y en ese sentido si uno ve la historia de las distintas modalidades de la psicoterapia, se encuentra con que el psicoanálisis abre un camino que durante un tiempo aparece como el más estructurado o el más científico, o el más serio, y luego se van desarrollando otras nuevas técnicas que constituyen sin lugar a dudas un enriquecimiento progresivo del conocimiento en este campo. Pero pienso que las técnicas se han ido desarrollando cada una como por sí misma y el peligro de esta situación ha sido y creo que sigue siéndolo en algunos aspectos, la configuración de compartimentos estancos entre unos y otros, tanto desde el punto de vista clínico y de la práctica. En términos, por ejemplo, de que muchas veces

un psicoanalista no tiene manera de comunicarse con un terapeuta de la familia o con un sociólogo que estudie por ej., la dinámica de una comunidad terapéutica psicoanalítica, o también en otro sentido, desde el punto de vista teórico en donde aparecen conceptos de un campo y de otro como irreconciliables, cuando la práctica nos obliga a entender que debe ser absolutamente integrados.

En este sentido creo que éste sería un punto que me gustaría como intercambio.

Otro aspecto es el de los pacientes difíciles, graves, no abordables por las técnicas psicoterapéuticas tradicionales o llamados incurables, tratados entonces por una psiquiatría que se dirige solamente a un tratamiento, por ej. de tipo farmacológico, o biológico, nada más; pensando en la inoperancia del abordaje psicoterapéutico. En mi experiencia el estudio de los fracasos de la psicoterapia ha sido muy enriquecedor y es en particular un intento de abordar psicoterapéuticamente, pacientes psicóticos graves donde uno puede aprender muchas cosas que no constituyen, diría yo, una especialización en psicóticos, sino la ampliación de un vasto campo. Aquí es donde abarcaría toda la psicopatología y la psicoterapia en general de los pacientes neuróticos y psicóticos como dos campos que se relacionan íntimamente y que no pueden ser separados en analizables y no analizables. La reflexión general que quisiera proponerles podría leerla en algunas frases: La experiencia clínica nos muestra que más allá, entonces, de diferentes técnicas a nuestro alcance, es necesario poder visualizar el proceso psicoterapéutico. A semejanza del proceso de desarrollo y crecimiento normal dentro de la familia, pensamos que todo proceso psicoterapéutico verdadero, cualquiera sea la técnica empleada como tratamiento, constituye una especie de desarrollo en un contexto familiar real o virtual. Si bien mi experiencia como digo, se basa mucho en trabajos con pacientes psicóticos como Uds. van a ver, en algunas de las cosas que les voy a decir, también abarca una experiencia psicoanalítica de todo paciente neurótico, y grupos familiares y de pareja de personas no psicóticas y por lo tanto no encuentro contradicción entre las cosas que puedo afirmar con respecto a pacientes neuróticos y los pacientes psicóticos.

La experiencia, como les digo, desde donde hablo, tiene mucho que ver con una comunidad terapéutica psicoanalítica. Esta surge desde el punto de vista de la necesidad de dar al paciente psicótico un contexto (para la experiencia psicoterapéutica) de una mayor seguridad psicológica.

En el caso del paciente psicótico en especial, su familia se configura como el obstáculo al proceso psicoterapéutico. Y allí en ese campo, es donde podemos trabajar y ver los aspectos de la dinámica psicopatológica-familiar y la correlación con aspectos de la psicodinámica interna del paciente, tan bien estudiada por el psicoanálisis. La comunidad terapéutica, se constituye en un campo psicológico de estructura multifamiliar que abarca las familias como totalidad, como unidades totalizadoras de una situación, donde el paciente está incluido como parte de esa patología y la familia está incluida en el campo más amplio multifamiliar, donde encuentra a su vez un campo privilegiado para el propio desarrollo del proceso terapéutico familiar. De esta manera en una especie de integración topológica, podemos hablar de un amplio campo multifamiliar de estructuras familiares nucleares y de pacientes dentro de estructuras familiares nucleares, a su vez de un intercambio de pacientes con otras familias, que por no ser su propio familiar, funcionan mucho mejor dentro, para apoyar o favorecer procesos de crecimiento, en vez de impedir procesos de desarrollo o crecimiento como la propia familia lo hace. Vuelvo a repetir que es desde el estudio de esos obstáculos de los procesos de desarrollo, el estudio de los vínculos familiares que obstaculizan el proceso psicoterapéutico de donde puede surgir o sacarse mayor experiencia para la comprensión de estos fenómenos.

En los 5 minutos que me quedan quisiera entonces, referirme a algunos puntos de lo que está incluido en las formulaciones generales que acabo de dar.

Uno de los aspectos que obstaculizan el proceso de crecimiento o desarrollo individual son los vínculos simbióticos patológicos del paciente con sus padres, fundamentalmente. El vínculo simbiótico patológico con la madre se estructura como una relación narcisística de objeto, en términos psicoanalíticos habituales y se expresa en el campo familiar como una transferencia psicótica desplazada, que puede ser estudiada también en el campo psicoanalítico individual.

Varios

Freud, no estudió la transferencia psicótica, habló de la transferencia neurótica y pensó por muchos factores de dificultades clínicas del abordaje del paciente psicótico, que el paciente psicótico no hacía transferencia.

La realidad es que autores posteriores fueron descubriendo que el paciente psicótico no hace transferencia neurótica pero sí psicótica, lo cual es también una transferencia aunque de naturaleza distinta. Poner en evidencia el vínculo simbiótico patológico, permite trabajarlo, cosa que en análisis individual es muy difícil y permite además descubrir el funcionamiento de la presencia del padre para poder disolver ese vínculo simbiótico, de las carencias de la madre en términos no solamente de un vínculo simbiótico patológico como representante de un conflicto narcisístico, sino también de un tipo de vínculo que incluye aspectos carenciales yoicos, que condicionaron la patología del sujeto. Cuando el paciente, entra en proceso terapéutico y se dan en él cambios, las estructuras familiares, en particular la madre (por ej. en este caso) trata inconscientemente, por las ansiedades que despierta el proceso de desimbiotización, de recuperar el vínculo simbiótico para recuperar su estabilidad. Fenómenos de este tipo han entrado dentro de lo que Jackson llamó "Homeostasis familiar". No me gusta mucho la palabra en tanto que homeostasis apunta a una fisiología normal, y estamos aquí hablando de volver a estructuras patológicas, o vínculos patológicos, mientras que lo normal aparece como una dinámica que tiende a una individuación y a una mayor autonomía en cada una de las personas incluidas en una estructura familiar; pero de todas maneras es ese vínculo simbiótico el que está en estudios en estos momentos.

En otros términos Winnicott habló del "falso self" y de la necesidad de recuperar el verdadero Self para poder hacer un proceso terapéutico efectivo. Desde el punto de vista psicoanalítico entonces, tenemos que ver, que por los problemas de la estructura narcisística, no pudo ser estudiada suficientemente por el mismo Freud, en la medida en que no pudo tomar en cuenta suficientemente estos aspectos.

Pero curiosamente, sería muy interesante adquirir, y es otro de los aspectos que propongo, el estudiar la dimensión familiar en toda la obra de Freud. Y como ustedes saben esa dimensión

familiar aparece nada menos que en el Complejo de Edipo, que es la estructura central de toda patología neurótica. Por supuesto que el Complejo de Edipo aparece descrito desde una conflictiva de la pulsión en juego, pero como hemos visto cada vez más, esas pulsiones que implican un desarrollo, es decir: el desarrollo de la libido, tan extraordinariamente desarrollada por Freud y además tan ricas...consecuencias, hipótesis de trabajo, etc., debe ser hoy a mi entender, integrada en un contexto de ese desarrollo. El contexto del desarrollo de la teoría de la libido es la familia, la articulación con el complejo de Edipo es una de las formas que Freud pudo describir, pero no abarca a todas. Por otra parte muchos de los fenómenos descritos por los estudiosos de la teoría de la comunicación en términos de la estructura familiar, léase por ej.: fenómenos del "doble vínculo" (Bateson-Jackson), fenómenos de pseudomutualidad (Wynne), o fenómenos como complementariedad de necesidades patológicas, (Boszormenyi-Nagy), para decir solamente algunas cosas, serían a mi entender los aspectos rígidos de las estructuras familiares, que tienden a detener los procesos de individuación y de desarrollo de los individuos dentro de esa estructura y que estarían al servicio de la patología narcisística vincular inicial o de los aspectos carenciales que se ponen en juego para poder netamente detener esos fenómenos de desarrollo.

El doble vínculo, por ej. es evidentemente muy interesante como concepto, pero necesita a mi entender, la complementación con la concepción psicoanalítica, en donde el doble vínculo juega para mantener la simbiosis. La complementariedad de necesidades patológicas serían las estructuras perversas entre padres e hijos que dificultan por ej., que impiden la resolución del Complejo de Edipo. Es decir, que lo mantienen en la medida en que la sexualidad infantil de los hijos no pueda desarrollarse como sexualidad adulta.

Estos últimos aspectos que traté de describir, son solo algunos ejemplos de lo que yo considero cada vez más necesario ir desarrollando entre psicoanalistas, entre terapeutas de familia, de grupo, etc., etc., cosa que a veces no se da porque, como dije al principio, las técnicas psicoterapéuticas muchas veces se desarrollan como en compartimentos estancos que no permiten suficientemente ni la articulación clínica, ni la articulación técnica,

ni la articulación teórica, necesarias para hacer un desarrollo más coherente entre nosotros. Nada más.

DR. SERRANO:

Muchas gracias, Dr. García Badaracco. Ahora nos va a hablar el Dr. Alfredo Canevaro. El es psiquiatra de formación psicoanalítica, presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar fundador y director de la revista de Terapia Familiar que acaba de sacar su tercer número. Así mismo es el codirector de la comunidad terapéutica psicoanalítica de la cual el Dr. Jorge García Badaracco es el director.

DR. ALFREDO CANEVARO

Entre las múltiples razones por las que debemos agradecer y felicitar a los organizadores de este congreso está la importante apertura ideológica con que viene imbuido el relato oficial y que nos marca un camino que quisiéramos recorrer especialmente cuando dice: "la particular ubicación de la materia que nos une, tiene la característica de favorecer el encuentro multidisciplinario para todos en la medida en que amplía nuestra capacidad de observación. Pero también esto trae aparejado el peligro de la apresurada traslación de modelos y conceptualizaciones teóricas de una disciplina a otra. Es necesario que todo esto sea minuciosamente estudiado para que la práctica vaya acompañada de hipótesis básicas que puedan luego ser revisadas por una comunidad profesional con criterios compartidos". Por lo tanto buscar las semejanzas y diferencias entre la terapia de grupo o grupal y la terapia del grupo familiar, puede ser sumamente útil, no solo conceptualmente sino por sus importantes implicaciones técnicas. El desarrollo más importantes de la terapia familiar nace hacia fines de la década del 40, no solo como un intento integrador del desarrollo de las ciencias en general de esa época. También surgió como necesidad clínica derivada del tratamiento de pacientes con una gran dependencia psicológica y emocional marcando dos líneas diferentes que luego se unieron conceptualmente: una la psicoterapia de esquizofrénicos y otra la psicoterapia infantil.

En ambos campos a pesar de ser resistida teórica y técnicamente, fue imponiéndose como una realidad clínica hoy indiscutible. La psicopatología y la psicoterapia, debían entonces, ser descentradas de su enfoque en el individuo y ampliarlo al grupo, viraje epistemológico intuído por el psicoanálisis cuya esencia es una antropología familiar, pero instrumentalmente insuficiente ya que no incluía las nociones de sistema y estructura aplicadas para pensar conjuntos y estudiar globalidades. Así entonces, ciertos mecanismos normales en el grupo familiar estudiados como sistemas, como ser la homeostasis, tenían que ser aprehendidos imprescindiblemente por el terapeuta para así poder comprender y anticipar vicisitudes del proceso terapéutico.

Mucho nos han enseñado los fracasos terapéuticos para que estos puntos de reparo teórico técnicos no sean soslayados. Por esta dimensión teórica nos remite nuevamente a la práctica cuando enfrentamos indicaciones de psicoterapia grupal o intentamos comprender situaciones contratransferenciales a veces críticas. Generalmente la psicoterapia de grupo se usó como alternativa familiar ofreciendo un soporte para la mejor discriminación yoica. El aislar a los familiares, más real que conceptualmente, a semejanza de lo que pasaba en la terapia individual permitía desplazar sobre el grupo familiar aspectos conflictivos de los pacientes. En este sentido no se podía cumplir con los verdaderos efectos terapéuticos de grupo en poder desarrollar una experiencia social basada en vínculos menos contaminados por transferencias de tipo narcisístico que recreaban en los grupos situaciones que no eran fáciles de manejar, en tanto alienaban la relación. Es decir: el múltiple campo de las actuaciones que impedían una verdadera experiencia de aprendizaje social en un grupo secundario con relaciones menos tiránicas y más optativas que las que se dan generalmente en grupos familiares. Por eso las indicaciones debieran ser precisas y evaluar la capacidad yoica de cada paciente y su real relación familiar. El gran valor terapéutico del grupo debe ser rescatado saliendo de confusiones conceptuales que llevaban a segregar pacientes en vez de integrarlos y prescribir correctamente cual es el tipo de terapia, ya sea complementándola, ya sea yendo por etapas. Así se dejan de lado pacientes border-line

o psicóticos que podían muy bien ser aceptados en grupos una vez superados los problemas más intensos en el seno de su grupo familiar con terapia familiar simultáneamente o bien invitando al grupo de esos familiares a revisar in-vivo las dificultades con el paciente. A veces unas pocas entrevistas con familiares significativos de los pacientes son suficientes para poner en marcha un proceso terapéutico que no se vea luego interrumpido por una reacción terapéutica negativa como señaláramos hace más de nueve años con Jorge García Badaracco. Esto sería la indicación típica en un grupo de adolescentes o en grupos en los cuales las reacciones de los cónyuges de los pacientes interfieren en los procesos terapéuticos. Esta parece ser otra de las dificultades técnicas para quienes no han tenido suficientemente en cuenta los procesos homeostáticos que regulan el grupo familiar. Para un paciente adulto, casado, que enfrenta problemas con su familia actual, específicamente conyugales, está contraindicada su inclusión en el grupo si no se tiene debida cuenta de la reacción que puede despertar en su cónyuge. En este caso es mucho más apropiado organizar un grupo de multiparejas o multifamiliar donde esa problemática compartida sea más idóneamente resuelta. Si el eje que divide a las diferentes técnicas pasa por la **organización de las relaciones familiares**, sería diferente prescribir grupo-terapia para un adolescente con problemas de individuación en su familia de origen que para un joven adulto con dificultades en su matrimonio recién conformado que para otro con conflictos más importantes que provengan de su familia nuclear, que para otro divorciado que no haya constituido nueva familia, etc.

Si este trasfondo de las relaciones familiares que obra intrapsíquica y relacionalmente en el individuo, ayuda a conformar su identidad profunda, también es el vehículo de su inclusión en la cultura, ayudado aquí por los distintos grupos de pertenencia que lo insertan en la sociedad. Debemos hacer un esfuerzo para comprender los factores específicos que diferencian a un grupo familiar de otro tipo de organización grupal y así aplicarlos terapéuticamente. Los sistemas de parentesco amalgaman con los códigos genéticos un eje biológico y cultural por el cual dos familias se continúan a través de un individuo.

Esta identidad profunda contiene determinaciones inconscien-

tes y mandatos poderosos que deben ser tomados en cuenta para comprender las acciones de los seres humanos a lo largo de un eje diacrónico que complementa al sincrónico. Los mandatos y las delegaciones transgeneracionales y los duelos no elaborados transmitidos conforman un sustrato psicológico y emocional que debe necesariamente ser analizado y elaborado para poder integrarse en un verdadero self. Así es como las transferencias en un grupo, además de su contenido informacional y de su estilo relacional contienen un trasfondo ético que simboliza las trascendencia de personas, de vínculos y de improntas culturales que deben ser tomadas en cuenta. El recorte arbitrario que la teoría determina como lectura de la realidad clínica corre el riesgo de limitar el aporte de nuevas experiencias que dialécticamente enriquezcan la teoría y así sucesivamente. La insuficiente elaboración de nuestra contratransferencia hace que muchas veces confundamos enfermedad o disfunción con intencionalidad disruptiva del encuadre. En ese sentido es donde la articulación de los recursos técnicos de probada eficacia como la coterapia y el trabajo en equipo amplían nuestra capacidad operativa en casos aparentemente insolubles.

Benjamín Wolman cita al filósofo Nagel cuando dice: "Aunque todo experimento requiera el uso de unos principios de interpretación, la prueba de la verdad de tales principios procede en última instancia de la observación y el experimento..." "Las proposiciones que la ciencia certifica en cualquier momento o son confirmadas en todos los experimentos posibles o son modificadas de acuerdo con la mejor prueba disponible. Así pues existe una continua apelación de los hechos a los principios y de los principios a los hechos... En orden al desarrollo de nuestro conocimiento, por consiguiente, la teoría y la observación ostentan la misma categoría. Y luego, Wolman se pregunta: "qué debería ser primero, la observación de los hechos o su interpretación?". La respuesta es evidente: en las ciencias empíricas el método de elección es el inductivo. Sin embargo, en las ciencias empíricas también se puede utilizar el método deductivo. La ciencia puede proceder del hecho a la interpretación, pero también un intento de interpretación, puede ser probado mediante los hechos. Cualquier sistema científico debe componerse de datos empíricos y de su interpretación". Siguiendo estas palabras y retomando el tema que hoy nos une,

Varios

podemos decir que: la terapia familiar, que tiene un objeto de estudio específico y propio, para aspirar al status de disciplina científica debe seguir construyendo y consolidando un cuerpo de teoría que se apoye sobre verdades clínicas, resultado de hipótesis rigurosamente confrontadas y verificadas.

Esto debe conformar un espacio ontológico nuevo que esté quizás más cercano a la realidad satisfaciendo nuestro doble anhelo de terapeutas y de investigadores.

DR. SERRANO

Muchas gracias Dr. Canevaro. Es interesante como podemos reconocer la necesidad de la existencia de la familia en el paciente y poder reconocer, lo que es interpersonal de lo que es específicamente familiar y como debemos conocer las diferencias entre grupos naturales y grupos artificiales e implementar los recursos terapéuticos como coterapia con el grupo. En fin, más podríamos seguir hablando y entraríamos en la tecnología y en la teoría y en la necesidad de ensamblar este tipo de situaciones.

La próxima presentación en especial, va a enfocar estos aspectos: el título de esa presentación que el Dr. Mendez Elizalde ha elegido es: "Algunas reflexiones entre la teoría y la práctica en la comprensión del tratamiento de familias".

El Dr. Mendez Elizalde es psicoanalista del Policlínico Gregorio Araoz Alfaro y tiene vasta experiencia en terapias de familias.

DR. MENDEZ ELIZALDE

Ante todo, quiero pedir disculpas por el carácter incompleto y un tanto improvisado de estas observaciones, ya que el tema surgió de una discusión que tuvimos anoche los integrantes del Panel.

Nuestro propósito es el de hablar de ciertos problemas que surgen en la práctica de la terapia con familias. Para ilustrarlo, tomaremos un material clínico y un trabajo presentado hace poco por Isidoro Gurman. El caso resultó paradigmático, ya que siendo el tema de la reunión Psicoanálisis y Familia, el autor jerarquizó sus intervenciones menos psicoanalíticas.

Se trataba de una familia compuesta por los padres y tres hijos,

que consultaban porque la hija robaba y tenía conductas sexuales exhibicionistas. Se preguntó quién más robaba y dijeron que una tía materna era cleptómana, tía a la que la paciente sancionada estaba muy ligada. Pero no se preguntó si había alguien más que tuviera conductas sexuales exhibicionistas.

Después de haber aceptado aparentemente las condiciones del tratamiento, en cuanto a los días y las horas de sesión, le dijeron al Terapeuta que no podían concurrir ni el día, ni la hora que habían acordado previamente. El Terapeuta les dijo entonces que no podría atenderlos y en el acto se desdijeron y aceptaron nuevamente el contrato.

Durante el tiempo del tratamiento, la madre se fue sola a New York, los hijos le empezaron a hacer bromas al padre, acerca de la confianza inquebrantable que le tenía a la madre, la actitud del padre era la de no darse por aludido y de hacerse el "oso".

Gurman comenzó a tener la impresión de que esta hija no era hija del padre y que en cambio los dos hijos varones sí y esta impresión o sospecha se fue acentuando con el tiempo.

Finalmente, un día comenzó la sesión diciéndoles que no aguantaba más y que les iba a decir toda la verdad y les habló de todas las sospechas que los hijos tenían acerca de las relaciones extramoniales de la madre y la particular actitud del padre frente a esto. Pero no mencionó su propia sospecha acerca de la ilegitimidad de la hija.

A partir de este momento, se operó un cambio espectacular en la familia, la hija dejó de robar y abandonó sus síntomas exhibicionistas.

La resultante de esto es de una gran ambigüedad, el ponerse en el lugar a decir toda la verdad y el decir sólo una parte de ella, convierte a quién denuncia en transgresor de su propia palabra. Se denuncia un secreto que obliga al padre a salir de una fratría en la que estaba mezclado con sus hijos, haciéndose el "oso" y se le obliga a confrontarse con una posición en la que no es igual a los hijos, ya que ellos no serían cornudos y él sí, frente a la supuesta infidelidad de la madre.

Aquellos que hayan leído el libro de Salvador Minuchin: "Familias y Terapia Familiar", recordarán que Minuchin asume liderazgos y rompe alianzas de este tipo, la de un padre funcionando en

Varios

la fratría, por ejemplo y también incluye a miembros separados del grupo. El problema que tiene una teoría que no da cuenta de esto sino a un nivel un tanto superficial. En todo caso, de lo que no se hace cargo Minuchin, por lo menos teóricamente, es de la ambigüedad esencial de su propia posición frente a la familia.

Es en esto en lo que queremos insistir, por más ingeniosas que puedan ser nuestras intervenciones, no tenemos una teoría que dé cuenta de ellas. En este caso en particular, sería un modo de pensar la estructura familiar que corresponda con la estructura del psicoanálisis, incluso para situar esta ambigüedad.

En nuestro caso, por la zona de vacío que se crea entre la envidia de las intervenciones y el silencio de la teoría, se intercala a veces la referencia un tanto mítica a la antropología cultural, que proporciona un modelo que tiene bastantes diferencias con el modelo psicoanalítico en sentido estricto. Aún cuando se pueda utilizar el modelo antropológico en la terapia de familias.

Las intervenciones de Gurman con esta familia, que lo convierten en represor y transgresor al mismo tiempo, corresponden al sentido que da Lacan a la imago paterna, cuyo carácter contradictorio exalta la tensión de la libido y el alcance de la sublimación. Permite la aparición de un ordenamiento simbólico en este juego de elementos narcisísticos. En esta familia sin límites, donde la hija no está ni adentro ni afuera, el terapeuta actúa como el que puede hablar, pero también callar, creando un espacio con el corte y la sutura, donde la hija se puede incorporar, aunque no sepamos muy bien a qué estructura corresponde la fantasía de ilegitimidad de la hija.

Ya Aristóteles, en su trabajo sobre Economía Doméstica, estableció claramente los espacios en la familia, donde el espacio de la madre es el espacio interno, la casa, y el padre es el que limita desde afuera a la familia.

No se nos escapa que estamos estableciendo una homología entre la función del padre y la posición del psicoanalista en una familia, de la que aún no podemos dar cuenta. Sin embargo, lo consideramos como un punto para la comprensión de la práctica con familias.

DR. SERRANO:

El próximo orador será el Dr. Santiago KORIN, es titular de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, también es titular de la Sociedad de Psicología y Psicoterapia de Grupo, es encargado del servicio de Psicopatología del Sanatorio Güemes y desde hace muchos años ha puesto especial interés en trabajar con adolescentes y sus familias.

El título de la presentación que el Dr. Korin ha elegido es un poco enigmático y se titula "Las palabras que usamos".

Desea hacer hincapié en la necesidad de buscar una transacción entre los modelos explicativos de la familia con los nuestros como terapeutas y además conviene comentar entre los familiares y nosotros que es lo que se va a esperar, que herramientas debemos usar, en fin, acá estamos hablando otra vez no de la magia, sino de qué manera tenemos que evaluar tanto pragmática como semánticamente lo que va a ocurrir entre familia y nosotros.

DR. KORIN:

Creo que en la presentación del Dr. Serrano, sintetizó brillantemente lo que yo ahora voy a tratar de desarrollar.

Esto de ninguna manera quisiera que les llegue a ustedes como un producto terminado o una serie de conclusiones, ya que si las hay son conclusiones de tipo provisorio y elegí la oportunidad de este encuentro, tanto con los colegas de la mesa como con los colegas de la platea para reflexionar en voz alta sobre un par de series de preocupaciones; son dos grupos de preocupaciones que me inquietan.

Esto de las palabras que usamos, no es un intento de ser enigmático, sino quizás un intento de sintetizar un tanto apretadamente el deseo de explorar cual es el repertorio, la jerga con la cual nos manejamos tanto con las familias como entre colegas y especialmente con los colegas en formación y cual es la consistencia de ese repertorio, y los traspiés en que este repertorio nos hace incurrir.

Me voy a referir a dos áreas, a las áreas donde se brinda asistencia y a las áreas de docencia e investigación.

Me voy a referir primero a las áreas de la asistencia. Hemos sido entrenados para tratar cuadros clínicos o enfermedades, los pacien-

Varios

tes nos traen malestares, y estos malestares, siempre corresponden a la medicina clínica o a la psicología o a la psiquiatría, son malestares que están estrechamente vinculados a los lazos que unen al individuo con la sociedad, más específicamente con el ecosistema donde ese individuo o esa familia, ese "ente consultante" podríamos decir está insertado.

Frente a tales malestares nosotros usamos un repertorio altamente tecnificado de conocimientos, que nos mantiene alejados de tal sistema ambiental.

Esto nos lleva a plantear verdaderas estrategias clínicas, nos obliga, yo creo que nos compromete a plantear estrategias clínicas que a mi juicio deben ser diferenciadas para cada ente consultante. Dicho de otra manera nos obliga a hacer una construcción cultural de la realidad clínica que se nos presenta. Es el malestar, y no los cuadros clínicos los que están estrechamente vinculados con el ecosistema y están firmemente influenciados por esta cultura desde donde se nos consulta.

Entonces nos encontramos con la siguiente situación, en la consulta, se da una relación entre el operador (sea médico, trabajador social, psicólogo, antropólogo), y el paciente, donde se intercambian modelos explicativos que la gran mayoría de las veces discrepan fuertemente, discrepan tanto en cuanto al contenido cognitivo, cuanto a los valores terapéuticos y como en cuanto a las metas y a las expectativas.

Dicho de otro modo y usando quizás un esquema bastante simplista, los profesionales estamos ubicados en un escalón diferencial que nos pone por encima de los consultantes, nos pone por encima, porque hemos recibido un entrenamiento y tenemos conocimientos altamente sofisticados en cuanto a la técnica y el peligro es creer que "nosotros sabemos y ellos no saben" y creer que lo que a ellos les duele es muy conocido para nosotros y que nosotros sabemos de ese dolor más de lo que ellos saben y todo esto no es cierto.

Ellos traen ese dolor desde dentro de la sociedad y la sociedad amplia y de la comunidad donde están ellos y el grupo religioso o étnico dentro del cual están. Entonces podemos dividir las áreas asistenciales en tres, es decir clásicamente están divididas en tres.

La que describí hasta ahora es el área profesional que nos com-

pete a nosotros y que por más numerosos que seamos en esta sala no debemos engañarnos, constituímos una ínfima minoría, frente a la población doliente, de la población que consulta. Nos caracterizamos por tener más tecnificación, más sofisticación en nuestro lenguaje y en general respecto de la gran masa de consultantes una disparidad socio-económica que nos favorece.

Tenemos un lenguaje más fino, más refinado: lo digo tanto en un sentido literal como irónico y tenemos una posición social privilegiada.

Hay otra área asistencial que se la llama popular y que prácticamente abarca entre el ochenta y cinco y el noventa y cinco por ciento de las consultas, (ésto surge de estadísticas dignas de confianza), o sea: habitualmente la gente recurre a la familia, al sacerdote, al enfermero, al farmacéutico, en fin a los elementos de la comunidad que le recetan un antiespasmódico o que se case o que se divorcie y que dan indicaciones terapéuticas y que proveen una asistencia a todas estas dolores e insatisfacciones, manifestaciones que mencionaba y acá viene un detalle bastante importante. Cuando alguien debe recurrir a una asistencia que se puede satisfacer dentro del ámbito popular, es en este mismo ámbito popular donde se decide a quien se va a consultar o si se va a consultar al ambiente profesional y si se va a consultar a nivel profesional, a quién se va a consultar y con qué expectativas se va a consultar.

"Andá a lo de fulano, que sabe", no es lo mismo por ejemplo que le aconsejen a una familia en una situación de crisis que vaya a ver a un psicólogo, un psiquiatra o que vaya a ver a un abogado.

Muchas veces y muchas más veces de las que nosotros podemos creer por razones de nuestra propia autoestima, la indicación comunitaria no es consultar a gente del área profesional sino que es consultar a gente de asistencia del área Folk, lo que nosotros llamamos curanderos, pero hay que incluir en esta área Folk a la tiradora de cartas, el horóscopo y a todo tipo de asistencia folklórica, asistencia diferenciada de la comunidad, pero no diplomada, entonces volviendo a la consulta tenemos el honor de haber sido elegidos y que recurran a nosotros y tenemos que estar a la altura de esa expectativa por lo tanto debemos saber que en esa expectativa va a haber diferencias marcadas entre ellos y nosotros que tenemos que solucionar.

El punto central en la consulta es para mí, el lograr una transacción, en algunos momentos se habla de una "negociación" entre los modelos explicativos que nos trae la familia y los modelos explicativos que nosotros tenemos.

Ambos se ocupan de los mismos puntos en el sentido de etiología, tratamiento, etc., pero sepamos siempre que el modelo que nos trae el paciente depende de su eco-sistema, refleja su clase social, las influencias culturales, su educación, su situación religiosa y los antecedentes que él tiene como persona y como familia con la enfermedad y con los métodos de curación.

El conflicto no se relaciona con un nivel de conocimientos o sea no es que tengamos nosotros un nivel de conocimientos distinto de ellos, sino simple y directamente estamos frente a diferencias de valores que conviene despear.

Paso a mi segundo grupo de preocupaciones.

En general abundan en la jerga que usamos, palabras que están tomadas de las leyes que estudian la energía y la materia y estas son leyes que hacen más a la sustancia que a la forma, por el contrario los procesos mentales, las ideas, la comunicación, la organización, la diferenciación, las pautas de conducta hacen más a las formas que a la sustancia.

Estos lleva a escuchar muchas veces que se usan principios explicativos sumamente compactos y en forma de sustantivos para decir cosas que ya no se entienden más porque la explicación no da más, se le pone el nombre sustantivado: el inconciente y si es más corto mejor, el Inc., que es más incisivo, trata de explicar muchas más cosas, entonces explica bastante poco. En realidad lo que queremos decir es que estamos ante aspectos no concientes de la conducta. Estos sustantivos cortos, como por ejemplo, oí el otro día que para elogiar un trabajo sobre familias mencionaban un Superyo lacunar: y el peligro es que gente en formación no comprenda que es precisamente un Superyo lacunar, ya que tal sustantivación denota un conjunto de normas (de tal familia) con un "hueco" en el medio, donde faltan normas.

El que está hablando de tal manera está empleando una metáfora y el peligro es que gente en formación tome la metáfora como un principio explicativo, real, como algo que existe dentro del grupo familiar y que los hace funcionar de esa manera.

Estos sustantivos cortos comienzan a ser tomados como causas y obtienen una cualidad concreta que no tienen aún en sí y lo más importante creo yo es que si dejamos de lado toda esta jerga lo más importante del psicoanálisis queda en pie y queda en pie para ser indudablemente aprovechado.

DR. SERRANO

Muchas gracias Dr. Korin. Me parece muy interesante lo que acaba de decir y tiene que ver con el lenguaje y el respeto de los pacientes que vemos y como podemos caer en usar un lenguaje o metáforas que el paciente no entiende, creo que es un aspecto muy importante y que nos va a llevar al punto que se va a cubrir a continuación.

El Dr. Isidoro Berenstein es un psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APDEBA.

Acaba de llegar de Israel, donde ha estado por más de dos años y ha organizado la Family Section en el Departamento de Psiquiatría del Cham Sheba Medical Center. Tiene publicaciones sobre temas psicoanalíticos, como Sueños, Complejo de Edipo y es de todos conocido por sus trabajos en familias.

El título que eligió es: Un modelo psicoanalítico estructural de las relaciones familiares ”.

Nos permite apreciar digamos, una combinación entre el modelo Psicoanalítico y el modelo Antropológico a lo Levy Strauss.

DR. BERENSTEIN

Antes de comenzar con la exposición, quisiera felicitar a la comisión y felicitarlos por habernos puesto el sábado a la mañana después de haber podido participar en las discusiones del jueves y en los W.S. del viernes.

Me parece sumamente importante el sábado a la mañana, porque permite una síntesis, ustedes verán, o por lo menos yo ví, que en todas las áreas se plantearon problemas semejantes, algo así como que el conocimiento debe tener una estructura, como ustedes van a ver ahora, por el cual aparece en distintos lugares, aunque, planteado en términos distintos.

Varios

Quizá esto forme el contexto de esta exposición, como dije antes y naturalmente los anteriores panelistas también formaban un contexto en el cual me parece que va a tener real sentido lo que voy a decir.

Deseo transmitirles los lineamientos básicos del modelo psicoanalítico-estructural para una psicoterapia de las relaciones familiares. Resulta de la conjunción de la teoría psicoanalítica tal como fue desarrollada por Freud, esto es una teoría del significado inconsciente y de la antropología estructural según Levi-Strauss, una de cuyas bases fundamentales es la noción de estructura inconsciente de los fenómenos culturales, lo cual a su vez reencontra el psicoanálisis. Son diferentes el sistema del aparato psíquico, el sistema de las relaciones familiares y el sistema de las relaciones grupales. Dicho en otros términos, doy por sentado que no es lo mismo tratar y formular teorías derivadas de tratar psicoterapéuticamente a un paciente acostado, a un grupo de personas sentadas con un vínculo de parentesco y a un grupo de personas sentadas sin vínculo de parentesco entre ellas.

El modelo psicoanalítico-estructural hasta hoy día me parece suficientemente fundado después de haberlo puesto a prueba con grupos familiares estudiados durante años aquí como con los que analicé en una cultura con valores y de origen diferente, en Israel.

Un modelo psicoanalítico-estructural de las relaciones familiares reúne las siguientes condiciones: 1) Las relaciones familiares tienen un carácter simbólico cuyo significado yace en la estructura inconsciente. Relaciones familiares y estructura familiar inconsciente corresponde a dos niveles lógicos diferentes. Las relaciones familiares: modos de hablar, maneras de sentarse, distribución de la vivienda, aplicación de nombres propios, etc., son miembros de una clase que los comprende, la estructura familiar inconsciente. Traté un grupo familiar cuyos nombres propios provenían en su gran mayoría de la familia materna. Sin embargo los integrantes decían que pertenecían al “santorál”. Es dable suponer ésta como una explicación encubridora, semejante a la producida cuando se ataca y desvincula el texto del contexto.

Hay familias con una disposición a aceptar la existencia del significado en un nivel distinto, aunque desconocido y que éste regula las distintas producciones conscientes. Hay familias con un

bloqueo en esa posibilidad y en la de aceptar ambos niveles lógicos diferentes. Estoy dispuesto a suponer este segundo grupo de familias como terapéuticamente no tratables, con nuestros recursos actuales. No depende del diagnóstico del miembro sancionado sino del tipo de modalidad de estructura inconsciente.

2) La estructura inconsciente de las relaciones familiares (2) es un conjunto ligado de relaciones entre términos, a saber: a) relación entre marido y mujer; b) relación de la mujer con su familia de origen a la que llamaremos "la familia materna". Esta puede estar representada por un representante; c) la relación del hijo con el o los progenitores y d) la relación del hijo con la familia materna o su representante. Las cuatro relaciones son términos organizados en un modelo transformacional. De la estructura inicial es posible obtener otros modelos de la misma familia. Las relaciones a) y b) corresponden a una generación y las relaciones c) y d) corresponden a otra generación. Lo digo en otros términos. La relación de alianza y la relación de la madre con la familia materna corresponden a integrantes de una generación (si existen los padres de la madre, los abuelos, se trataría de una tercera generación). La relación del hijo con sus progenitores y la relación del hijo con la familia materna corresponde a otra generación. En cambio las relaciones a) y d) son de orden exogámico y las relaciones b) y c) son de orden endogámico. La relación de alianza, entre marido y mujer y la del hijo con la familia materna son exogámicas y las relaciones entre la mujer y su familia de origen y entre el hijo y sus progenitores son endogámicas.

La estructura familiar inconsciente es un operador a través del cual se generan significaciones provenientes de la cultura. Llega a los integrantes del grupo familiar mediante transformaciones que le dan sentido y significado a las relaciones familiares. Estas se relacionan con las fantasías originarias de cada ser y, a través de su relación con el cuerpo, determina las experiencias infantiles. Con éstas se genera, a medida que actúa la represión y la censura, la estructura inconsciente del aparato psíquico. La estructura mental inconsciente es un operador interpuesto entre las fantasías originarias (4) y las relaciones familiares. Deseo se note la semejanza y diferencia entre la estructura familiar inconsciente y el aparato psíquico, también con una estructura inconsciente. En otro lado

(3) escribí "el inconsciente se halla compuesto por representantes pulsionales ordenados en un modelo semiótico susceptible de generar nuevas ordenaciones dentro de la misma familia de representantes. Los representantes son, el Yo como significado de la fuente del deseo; el Otro como significado de la fuente de la acción específica, el no Yo como significado de la meta del deseo y el no Otro como significado de la meta de la acción". El inconsciente psíquico es el intermediario entre el cuerpo y las relaciones familiares, mediante las cuales el cuerpo se "familiariza" o se cultiva.

La estructura familiar inconsciente es de un orden diferente y el intermediario entre el inconsciente del aparato psíquico y la cultura.

Un terapeuta de las relaciones familiares irá de las relaciones familiares, desde las interacciones familiares a la estructura familiar inconsciente.

3) Las relaciones familiares tienen una historia comprensible y vigente si se la toma en términos de la estructura familiar inconsciente, la cual organiza tanto las relaciones actuales como aquellas relaciones recordadas y relatadas como históricas. La estructura familiar inconsciente contiene el significado, el orden, el sentido y es un objeto en sí mismo, distinto de los sujetos que lo forman. Estos son elementos o signos dentro de su sistema. Considerar la estructura nos torna comprensibles las relaciones aparentemente incomprensibles, dispares y a menudo opuestas de los integrantes, aparentemente incoherentes si no se las considera en su conjunto.

4) Si el modelo expuesto es científicamente válido deberá poder dar cuenta de algunos conceptos fundamentales surgidos de otras teorías. Veamos por su importancia y su amplitud el concepto "doble vínculo". Los elementos necesarios para esta construcción son (1): a) Dos o más personas, por lo general la madre o una combinación parcial de miembros familiares, como la madre, el padre y/o hermanos por un lado y otro miembro "víctima" por otro; b) Una experiencia repetida, por lo cual su presencia es habitual; c) Un mandato primaria negativo; d) Un mandato secundario en conflicto con el primero a un nivel más abstracto, y que, al igual que el primero está reforzado por castigos o señales que anuncian un peligro para la supervivencia. Este mandato está a

un nivel lógico diferente respecto del primero; e) Un mandato negativo terciario que prohíbe a la víctima escapar del campo; f) Todo este conjunto se convierte en una estructura por lo cual la emergencia de uno solo de los elementos funciona como signo del conjunto. Sugiero que los dos mandatos contradictorios corresponden al significado de la relación de alianza por un lado y la relación con la familia materna por otro, significados conflictivos que organizan la familia en una formación dualista, un subgrupo por un lado y otro subgrupo por otro, no importa que un solo miembro forme parte del subgrupo. Esta organización tiene carácter de permanente y además contiene consignas determinantes de la imposibilidad de salir de aquella. La preservación del sistema es más necesaria que la de sus integrantes, sería una consigna de estas familias.

Una seria perturbación mental se genera cuando un sujeto disposicionalmente apto está expuesto a un conflicto permanente y a una oposición competitiva entre el vínculo de alianza y el vínculo con la familia materna. Tal como he descripto se refiere a la oposición entre la relación marido-mujer o, desde la perspectiva del hijo, la relación papá-mamá, cuando está impugnada en otro nivel por el vínculo mujer-familia de origen o, desde el hijo, mamá-familia materna. Cuando esto ocurre y este segundo vínculo es predominante sobre el primero produce las condiciones para producir desorientación, confusión, desrealización y despersonalización.

Puedo asumir que la clásica descripción de la madre esquizofrenógena o la más completa, propuesta por Bateson y colaboradores son transcripciones correctas pero parciales respecto de una estructura familiar inconsciente como la descripta más arriba. El hijo expuesto a esta situación deberá escindir su mente para hacerla concordante con la escisión solicitada para tratar su vínculo con los padres y su vínculo con la familia materna toda vez que el predominio de la segunda se oponga y quite vitalidad al vínculo de alianza. Apoyo la afirmación de Bateson cuando afirma que "la falta en la familia de alguna persona (por ejemplo, un padre fuerte y comprensivo) que pueda intervenir en las relaciones entre la madre y el niño y apoyar al niño frente a las contradicciones en juego". Podría ampliarla diciendo que la falta de un padre continúa la

falta de un marido que pudiera haber ligado en la alianza a su mujer obtenida de una familia dadora, de manera de establecer con ésta una relación diferenciada, permitiéndole a la mujer hacer el pasaje de hija a esposa, lo cual permite hacer el pasaje de esposa a madre y del marido hacer el pasaje de esposo a padre y del niño en hijo. Claro está que la elección del marido por parte de la mujer, y a la recíproca, fue determinada para el cumplimiento de esa función en el delicado intercambio entre la familia materna y la familia conyugal.

Lo descripto es un modelo semiótico de la estructura familiar inconsciente y sus transformaciones nos darán otras estructuras derivadas. La investidura de significado nos ofrecerá una tipología de relaciones familiares original y no derivada de la nosología psiquiátrica individual.

Hasta aquí he descripto sucintamente el modelo psicoanalítico-estructural de una psicoterapia de las relaciones familiares. Desde el punto de vista técnico, este modelo incluye como instrumento terapéutico la interpretación y la construcción para tornar comprensible la determinación y el significado de las relaciones familiares provenientes de la estructura familiar inconsciente. Ninguna modificación sintomática afecta la estructura inconsciente, frecuentemente la encubre. Las interpretaciones deberían apoyarse en observables de la estructura familiar y no en observables derivados del sistema inconsciente del aparato psíquico de los integrantes.

En una sesión con una pareja señalé que ambos integrantes parecían más atentos al marido y su manera atractiva de hablar, de formular sus comentarios, que a la información transmitida. El marido respondió que se había especializado en hablar de manera tal que el mensaje no entrara directamente en el oído del interlocutor sino después de dar tres vueltas alrededor de la cabeza y entrara entonces por los sentidos. Por su lado, la mujer aprobaba con gusto la manera de hablar del marido, pero luego lo criticaba acerbamente por motivos tangenciales. Basado en algunas evidencias actuales y previas opté por interpretar el intento frustrado del marido de ligar con tres vueltas a su mujer, respondiendo a un pedido latente de ésta para ayudarla a completar su casamiento y la unión con él y ayudar al desligamento del vínculo con la madre.

Posiblemente las tres vueltas fuera una referencia transferencial, éramos tres los participantes, la pareja y yo, y me habían investido inconscientemente de representante de la familia materna de la que había que desprender a la mujer para poder completar la alianza con su marido. Anteriormente habían comentado que todos los veranos lo habían pasado en una casa de veraneo de la madre de la mujer y esa circunstancia ocasionó siempre un malestar invencible e incoercible.

No tomé para interpretar, por ejemplo, la identificación del marido con una madre envolvente, experiencia infantil derivada de la semantización de una fantasía originaria de seducción mediante una experiencia infantil derivada del complejo de Edipo. Podría agregar la proyección en la mujer y la identificación en ésta de una boca hambrienta e insatisfecha. Estos elementos los considero parciales en una terapia familiar o de pareja o los haría relevantes en un tratamiento psicoanalítico de los integrantes.

Otro ejemplo (*). Una mujer solicitó una entrevista de pareja al terapeuta a quien conocía previamente de otro contexto. A la entrevista de pareja concurrió sola. Hizo hincapié en el sufrimiento derivado de una relación matrimonial infortunada, debido al trastorno mental del marido. Cuando a la segunda entrevista llegaron ambos integrantes de la pareja, la mujer acomodó los asientos de manera tal de ubicar al marido poco más adelante y cerca del terapeuta y ella un tanto atrás, desde donde era más sencillo tener un vínculo visual con el terapeuta, excluyendo aparentemente al marido. Posteriormente y para formular de una manera comprensible la naturaleza de la desaveniencia, contaron como se relacionaban para organizar un acontecimiento social y familiar, la festividad de la navidad. La mujer deseaba instalar un arbolito de navidad en la casa, tal como se hacía cuando ella era chica. Le parecía una bella manera de festejarlo. El marido se opuso terminantemente, no encontraba ningún sentido en tener un árbol navideño en su casa, no obstante ser igualmente católico observante. La mujer insistió por las vías de los hechos consumados e instaló el adorno que tan caro le era desde sus años infantiles.

El marido ante el hecho consumado y en el colmo del paroxismo rompió el árbol. Esta interacción ocurrió varias veces. En una interacción conjunta repetitiva la mujer instaló otros arbolitos y el

marido los rompió sistemáticamente. Podemos decir que la presencia del terapeuta estimuló un relato y una interacción donde en sus distintas secuencias se pueden recoger indicios de un ataque al vínculo de pareja, ataque conjunto aunque manifiestamente proveniente de la mujer, con la intervención del marido al aceptar el diseño del vínculo y el significado propuesto por aquella. El ataque al vínculo matrimonial proviene del ligamen de la mujer a su familia de origen cuyo significado intenta ser reproducido en el vínculo matrimonial. El marido está imposibilitado de desligar a su mujer de la familia dadora, de la mujer y de la matriz de significaciones (en lo manifiesto, la manera de festejar la Navidad). Esa imposibilidad se perpetúa toda vez que el marido "rompe" las evidencias sin poderlas regular con una ley o un encuadre propio de la pareja y sin poder hacerlo consciente.

La función del terapeuta consiste en recoger lo observable y realizar la interpretación y/o construcción, los cuales tendrían los siguientes pasos: 1) **Interpretación simbólica**: el relato de la interacción así como la interacción misma tiene un significado que no pasa por la conciencia de los integrantes de la familia; 2) **Interpretación de la repetición**: los integrantes intervienen en una interacción repetitiva. No se puede repetir si no se es acompañado en la repetición (A). Este paso de la interpretación incluye, por parte del terapeuta, el uso de pronombres plurales en sustitución de los pronombres singulares usados por los miembros familiares para señalar la no pertenencia a la interacción del sistema, al cual colaboran sin darse cuenta. En otros términos sería a la interpretación del sistema, al cual colaboran sin darse cuenta. En otros términos sería la interpretación de las identificaciones proyectivas cruzadas, mutuas y respectivas; 3) **Interpretación de la formación dualista**: la escisión del sistema familiar es un modo de organización defensivo de la interacción repetitiva; 4) **Interpretación transferencial**: el significado y la emergencia de estas modalidades fue estimulado por la presencia del terapeuta, quien ocupa en la estructura familiar el lugar de un personaje significativo de la actualidad o del pasado, como una figura total o como una figura compuesta de varios rasgos parciales; 5) **Interpretación contextual**: desde donde atribuyen significado a los mensajes recibidos, entre ellos las mismas interpretaciones y las bases sobre las cuales se construyó el

código familiar. 6) **Interpretación histórica:** la estructura de las actuales relaciones siguen el mismo modelo que la organización del relato histórico de las relaciones familiares. Se refiere a la correlación entre estructura familiar e historia familiar; 7) **Interpretación de la modalidad de la relación de alianza;** 8) **Interpretación de la modalidad de la relación con la familia materna;** 9) **Interpretación de la modalidad de la relación del hijo con la relación de alianza,** esto es con los progenitores; 10) **Interpretación de la modalidad de la relación del hijo con la familia materna.** Los últimos cuatro pasos, esto es las interpretaciones 7), 8), 9) y 10) permiten realizar 11) **Construcción de la estructura inconsciente familiar,** ligado como un conjunto transformacional, esto es con la posibilidad de hacer predicciones acerca de las transformaciones posibles.

La descripción de la interpretación y construcción antecedente se refiere a una serie de pasos lógicos y no cronológicos. Esto es, he tratado de describir un modelo de interpretación acorde al modelo psicoanalítico-estructural de las relaciones familiares.

DR. SERRANO:

Muchas gracias Dr. Berenstein. Me parece muy feliz completar las diversas secuencias que les hemos presentado y sobre todo tratando de hacer una cosa más conciente, en este aspecto de la familia, en torno a la situación familiar y como la podemos calibrar digamos, en la progresión de la enfermedad a la salud.

Escriban las preguntas que tengan interés de hacer para que los panelistas puedan contestarlas y que si éstas se repiten, trataremos de hacer que sean contestadas en conjunto por los diversos panelistas.

Tenemos una cantidad de preguntas que fueron repartidas entre los panelistas, algunas fueron asignadas directamente y otras las asignamos aquí y todas las preguntas van a ser contestadas en grupo porque hay cierta duplicación o similitudes entre ellas. El Dr. Berenstein tiene varias.

DR. BERENSTEIN:

Varios

Hay un pedido de aclaración del licenciado Serruti acerca de aclarar un poco más el siguiente punto: interpretación del encuadre, interpretación de la interpretación, creo que esto lo voy a poder juntar con otra que dice me gustaría que el Dr. Berenstein explicara algo más con respecto a cuál es el criterio con que establece que familias pueden ser no tratables. Estas preguntas se relacionan entre sí y esta también: "¿La interpretación no será tomada por la familia como algo ajeno a ella, como un mito conceptual extraño a la cultura preexistente a la familia?"

Estas son tres preguntas agrupables en algo que provisoriamente podemos llamar: trastornos conceptuales. Con esto se relaciona un intento de entender porqué había familias que abandonaban el tratamiento cuando yo no lo había podido prever, y que además del problema narcisístico que esto me presentaba me ponía frente al problema de hacer un tipo de diagnóstico; yo recuerdo que en Israel donde yo llegué sin saber hebreo, prácticamente, cuando yo trabajaba en el hospital, tenía un hebrero básico, entonces yo me dí cuenta que las familias me decían que en realidad había dos tipos de conducta, una de ellas me decía: "mire, no le entendemos, debe ser por el idioma" y otras familias sí entendían. Por supuesto esto iba junto con mi conciencia de que decía lo que quería decir más mi coterapeuta que me decía que él sí me entendía, pero me encontré además que estas familias a medida que pasaba el tiempo hablaban un hebreo más y más sofisticado y más y más literario, y cuando se trataba de las otras familias hablaban conmigo un hebreo más comprensible. Lo que quiero decir es esto: que cuando uno emite un mensaje da por sentado que hay un universo común de significados entre el que lo emite y el que lo recibe. Hay determinados tipos de trastornos que afectan a esta posibilidad de atribuir, de establecer un contexto compartido, entonces cuando uno como terapeuta establece un encuadre define un contexto que los pacientes pueden aceptar o no, si no lo aceptan no hay problema, porque no hay marco terapéutico, pero el problema es con los pacientes que sí lo aceptan como encuadre y después sobreimponen sobre el encuadre terapéutico un encuadre familiar cuyas normas son secretas, entonces uno no entiende porqué la familia le responde a una interpretación que no dijo. Quiere decir que la misma interpretación es entendida de una ma-

nera distinta. Como esto me pareció que era bastante sistemático de un tipo de relación familiar lo llamé: trastornos familiares perturbados, con trastornos conflictuales. Ahí a mí me ayudó a no hacer interpretaciones del contenido sino hacer interpretaciones conceptuales. Entonces la interpretación era anticipada de una apreciación de otro tipo. Yo pido que ustedes traten de escucharme en el mismo sentido que yo digo, entonces si es así yo les voy a decir que tal y tal cosa, porque lo formulé así por qué entonces permitía definir que el enfoque familiar no era un encuadre terapéutico sino que los familiares eran ellos, que venían a tratarse conmigo y que yo era el encargado de hacer la traducción o la corrección semántica de lo que ellos traían, por que si yo pasaba a ser un familiar más esta construcción estaba invalidada.

DR. SERRANO:

Yo le pediría al Dr. Berenstein y le agradecería ya que el tiempo es breve si puede sintetizar así se pueden contestar más preguntas entre los otros panelistas.

DR. BERENSTEIN:

Entonces termino diciendo que esas familias con trastornos conceptuales se refieren a familias que no aceptaron la ley del padre para establecer la alianza para definir un contexto en una relación matrimonial diferente, autónoma del contexto de la familia materna.

DR. SERRANO:

El Dr. Mendez Elizalde tiene algunas preguntas que va a contestar.

DR. MENDEZ ELIZALDE:

A raíz de algo que dijo el Dr. Korín, quisiéramos aclarar un mal entendido que pudiera haberse deslizado en nuestra exposición. En efecto, pareciera como que la teoría psicoanalítica inten-

Varios

tara ocupar todo el campo familiar. El sentido que le damos es inverso. Siendo la familia una institución, su dominio pertenece a la sociología, el derecho, la antropología, etc. Lo que sí trataría de determinar sería cual es el lugar que le corresponde al psicoanálisis, o sea un sentido restrictivo. Lo contrario sería pretender que el psicoanálisis diera cuenta de todas las ciencias conexas.

Primera pregunta:

Desearíamos saber por qué considera usted que la intervención del Dr. Gurman fue necesaria en esos términos, y si no hubiera sido mejor una interpretación en cuanto a lo que él podía percibir de lo que pre-conscientemente estaba estableciendo a la familia, en cuanto al conflicto percibido por los hijos frente a las relaciones de los padres.

Respuesta:

Efectivamente se podría pensar así. Pero lo que yo privilegio es precisamente ésto que aparece como tan dudoso, casi como una metida de pata, pero una metida de pata salvadora. Es el trabajo de un psicoanalista donde lo que produce efectos son cosas en las cuales él se debía hasta de su propia ideología. Actúa una función ausente como a pesar de él mismo. A esto me refería cuando indicaba un vacío concreto en la teoría. Estoy de acuerdo en que lo importante es como elaborar esto y el por qué del alcance simbólico de estas intervenciones.

En cuanto a la otra pregunta: ¿En el libro, Burman se pregunta cómo elaboró lo que él explicitó? ¿Se dieron los pasos necesarios para su elaboración? ¿El conocimiento del secreto le sirve a la familia que se le imponga de afuera?

Son tres preguntas que las voy a contestar en una sola. Precisamente se trata de cosas que no fueron estrictamente elaboradas. Aclaro que hubo muchas interpretaciones, pero lo que influyó fue que a partir de ese momento se produjeron todos los cambios en un sentido de ordenamiento cambió toda la estructura familiar, esta chica dejó de robar, etc. y empezó a ocupar un lugar completamente distinto en la casa o sea, diría yo que en éste momento y podría decir que no se dieron los pasos necesarios para una elaboración, sino que fue como un ordenamiento, y si la familia es una estructura

y además una organización esto tiene su valor importante y no solamente semántico, y en cuanto al secreto si le sirve o no a una familia que se le imponga de afuera, yo diría que parece que sí, el hecho de que alguien contenga un secreto como denunciándolo, tanto tendría como una función, donde parecería que precisamente en una familia que no había secretos, la vida sexual de los padres que era como notorio y público, era ignorada por los padres y sabida por los hijos.

DR. SERRANO:

Gracias, ahora el Dr. Canevaro va a contestar preguntas.

DR. CANEVARO:

Hay una pregunta que me pasaron a mí para responderla. ¿Cuáles son los parámetros que toma para indicar terapia familiar en pacientes neuróticos?

¿Alguién recuerda quién la formuló, para poderla explicitar mejor?. (nadie contesta)

Puede ser como parte complementaria de un tratamiento individual, cuando está estancado o interrumpido o cuando hay reiterados fracasos terapéuticos y en pacientes que en principio no tienen porqué tener síntomas psicóticos. Podría ser también una indicación para las crisis normales en la vida de una familia y por lo menos requerir algunas entrevistas para acompañarlos en esos momentos de cambio.

Otro tipo sería la situación de rebeldía adolescente y dificultades de entendimiento con la familia de origen; crecimientos de los hijos, o enfermedades graves o la muerte de algún familiar que cuando no se toma en un trabajo en conjunto puede pensarse que aparentemente se ha elaborado ese duelo, cuando en realidad quizás lo encontremos desplazado en otra generación. Todavía no tenemos suficientes criterios para aunar y poder predecir fenómenos y saber cuanto hemos podido ayudar a una familia en la prevención primaria.

Yo pienso que la terapia familiar es una de las grandes indicaciones preventivas pero no tenemos posibilidades de confirmar porque esto es así.

Varios

A veces la crisis psicótica grave en una familia, se reduce a expresar un fenómeno "en cascada" que viene multigeneracionalmente determinado.

Si hacemos un buen trabajo con esta familia a lo largo del tiempo necesario, probablemente podamos ayudar a que se pare ese fenómeno en cascada y así aliviar a las generaciones siguientes.

Nosotros tenemos una institución que nos ha permitido por ejemplo observar cómo una misma rama familiar y por vías totalmente distintas nos llegan a tratamiento y que si los podemos confrontar en una estructura multifamiliar, comprendemos mucho mejor cómo varias generaciones están involucradas en un proceso patológico, y esto no es por azar.

Esto comenzó en el año 50 aproximadamente y ya que pensamos en un sentido familiar y social, utilizaremos eso no solamente como fuente de información para la comprensión de las necesidades diagnósticas y la intervención terapéutica, sino también en un sentido profiláctico. Nosotros tenemos experiencia en trabajar con enfermos en diálisis y con enfermos con cáncer o hemofilia; con problemas de adolescentes y sus familias. Estas familias están continuamente sujetas a excesivas demandas de aspectos emocionales e instrumentales que traen un desgaste de sus recursos internos. Si bien primariamente puede haber más psicopatología, también puede ser secundaria al stress de los fenómenos psíquicos.

O sea que si se piensa en familia y se ve al individuo en un contexto psico-social, no utilizar estos instrumentos simplemente para el tratamiento de enfermedades píquicas o psiquiátricas sino que también en un nivel preventivo educacional, por ejemplo en escuelas y personal educacional, etc.

Quisiera que en los próximos momentos pudiera haber intercambio entre el panel de las distintas opiniones, e inclusive podrían responderse algunas preguntas que no han quedado contestadas.

Algunas de las preguntas que tengo acá tienen que ver también con una interpretación que yo la puedo hacer un poquito libre: "Y si aceptamos que no se interpreta. ¿Qué es lo que se hace? se piensa en lo que se hace en tratamiento de familia?"

Mi asociación libre apunta y me doy cuenta de algo que tiene que ver con la esencia de como se conceptualiza lo que es funcional de

lo que es disfuncional, esencia del cambio, que clase de intervenciones ejercemos o que tratamiento utilizamos y todos los miembros desde el panel han enfocado en algún aspecto u otro esto, y si hay interpretación o no ya veremos, en el nivel verbal, o no verbal, en el nivel preconciente o conciente. Hasta donde llevamos eso, o si lo necesitamos en todos los casos.

En fin, en ese sentido es lo que quiero pedir y hago mención de que el panel empieza.

DR. GARCIA BADARACCO

Yo tenía dos preguntas que quería responder muy brevemente para cumplir con ellas y poder dialogar.

Una es de: una persona que trabaja con drogadictos en instituciones y pregunta si los niños se incluyen y como podrían incluirse.

Nosotros en los grupos de terapia familiar no incluimos niños, sino adolescentes a partir de los 15 ó 16 años y con buen resultado en la interacción que ellos pueden realizar, pero, por otro lado, el coordinador debe marcar las situaciones poniendo límites y conduciendo el grupo con el objeto de procurar intercambio de ciertos temas que puedan adaptarse a la edad de las personas que juegan allí. Por otra parte, los niños pequeños pueden incluirse en los grupos con padres, siempre que la temática, con la participación del terapeuta coordinador tenga en cuenta la naturaleza de la condición infantil, de la importancia que puede tener el ubicarse en esa edad.

Hay otra pregunta que dice que: ¿si en una estructuración de identidad, la conflictiva de la resolución del complejo de Edipo, marca el proceso de identificación; el alejamiento del paciente de su núcleo familiar no entorpece el pasaje de un proceso de identificaciones psicóticas hacia más neuróticas posible de ser manejadas en un proceso transferencial terapeuta-paciente?

Si, es así. Yo pienso que en estos casos precisamente la inclusión de la familia es lo que favorece el proceso de disolución de identificaciones patológicas a través de construcciones de identificaciones positivas, fundamentalmente con los terapeutas, pero no solamente con ellos sino también con las nuevas actitudes que los fa-

Varios

miliares, en el proceso terapéutico familiar pueden ir desarrollando.

El problema que se planteó es que, si en una estructura familiar ha habido un padre ausente, nosotros podemos ayudarlo a hacerse presente a través del proceso terapéutico familiar, donde el hijo podría reencontrarse con un padre diferente y hacer una parte de su proceso terapéutico acompañado por el mismo.

Ahora, estos puntos son respuestas a preguntas, pero a mí lo que más me interesaba era la interacción del panel.

Ahora, esto no es nada fácil porque tendríamos que tener por delante mucho tiempo y por otra parte algunas afirmaciones pueden aparecer como abriendo una problemática muy compleja que no se puede resolver en el panel. Por lo tanto sería quedar un poco como aprendiz de brujo tratando de sacar temas un poco complicados que no vamos a tener tiempo de resolver.

Pero mi observación es que de alguna manera hay una pregunta, o un problema o un planteo, que se centra sobre el rol del terapeuta.

El Dr. Serrano comentó en algún momento que había una pregunta que decía: aceptando que no se interpreta ¿qué es lo que se hace en terapia familiar?. Algunas respuestas se dieron desde ejemplos clínicos en donde una actitud del terapeuta pudo cambiar la estructura a partir de ese momento y el terapeuta se pregunta que es lo que hizo si no fue justamente una interpretación.

Lo importante en este punto es que el terapeuta se incluyó en un campo psicológico cumpliendo un papel que hasta ese momento había faltado. Esta presencia del terapeuta como inclusión dentro de los aspectos faltantes de la estructura familiar, es algo característico de la terapia familiar como posibilidad; y nos ilustra de la necesidad de tener más en cuenta, en las terapias individuales, donde actualmente se trabaja con el esquema de que el proceso terapéutico pasa solamente por la transferencia del paciente hacia el analista. Ahora este punto creo que lo planteó también el Dr. Korin, cuando dijo que interpretar el inconsciente podría ser no sé bien que palabra empleó pero algo así como un "disparate". Yo lo entendí en el buen sentido de la palabra: no que eso era un disparate sino que ya estaba incluido en el proceso terapéutico de elaboración. Pero hacerlo como sistemático es perder de vista que hay otras funciones terapéuticas esenciales que no pasan por la

interpretación. En esto creo que es un punto que coincide con la problemática que trato de detectar en estas situaciones y que ha sido central en mi propio aporte, aunque a lo mejor no se destacó suficientemente.

Ahora, el punto un poco más difícil, tal vez, de intercambiar, es con el Dr. Berenstein porque curiosamente el desarrollo del Dr. Berenstein de las etapas de una interpretación posible, coincide con mi experiencia clínica, pero en términos de etapas del proceso terapéutico que no es el proceso de interpretación sino que es una estructura vital de la dinámica de las relaciones en la medida en que se van produciendo cambios significativos. Es decir: yo comprendo como muy interesante poder formular por ejemplo, la patología o la estructura familiar en términos de las relaciones inconscientes.

El cambio significativo, es que faltó la inclusión del padre, por ejemplo, en un momento dado de la evolución, o en muchos momentos de la evolución de una estructura familiar, y que puede hacerse presente en determinados momentos a través de la intervención del terapeuta.

Pero esa actitud terapéutica trae cambios que no están incluidos en la estructura inconsciente de la familia, y modifica no solamente a ésta, sino también los recursos propios que cada individuo tiene para manejarse con su propia estructura inconsciente y en la estructura inconsciente de sus vínculos con los demás. Por lo tanto los aspectos de desarrollo propio, alcanzables, incluidos en el proceso terapéutico, no pueden ser sino deslindados en la estructura inconsciente como carencias significativas de una estructura más sana que tiene que ser visualizada en los distintos pasos a alcanzar en un proceso terapéutico. Esto quizás nos llevaría por supuesto, a una discusión mucho más compleja o mucho más profunda y lamentablemente en este momento pueda parecer como una oposición entre dos formas de pensar, que tienen muchos puntos en contacto.

Ahora hay un aspecto sí, en que pienso que hay diferencias significativas. El Dr. Berenstein, dice que en las interpretaciones se incluía, precisamente la necesidad de destacar una dificultad que es, que él estaba hablando desde un lenguaje que la familia no

Varios

podría comprender y la familia en cierto modo le solicita que él se incluya como familiar, y que él les significa que no es un familiar, sino que es el terapeuta. En nuestra experiencia, hay familias que necesitan algo absolutamente diferente al proceso terapéutico: que el terapeuta tenga la posibilidad de incluirse como familiar en algún momento, por supuesto no como una situación estable, sino más bien como hechos significativos, porque esa inclusión como familiar hace posible el desarrollo de la significación simbólica. Es decir, no me voy a hacer cargo de una familia como si yo fuera el padre o la madre, en un rol que no se dió, etc. Pero en un momento dado una inclusión como persona real cumpliendo una función que no se dió, es absolutamente necesaria para hacer posible un proceso terapéutico. En ese sentido entonces, creo que la clasificación de familias difícilmente tratables, en el sentido como son las familias con las cuales tenemos una gran dificultad para comunicarnos, es un buen intento de clasificación. Sin embargo esto no debe impedarnos ver, que a veces la familia nos solicita más allá de esa situación y que la posibilidad de hacer ese paso, es lo que permite rescatarnos de la dificultad de no poder comunicarnos con una parte inherente al proceso terapéutico. No sé si he sido claro, pero creo que es una problemática muy interesante.

DR. SERRANO:

Pide media hora más. Todos de acuerdo. El Dr. Korin tiene una pregunta para el Dr. Berenstein.

DR. KORIN:

El trabajo de Berenstein me produjo una gran admiración por la fuerte coherencia interna que tiene. Entonces cuando uno se encuentra con este tipo de trabajo, parece que una especie de luzbelito interno me hiciera buscar ciertas brechas para ver de dónde sacarle la universalidad o sacar esa coherencia tan firme.

Yo dudo que pueda, pero la tentación me lleva a preguntarle por lo siguiente: como puede ser tan abarcativo, tan universal, y no figurar ojo, o sí figurar, la vía paterna, o sea: la familia del padre?

DR. BERENSTEIN:

La verdad, que como dice Jorge es como difícil dialogar ahora, en que consiste esta dificultad. A mí me parece que yo no termino de entender porqué a la gente le es tan difícil establecer diferencias, y porqué le es más fácil llevarse a establecer semejanzas aún cuando sean semejanzas formales. Esto es un obstáculo con el que yo me encontré realmente, desde hace mucho tiempo, como para poder en poco tiempo establecer una discusión. De paso les refiero que fue mi propio problema cuando empecé con todo esto. Por ejemplo, yo tomaba solamente una frase, pero no tanto para discutir nada con Jorge, sino como para ejemplificar el tipo de problema que se genera, como el tipo de problema que se puede plantear en el ejemplo de Mendez Elizalde, donde hubo una intervención del terapeuta. Donde Jorge dice, que la actitud del terapeuta, cambió la estructura, yo puedo decir cómo yo entendí la pregunta, porque coincide con una discusión interna que tengo con Minuchin, que es, que entiende él cuando habla de estructura, y resulta que yo encuentro que cuando él habla de estructuras, yo hablo de sistemas y no es solamente una diferencia, y no es un preciosismo terminológico, sino que yo encuentro que él tiene como recursos maniobras, porque cambia la estructura, si yo lo tengo que pensar de acuerdo con el sentido que le atribuyo a esa palabra. Para mí en cambio, el sistema trato de cambiar las relaciones familiares, por lo tanto así, sino llega a la estructura inconsciente, para mí son cambios sintomáticos. No es que son de menospreciar los cambios sintomáticos sino que no cambia las estructuras inconscientes. Pero entonces, a qué le llamo yo estructuras? Hay un libro de Bastide, como un coloquio sobre el término y sentido o acepciones del término "estructura". Ahí se pueden dar cuenta del verdadero pandemonio acerca de ese término. Entonces, si yo le llamo estructuras a un conjunto ligado de relaciones, que no las voy a repetir, quiere decir que si no logro establecer algún cambio en la semántica, en el significado que proviene de esa estructura, yo no podría decir que el terapeuta cambió la estructura. Esto no es para discutir con Jorge, sino para establecer una discusión semántica, seguramente en el sentido que él le da y en el que yo le doy, sino porqué hacemos precisiones semánticas. Y esto pasó hace mucho

Varios

tiempo, resulta que todos decimos lo mismo y nos damos cuenta que esto nos deja un malestar, por el cual uno se da cuenta que no dice lo mismo que el otro. Entonces cuando yo me planteé hacer una presentación ante ustedes, una presentación taxativa, era para que se notara que este enfoque es diferente a otros. Por ejemplo es diferente al enfoque de los interaccionistas porque los interaccionistas postulan que no toman en cuenta motivos, que no es que los desestiman, sino que no toman en cuenta la historia y el significado inconsciente, entonces no es lo que trato de decir yo. Entonces, esto creo que es lo que trato de describir sin mucha extensión de tiempo. Trato de solamente de establecer o por lo menos a mi me gusta establecer diferencias entre este enfoque y otros que se refieren a relaciones familiares, como diferenciar lo que pasa en un aparato psíquico de lo que pasa en una estructura familiar, porque yo dejo sentado que una estructura familiar no es la suma algebraica de dos aparatos psíquicos, por eso no cobra sentido como decía, Santiago, hablar de Superyo Lacunar, porque el padre no es el super yo. El padre actual no es el Superyo, porque el superyo como definición es la Imago del paterno infantil más el narcisismo del chico, por lo tanto el señor que se llama el padre, no es el Superyo, entonces, si no es el Superyo, hay que inventar otro nombre, otra terminología y si hay que inventar otra terminología, no hay porqué desestimar algunas, siempre y cuando se las reivindique, entonces lo voy a hacer con un concepto epistemológico obligatorio como es el inconsciente; por eso yo me doy cuenta, que yo no hablo de otros términos analíticos, cuando hablo de un aparato psíquico de un paciente.

Platea: Es posible el diálogo?

DR. SERRANO:

El panel todavía está frustrado con muchas cosas que quedaron en el tintero y un comentario que yo quería hacer es por ejemplo destacar la importancia de diferenciar lo que yo llamo "terapias cosméticas" a oposición; de las terapias más constructivas o re-constructivas que buscan profundizar cambios a otro nivel.

Al Dr. Canevaro le quedó algo para contestar.

DR. CANEVARO:

Cuando oía lo que estaban hablando los colegas y es una cosa que se reitera en cada panel, al enfocar la terapia familiar y otras terapias o la diferencia entre teoría y técnica, me vino a la memoria dos cosas: una es una frase del filósofo Gabriel Marcel cuando decía: "los órganos piensan a través del cerebro", a propósito de la unidad psicosomática.

Otra cosa que me vino a la memoria es una lectura sobre los indios canacos de la Polinesia. Esta tribu piensa que los pensamientos rezuman del cuerpo y pasan a través de la cabeza hacia la realidad externa. Entonces el mejor elogio que ellos podían hacer de una persona, es llamarlo "cabeza hueca", porque entonces los pensamientos no están detenidos, no se constipan en la cabeza.

Esto me hace pensar en algo que veo permanentemente, no solo en mi autocrítica sino también en numerosos casos, a lo largo de años, en una comunidad terapéutica, observando no sólo el comportamiento de los pacientes y sus familiares, sino de los terapeutas involucrados en este proceso terapéutico y los bastiones narcisísticos que cada uno de nosotros defendemos en un proceso terapéutico. Como una confrontación específica; creo que son inevitables, pero también creo que por otro lado entorpecen la síntesis creadora de un panel.

Yo quería leer algunas cosas, que no están en el trabajo de hoy, pero que sí vienen muy al caso. Es una disgresión que había hecho yo con 4 palabras, estudiadas etimológicamente, que son: terapéutica - actor - espectador y teoría.

"Terapéutico" deriva del griego "therapeutikos" - yo cuido, estoy al servicio de alguien, esencialmente hablando del enfermo, su médico.

"Actor" del latín, "actorem", el que obra "en el sentido del agente que pone en comunicación al poeta dramático con su público.

"Espectador" del latín "spectatorem", que es el que mira algo con atención" y también deriva del verbo griego Theoreo.

Y Teoría como un conjunto de sistematizaciones, de opiniones sobre un tema determinado con un conjunto de leyes y reglas que

Varios

son la base de las ciencias y también deriva del verbo griego theoreo y es la misma raíz que espectador.

Entonces yo diría que: en delicado y sutil interjuego dialéctico, une y a la vez separa estos elementos, porque la raíz de theoreo, es contemplar, asistir como espectador. Entonces este interjuego dialéctico une y separa estos elementos que forman dos pares antitéticos si se los emplea simultáneamente.

Cuando somos terapeutas, somos también actores participando de ese drama; obramos con todas nuestras posibilidades de sentir y de accionar, de pensar en función de lo que nos está pasando. Cuando somos espectadores, también sentimos y pensamos como personas, pero más en función de lo que vemos.

Cuando teorizamos puede ser sobre los recuerdos o sobre el trabajo de otros, pero en ese momento dejamos de ser terapeutas. La ubicuidad de nuestro trabajo, consistirá entonces en situarnos, no solo en saber qué y cómo vamos a hacer, sino fundamentalmente cuándo lo vamos a hacer.

La terapia grupal, especialmente, la del grupo familiar, crea un espacio que favorece la actuación o la regresión, que pone en evidencia actitudes habitualmente disociadas y que recrean situaciones conflictivas de intensa carga emocional. El trabajo con los mismos objetos reales externos que protagonizaron pretéritas conflictivas, hace que el "calor de la transferencia" sea por momentos altísimo y que comprometa la capacidad emocional y cognitiva del terapeuta. Enfrentado a ese sistema no puede dejar de estar incluido en él y una actitud de prescindencia emocional sólo complicaría las cosas.

El terapeuta tiene que tener la habilidad de estimular situaciones conflictivas latentes y a la vez "ponerse de lado" en la expresión transferencial, no para eludir la responsabilidad, sino para que los conflictos puedan resolverse entre quienes los crearon, participando como conductor de ese proceso ayudando a unos y a otros, a la libre expresión de sus afectos.

La elaboración compartida posterior da lugar a un tipo de actitud más reflexiva, momento necesario de síntesis.

En fin estas palabras son un poco para ubicar como yo veo el problema. El impacto de nuestras tareas hace que si no tenemos la suficiente capacidad de ponernos en juego como personas para

poder intercambiar, ya sea en supervisiones, ya haciendo que nuestro trabajo sea revisado críticamente, tengo la impresión que eso va a a quedar dentro nuestro a la manera de como decían los indios Canacos. Como algo que va perturbando la vehiculización de nuestros pensamientos y quizás la utilización tan emocional de las teorías como bastiones narcisísticos, provenga en parte quizás de la dificultad en la elaboración de lo que nos pasa en contacto con los pacientes.

PUBLICO:

Me parece que quedó flotando entre mucha gente, esta pregunta de Korín a Berenstein, como una extrañeza de por qué no figura allí la familia paterna. Creo que se trata solamente de una cuestión semántica, como había denunciado el Dr. Korín de esa tendencia a sustantivar. Si uno trata justamente de no sustantivar, se aclara la pregunta.

Creo que todos nos formulamos esta pregunta por la vigencia del modelo psicoanalítico del Edipo, que por supuesto en esta estructura triangular, le da al padre un papel fundamental sobre todo a través de la prohibición que fue calificada como paterna, y a eso se le llama la función del padre pero se sustantiva y se cree que la función del padre es ejercida como persona, cuando en realidad la función del padre es una función entendida como estructura. Entonces, comprendiendo esta sustantivación me encontré con varias respuestas: porqué si la figura paterna es importante, no figura allí, o cuál es el papel de la familia paterna? Si uno se fija bien en este cuadro del Dr. Berenstein, necesariamente Berenstein tiene que preponderar la familia materna porque de este lado está el vínculo conyugal, del otro lado está el vínculo hermana-hermano, y el vínculo hermana-hermano es justamente donde está actuando la prohibición del incesto, que es la prohibición básica de la estructura edípica; quiere decir que la función paterna, si entendemos como función paterna la prohibición del incesto, está en el lado de la familia materna entre la hermana y el hermano y no del otro lado, donde figura allí la relación conyugal. Me parece interesante esto, porque yo estoy plenamente de acuerdo con la exposición primera del Dr. Korin, sobre este peligro de las sustantiva-

Varios

ciones, y creo que hay que tener mucho cuidado porque esto puede generar una serie de obstáculos muy grandes o conflictos como éste que se han planteado.

DR. SERRANO:

Me parece muy atinado el comentario y estimulante porque evidentemente, muchas posturas entre ellas, la de la cultura árabe donde el predominio sería de la línea paterna y no materna, por ejemplo: hegemonía, dominación, etc, y las variaciones si uno estudia lo que hacen los antropólogos en los diversos grupos, según el mundo en relación a la historia, a la cultura, etc. hace que veamos que este punto no puede ser tomado nunca en forma universal. Me parece una cosa muy interesante: ya que es un esfuerzo de tratar de organizar el material de una manera vigorosa, que es lo que tratamos de hacer.

DR. GARCIA BADARACCO:

Yo quería aprovechar esta intervención última para decir algo sobre la dificultad de entendernos en poco tiempo y la dificultad de así tener comunicación. Yo entiendo que hay una serie de evidencias y de estas que dan lugar a confusión. Se puede formular la función paterna como la prohibidora del incesto pero esto dicho así, corresponde más a una estructura deficitaria en los crecimientos y desarrollos de las personas, donde el complejo de Edipo no se resuelve por la prohibición de las pulsiones libidinales dirigidas hacia las figuras consanguíneas, sino que se diluye a través de un proceso de desarrollo y crecimiento donde se puede abandonar la pulsión primitiva y canalizarse hacia la exogamia. Este proceso de desarrollo entendido de esta manera cambia cualitativamente, no solamente una concepción teórica de lo que puede ser el incesto, sino la manera de entender la inclusión del terapeuta en el proceso terapéutico mismo y la función paterna. En este sentido empieza por la madre, y no es para nada la persona real del padre porque es la madre la que empieza por dar sentido a esa realidad que incluye la necesidad de que el hijo no quede atrapado en vínculo simbiótico con ella como único exponente del mundo, sino que le abra

las puertas al mundo externo y así como decía Aristóteles la madre era dentro de la casa y el padre fuera de la casa. En realidad la madre puede si tiene una estructura mental adecuada, aprender a preparar al hijo para el afuera de la casa pero sin retenerlo en el adentro de la casa, entonces la función paterna en ese sentido empieza con la madre. Por otro lado en un momento dado del funcionamiento familiar, la inclusión a través de una actitud puede ser significativa de una función paterna, mientras que una función puramente interpretativa por ejemplo, puede ser representante de un tipo de vínculo materno simbiotizante que mantiene el vínculo narcisístico, sin permitirle al paciente liberarse de él a través de un desarrollo yoico, que lo comunique mejor hacia el afuera.

Este tipo de pensamiento que solamente es un pequeño esquema e intento en este momento aclarar un punto, surgió de la audiencia y es solamente para aclarar un punto más de una manera de pensar. Es decir que vuelvo a insistir en que la estructura de la dinámica familiar para que sea terapéutica debe incluir sí las posibilidades del terapeuta a través de su experiencia de vida, la posibilidad de acompañar a veces interpretando, a veces con una actitud como actor, como decía Cannevaro, etc., un proceso terapéutico que incluya aspectos de elaboración interpretativa de crecimiento yoico, así como experiencias nuevas, dimensiones que en la estricta visión psicoanalítica, a veces llamada ortodoxa, no está suficientemente incluida y que nosotros estamos tratando de hacer. Lo vemos cada vez más necesario, sin abandonar la perspectiva psicoanalítica en sus fundamentos esenciales, pero sí enriqueciéndolas con una serie de experiencias útiles, cuando se incluye el contexto familiar, conocido como contexto necesario para esa experiencia.

DR. BERENSTEIN:

Ciertamente me había quedado en el tintero responderle al Dr. Korin acerca de la familia materna, pero me parece que podría tomar lo que dijo el licenciado Machuca y que lo explicó muy bien. Entonces no lo voy a repetir.

Lo que quiero señalar es que oí que se discutía mucho en este Congreso, acerca del psicoanálisis o técnicas auxiliares. Como mo-

Varios

delo biológico, está bien, pero como modelo que va de lo cuantitativo hacia lo cualitativo, que va hacia la cualidad no necesariamente tiene que ser sumatoria, de manera tal que puede haber cualidades diferentes que están descriptas en términos de función. En todo caso, cuando uno se enfrenta cuando pasa a trabajar en una relación bipersonal, con una sola persona o una relación multipersonal; no es una sumatoria de individuos, es un fenómeno de una cualidad distinta. Por lo tanto, para mi gusto, recibe una teoría distinta porque cambia o hay una ruptura epistemológica, por ejemplo: si ustedes reúnen a varios individuos, cambia el criterio de la verdad, realidad, etc. De manera tal que necesariamente hasta acá y va a pasar mucho tiempo, hasta tanto no se confeccione una teoría a los observables distintos que tienen las fijaciones tipo grupo familiar, me parece que vamos a tener un déficit probablemente. Esto se acerca, y es una muy buena apertura para futuros encuentros.

DR. SERRANO:

Ha llegado el momento de agradecer a los panelistas y a la audiencia por la atención que nos han prestado hoy. Fue la intención mostrar una tecnología de la terapia familiar, donde se estructuran conocimientos pre-existentes para darnos una noción de todo un contexto psicosocial de la familia, y cómo conceptualizamos esto, y de qué manera podemos verlo aquí.

Quiero agradecer a los Doctores: García Badaracco, Cannevaro, Mendez Elizalde, Korin, Berenstein, por todo lo que han ayudado. Muchas gracias y doy por concluida esta sesión.

**Agradecemos la generosidad del Dr. Juan M. Obarrio quien nos facilitó la versión desgravada del Simposio (nota del Editor).*

DIALOGOS

Entrevista del Editor con el Dr. Ivan Boszormenyi-Nagy, sobre el estado actual del campo de la Terapia Familiar para Terapia Familiar. (Buenos Aires, Argentina, Ed. ACE L.R.L., 1978).

Editor: Dr. Alfredo A. Canevaro

C: Quisiera preguntarle su opinión acerca del panorama general de la terapia familiar en el mundo. En Europa, por ejemplo, hay algunos terapeutas, como Mara Selvini-Palazzoli que retomando conceptos de la teoría de la comunicación, paradojas y contrapadojas, han articulado nuevas estrategias terapéuticas distintas a los abordajes psicodinámicos. Pareciera como si los europeos que durante muchos años recibieron visitas y enseñanzas de pioneros norteamericanos en este campo, quisieran ahora reivindicar sus derechos a ser teóricos y dar un nuevo aliento y desarrollo a la terapia familiar. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Qué piensa Ud. acerca del desarrollo de la terapia familiar en EE.UU. y Europa?

B-N: ¿No mi propio desarrollo, sino en general?

C: Así es, aunque si quiere puede hacerlo desde un punto de vista personal, ya que Ud. es un europeo que trabaja en EE.UU.

B-N: En mi opinión, lo que ha ocurrido es que el enfoque orien-

Diálogos

tado hacia la terapia familiar se desarrolló después de haber comprobado en la práctica que se realiza una mejor terapia cuando se toman en cuenta las relaciones que cuando no se utiliza tal recurso. En un comienzo existía la opción acerca de si se la debía utilizar o no. Una vez que se la utilizó y demostró ser útil, el problema era explicar el por qué de esa utilidad, cuál era la mejor manera de enseñarla, y como desarrollarla como un sistema conceptual separado de la terapia individual.

Considero que el aspecto concerniente al equilibrio de las relaciones constituyó la gran transición entre el enfoque individual y el familiar; vale decir, el hecho de que el terapeuta deba tomar en cuenta no sólo uno o varios individuos como sistemas mentales separados, sino relaciones que tienen diversas facetas. Yo llamo a esto dialéctica de las relaciones: una multilateralidad viva que alterna de una faceta a otra. Es un flujo constante de tesis, antítesis y síntesis de facetas. Creo que éste fue el gran cambio, que todavía no hemos resuelto por completo. Se intentó comprenderlo de una serie de maneras distintas. Una de ellas consistió en ampliar la teoría dinámica individual: se introdujeron conceptos como necesidad (yo mismo me referí a la complementariedad de necesidades hace alrededor de 20 años), gratificaciones vicariantes (Johnson y Szurek), teoría de las relaciones objetales (Mélanie Klein y Fairbairn), y diferenciación versus fusión. Estos fueron algunos de los intentos de explicar la dinámica de las relaciones dentro de marcos dinámicos individuales más amplios.

Pero también surgieron marcos totalmente diferentes. Uno de ellos fue la teoría de la cognición de Bateson, una teoría del significado, de la cual nació el concepto de doble vínculo, para explicar el significado en las relaciones, como algo separado de los individuos. Nació un concepto unificador: el del sistema. Los primeros terapeutas de familia aludieron repetidamente a la teoría general de los sistemas e intentaron comprender las cosas sobre la base de que existen niveles paralelos de organización sistémica: el individuo es un sistema en un nivel inferior, mientras que los patrones (transaccionales y comunicacionales) lo eran en un nivel superior. Algunos terapeutas consideraron que se podía prescindir del nivel individual, siempre y cuando se supiera como operan exactamente estos patrones en las comunicaciones y en

las estructuras de transacciones. Por consiguiente, lo importante era basarse en intervenciones en el nivel "sistémico", con frecuencia sin mostrar el menor interés en lo que sucede dentro de la mente de cada persona. Llevado al extremo, esto condujo a la conclusión de que se puede hacer caso omiso de todo conocimiento psicológico individual, siempre y cuando uno se convierta en especialista de estos patrones relacionales o de los sistemas transaccionales.

Otro enfoque estaba basado en la búsqueda de una experiencia genuina: La escuela experiencial. Incluiría aquí a Ackerman y Whittaker, y a varios otros pioneros que acentuaron la importancia del momento de encuentro entre las personas. Algunos terapeutas tienen el verdadero don de ser muy expresivos y tienen una actitud de gran franqueza que tiene como finalidad lograr relacionarse auténticamente con la gente, y que esta relación sea lo más reveladora posible. Precisamente basan el efecto de la terapia en este hecho.

C: Tratando de poder contactarse con el verdadero self (según la noción de Winnicott). Para este contacto auténtico, habría que pasar a través de las defensas...

B-N: Eso podría ser o no así, pero no tiene que serlo necesariamente. Podría haber un enfoque experiencial basado puramente en una actitud franca y abierta, sin tomar para nada en cuenta la teoría del self falso o el self genuino del individuo. Podría desarrollarse simplemente como una teoría relacional de comunicación auténtica; nada de secretos, nada de complicidades, etc. O podría estar relacionada con lo que usted dice, alegando que la relación auténtica se establece con el self auténtico del individuo.

Pero quisiera expresarme un poco en las últimas ideas que he desarrollado, y que acentúan el aspecto ético de la dinámica, esto es, el equilibrio de HONESTIDAD entre las personas. Qué se hacen mutuamente esas personas y cómo afecta ello sus intereses vitales? Por ejemplo, yo puedo maltratar a mi hijo, puedo ser un sádico y mi hijo se convertirá en masoquista, y es posible que incluso le guste serlo. Yo puedo explotar, torturar o lastimar a mi hijo, y no obstante eso mi hijo puede amarme. Sin embargo, éticamente, lo

que ocurre es que como padre yo usé mi poder para aprovecharme de mi hijo. Y, a la larga, esto lesiona los intereses vitales de mi hijo. El hecho de que mi hijo pueda disfrutar o no con mi conducta pertenece a la psicología del niño; lo cierto es que la ética de mis actos trasciende nuestra relación y afecta los intereses vitales de mi hijo. El tiene derecho a crecer sano y a tener su propia familia, hijos y amistades. A la psicoterapia le incumben los intereses vitales de ese hijo, y no sólo sus necesidades psicológicas. Si es un masoquista, sus necesidades psicológicas le exigirán disfrutar del castigo y de la crueldad, si creciera dentro de un sistema de relaciones patógenas. Pero desde el punto de vista ético, lo que verdaderamente importa es qué le ocurre como resultado de nuestra relación. Creo que esto ilustra mi enfoque de la terapia; la principal dinámica de las relaciones reside en la dimensión ética. ¿Acaso nuestra relación puede ser confiable si yo exploto al más débil? Tal vez sea placentera porque nos complementamos psicológicamente. La falta de preocupación o de respeto por los intereses del otro constituye la esencia de la explotación en las relaciones.

C: Acerca de este tema Ud. habló en un libro suyo sobre la "complementariedad de necesidades patológicas" y que este tipo de relaciones se haría basada en un mecanismo de "diferencia de potencial" en la relación. En el ejemplo que recién dió, el padre necesita al hijo de esa manera. Ahora, ¿porqué, según Ud. este hijo no puede salir de esa relación patológica?. ¿A causa de la fuerza del padre?

B-N: El progenitor ejerce influencia sobre la personalidad del hijo y es, a la vez, miembro de la relación. Existe un componente que tiene que ver con el desarrollo y otro de tipo transaccional. El padre es poderoso en cuanto a transacción porque es adulto y sabe como ser eficaz y tener éxito. Asimismo, a lo largo del tiempo, ha ido ejerciendo influencia sobre el desarrollo de hijo, ha logrado afectar la personalidad del hijo convirtiéndolo en un masoquista, en una persona que posee un superyó que se anula a sí mismo. El padre tiene dos ventajas de poder sobre el hijo: la primera es que puede tener influencia sobre el desarrollo del hijo pequeño, y la segunda es que es un miembro más poderoso o fuerte en

cualquier interacción. Es posible que un terapeuta transaccional quiera ayudar activamente reestructurando el aspecto de poder en la interrelación. Sin embargo, y desde el punto de vista ético, el problema es éste: ¿cómo es que el padre no siente culpa por haber lastimado a su hijo?. No se trata tan sólo de un juego de complementariedad de necesidades de tipo perverso, sino de que el niño está siendo realmente lastimado, y en algún nivel el padre debe saberlo. Algunos padres matan a sus hijos a golpes. ¿Cómo pueden permanecer indiferentes a la culpa de destruir a su hijo?. Una orientación hacia las relaciones de poder no soluciona este problema. Incluso aunque en otras relaciones sea norma que el poderoso explote al más débil, si yo como padre exploto a mi propio hijo, fracaso en mi rol natural: la responsabilidad que me incumbe como padre frente al hijo que depende de mí. La ética de las relaciones es fáctica. Lo que realmente importa no es sólo corregir mi superyó sino lo que de veras le sucede a mi hijo. El enfoque "contextual" de la terapia hace una distinción entre las dimensiones psicológicas, de poder y ética de la dinámica.

C: Si tomáramos a ese padre bajo el punto de vista de una relación narcisística de objeto, es probable que él no considere a su hijo como otra persona. En este caso podríamos considerar que el padre es masoquista "a través" de su hijo y por lo tanto no siente culpa, ya que en esta simbiosis o relación vicariante, el hijo es parte de él mismo.

B-N: Bueno, ése es un aspecto de la cuestión. Es una explicación psicológica, que en alguna medida debe ser cierta. Sin embargo, si la llevamos un poco más lejos, también los intereses del hijo deben estar incluídos en la narcisismo del padre. La idea de que yo moriré algún día y de que espero sobrevivir en mi hijo, en el hijo de éste, en el hijo del hijo de éste... Es la única forma en que puedo sobrevivir. No me es indiferente que sea mi hijo o el hijo de otra persona. Mi inmortalidad narcisista necesita coincidir con la responsabilidad ética de la supervivencia de mi hijo. Por consiguiente, resulta tanto o más sorprendente que el progenitor destructivo pueda permanecer indiferente al hecho de que está destruyendo a su hijo. En mi experiencia personal, esto por lo

general puede explicarse por lo que yo denomino "REVOLVING SLATE" en *Invisible Loyalties* (1973).

En pocas palabras, significa que uno puede lastimar a personas inocentes en lugar de lastimar a padres hacia los que sentimos un resentimiento ambivalente. Debido a la lealtad intrínseca que siente hacia sus padres, a quienes conscientemente desprecia, el sujeto siente culpa hacia la persona inocente que es víctima de su trato lesivo, por lo general su esposa o su hijo.

C: ... padres idealizados.

B-N: En efecto, idealizados en un sentido psicológico; pero en términos interaccionales lo que en realidad hago es protegerlos de la culpa culpando a alguna otra persona, o lastimando a otra persona. Si bien la inculpación paranoide resulta a veces comprensible desde un punto de vista psicológico, también lo es que yo lastimo a otra persona a fin de proteger a mis padres. La sustitución ética jamás es justa, pero la persona que la realiza puede no tener conciencia de este hecho.

C: ¿Cree usted que ello se debe a razones de tipo ético, o más bien a un motivo psicológico?

B-N: A ambos. Existen dos dimensiones distintas, las dos están presentes. Y están relacionadas entre sí. Por ejemplo, es evidente que la teoría desarrollada por Fairbairn y Mélanie Klein acerca de la necesidad de tener internalizado un objeto bueno y otro malo, y de re proyectarlo en otra persona, concuerda con mi concepto de las "REVOLVING SLATE", que también constituye una ilustración de la necesidad de externalizar el objeto malo. Si, por otro lado, también siento necesidad de ser leal a mis padres poniendo el objeto malo en otro lado, entonces podría hacer ambas cosas. No es sólo que mi propio desarrollo yoico inmaduro requiera que vea a mi esposa como un objeto externo malo, sino que también los lazos filiales de lealtad invisible refuerzan mi patología, esto es, la integración deficiente de mis objetos internos buenos y malos. Puesto que soy una persona psicológicamente inmadura, necesito ver como malo un objeto externo, y como persona con lealtad

invisible llevo a cabo la programación familiar de tener con mi pareja una deuda imposible de cancelar.

C: En este caso, ¿considera usted que la otra generación, por ejemplo, el padre de este padre, está provocando esta conducta como un objeto interno, o que existen también relaciones objetales que influyen sobre esta conducta en el presente? Porque podríamos ver esto sólo como relaciones internas: este padre tiene, como objeto interno, la relación con sus padres. Pero también podríamos considerar que este padre tiene, por ejemplo, una hermana o un tío aun con vida, que refuerza estas situaciones internas como una relación objetal. ¿Cómo considera usted esta situación, en su aspecto técnico?

B-N: Mi enfoque sería incluso más activo. Diría: como terapeuta debería idear una estrategia para que la persona encuentre la mejor manera de mejorar su relación con la familia original, porque esa es la única forma de establecer relaciones éticas genuinas. En mi opinión, no es cuestión de insight o de analizar la internalización. Ese sería el enfoque psicológico. Sería correcto pero no suficiente. El terapeuta contextual formula esta pregunta: Pues bien, ¿qué puede hacer usted por sus padres? Si están vivos, ¿puede visitarlos o escribirles? Podemos investigar que tipo de ayuda necesitan: ¿son ancianos, están enfermo, son pobres? En ese momento se planea activamente hacer algo en el contexto de la auténtica relación. Supongamos que han muerto. Por ejemplo, yo tuve una paciente, una mujer joven que estaba casada y que durante mucho tiempo no había podido tener hijos. Por último decidió que puesto que no tendría hijos, prepararía la tesis para doctorarse en su carrera. También visitó la tumba de su padre, después de no haber ido durante bastante tiempo al cementerio, y la encontró en un estado lamentable, por lo cual debió dedicar muchas horas de trabajo para poner todo en orden. A la semana siguiente quedó embarazada. De hecho se puede hacer algo por las personas fallecidas. La paciente le prestó atención a su padre mientras trabajaba para arreglar su tumba. Su padre estaba muerto, pero ella hizo algo más que analizar sus sentimientos: de hecho le dedicó su tiempo. Le dio algo de sí misma. Así como, si hubiese estado vivo, lo habría visitado, no habría trabajado ese día y habría pasado algún tiempo con él.

Eso es lo que hizo. Y parecería que hubo una armonía psicósomática con esta reparación interna. Ella disminuyó su "debe" e incrementó su "haber".

C: Esto es sumamente importante. ¿Le sugeriría usted, por ejemplo, a un paciente que visitara la tumba de su padre, como indicación técnica?

B-N: Sí, como una forma de establecer un nuevo equilibrio de las obligaciones filiales de lealtad. Otra forma sería averiguar cosas sobre el padre. Por ejemplo, está ese viejo tío que vive en un pueblo lejano: ¿por qué no visitarlo y charlar con él? Tal vez se descubran hechos acerca de la infancia del padre, cosas que expliquen determinadas actitudes de él que siempre se le reprocharon. ¿Qué distintas serían las cosas si supiera cuán difícil fue su infancia! A medida que se van descubriendo sus excusas y motivaciones, se están dedicando tiempo y energías para mejorar la imagen que se tiene del padre. Porque cuando el tío haya muerto ya no será posible averiguar nada. Este proceso implica una actitud activa hacia el padre, y no tan sólo analizar los sentimientos reprimidos. En cambio, al tomar la iniciativa y tratar de obtener nuevos datos, el paciente establece una relación con el tío y, a través de éste, con su padre. Y la relación con el padre se mejora merced a auténticas cosas nuevas que se descubren acerca de él, y no tan sólo mediante la reorganización de los introyectos. Lo importante es que se buscó nueva evidencia. O bien la pesquisa pudo haberse orientado hacia descubrir y leer la correspondencia del padre. Tal vez en algún lugar de Europa alguien conserva cartas que él escribió cuando el paciente era un niño pequeño. Pues entonces, ¿por qué no leer esas cartas? Tal vez se descubra que el padre amaba mucho al hijo y estaba preocupado por él. Recuerdo el caso de una paciente cuya madre siempre le decía: "Tu padre te abandonó. Jamás quiso saber nada acerca de tí". Y luego, leyendo la correspondencia del padre, la paciente se encontró frases como ésta: "No sabes cuánto me entristece que mi pequeña hija esté tan lejos; y ahora que me he divorciado de mi mujer jamás podré verla...". Y esto no se habría descubierto nunca si no se hubiese tenido oportunidad de leer esas cartas.

Diálogos

C: Esto es muy importante. Es como un rompecabezas de la verdad. Descubrir la verdad de la relación. Algunas personas se pasan la vida entera tratando de descubrir esa verdad.

B-N: Pero también se trata de establecer un nuevo equilibrio de confianza. Si tengo éxito en la pesquisa y ese mayor conocimiento del progenitor hace que mi actitud y mis sentimientos hacia él cambien, y que de hecho mi relación con él se modifique, entonces tendré menor necesidad de convertir a mi esposa en un chivo emisor o de dañar a mi hijo. Porque considero que no se trata tan sólo del conocimiento de la verdad sino de una actitud abierta hacia los aspectos del debe y el haber en la interrelación. Si yo me esfuerzo en que disminuya la desconfianza en la relación con mis padres, puedo entonces aumentar las posibilidades de que mis hijos tengan confianza básica en sí mismos. (Erikson).

C: Usted afirma que aconsejaría leer, por ejemplo, la correspondencia. Esa paciente descubrió la verdad de ciertos aspectos de su padre. Esto es muy importante. ¿Pero no cree usted que es importante la búsqueda de la verdad, pero no sólo de la verdad con mayúscula, de lo que en realidad ocurrió, sino también de la "pequeña verdad"? ¿No cree que sería conveniente que la familia se reuniera y conversara acerca de esos pequeños "secretos" que toda familia tiene, y que sacándolos a la luz se podrían descubrir cosas importantes?

B-N: Mi razonamiento solía ser de tipo cognitivo y comunicacional. Pero últimamente he desarrollado más bien un concepto ético. En este sentido, a manera de ejemplo hipotético, lo que me ocurrió al descubrir la verdad en la correspondencia de mi padre representa establecer un nuevo equilibrio de tipo ético. En otras palabras, lo más importante es que pude humanizarlo. Siempre lo había vivido como un monstruo, un ser no querible. Pero ahora descubro que era un ser humano a quien le importaba o no su hijo. Incluso aunque lo siga viendo como un monstruo, por lo menos he descubierto como fue su infancia, lo veo no solo como victimario sino también como víctima. Y como he rebalanceado el debe y haber de méritos de mi padre, ya no necesito sentir un resentimiento

Diálogos

miento ambivalente hacia él y puedo amarlo. Si puedo confiar más en mi padre, entonces puedo confiar en el mundo, en mi pareja, en mi hijo, en todas las demás relaciones. La fundamentación teórica básica es entonces el equilibrio ético, a fin de incrementar la confianza.

C: En este sentido, ¿considera usted que la terapia familiar resulta más apropiada que la individual?

B-N: La cuestión se centra más bien en cuál es la mejor manera de utilizar los recursos relacionales. La confiabilidad es la fuente de confianza básica para los hijos: si las relaciones son confiables, los hijos pueden desarrollar confianza básica. Es en este punto donde mejor se conecta el sistema individual con el sistema ético relacional. Y este es el lineamiento básico y fundamental que debe seguirse, sea que se trate a individuos o a familias.

C: Me gustaría saber qué opina acerca de la simbiosis y la complementariedad patológica de necesidades. Considera usted que desde un punto de vista clínico, son las mismas cosas o dos problemas diferentes? Porque tal vez la simbiosis sea más narcisista, y la complementariedad patológica, mucho más difícil de resolver.

B-N: El problema que entraña esta interesante pregunta es la complejidad de niveles involucrados en ella. En mis trabajos más recientes describo cuatro dimensiones principales de las relaciones, a saber: 1) hechos; 2) necesidades o psicología; 3) ética o méritos; y 4) poder o transacciones. Estas son las cuatro principales dimensiones tanto de las relaciones como de las intervenciones. Al evaluar un caso tenemos que contemplar todas estas dimensiones. Por ejemplo, si existe una enfermedad de tipo hereditario, ese sería un hecho. Una persona puede haber nacido con retardo mental, tener alguna lesión cerebral. El hecho de que yo sea blanco versus negro, o varón versus mujer, o judío o cristiano, o que sea una persona cuyos padres fueron aniquilados por Hitler, o que mi padre fuera un presidente norteamericano, cualesquiera hayan sido los hechos de mi vida, es una cosa. Estos hechos determinan en gran medida mis motivaciones e incluso las expecta-

tivas que coloco en mi propia vida. La dimensión que tengo que con los méritos encierra los aspectos de tipo explotación. Por ejemplo, los sutiles mensajes de los padres en este sentido: "Te amo tanto, hijo mío, que quisiera dártelo todo, y no espero que me des nada a cambio. Yo te he consagrado mi vida entera, pero tú no me debes nada a mí". El hijo queda atrapado en el absurdo ético y unilateral de esta premisa. O podemos tomar el aspecto que tiene que ver con las necesidades, o psicológico. Aquí podemos hablar acerca de complementariedad entre mi narcisismo y su narcisismo, o mi sadismo y su masoquismo, o mi necesidad de una fusión primitiva o de indiferenciación emocional, o de mi necesidad de lograr que usted siga siendo un hijo primitivo para que yo pueda seguir siendo un padre primitivo y disfrutarlo, etc. O se pueden investigar las transacciones, el poder y las comunicaciones, o sea la cuarta dimensión: yo puedo establecer relaciones de tipo doble vínculo con usted, puedo mistificarlo, puedo usar mi poder para aferrarme a usted y no permitir que jamás se aparte de mí.

Ahora bien, en todas estas cosas podemos hablar de simbiosis, y si simbiosis es un término descriptivo, lo que entraña es que todo el sistema está centrado en que los hijos no puedan crecer, individuarse ni diferenciarse como seres humanos autónomos. Esta es la esencia de la simbiosis, pero, al mismo tiempo, posee todos estos componentes dinámicos: esto es, el hecho de que el hijo naciera con una lesión cerebral, o la corrupción ética del sistema, o la complementariedad psicológica de necesidades, o las técnicas de poder que se utilizan: paradojas, relaciones de tipo doble vínculo, mistificaciones, etc.

C: Usted se refirió hace un rato a la inmortalidad a través del hijo. A permanecer vivo en el hijo, el hijo de éste, el hijo del hijo de éste. Yo diría que tal vez esta simbiosis narcisista es algo así como una lucha contra la muerte. Mientras que me parece que la complementariedad patológica es algo peor, algo más paranoide o más difícil de reconocer en este tipo de interrelación. No sé que pienda usted al respecto.

B-N: Esa es una dimensión importante, la psicológica, el aspecto de necesidad. Otra podría ser la de tipo dependiente: que me

identifico con mi hijo y lo convierto en mi padre, y me aferro a él para no volver a perder a mi padre; me aferraré de este hijo que es mi padre, a quien uso como padre, de quien jamás me separaré. Así que hago que le resulte imposible separarse de mí o decepcionarme. Así que puede verse la relación en el aspecto dependiente, o en el aspecto narcisista, o en el aspecto de tipo de diferenciación y fronteras del yo a la que se refiere Bowen: Como usted sabe, la masa del yo indiferenciado, es una suerte de fusión emocionalmente sobrecargada, entre distintos miembros de una familia. (fusión simbiótica). Esa es una dimensión psicológica a la que incluso se refirió Freud, los límites yoicos, y Federn elaboró toda una teoría acerca de ella, en el terreno de la psicosis. Así que allí tiene usted otro aspecto. Y toda una serie de dimensiones psicológicas que puede utilizar. Pero siguen existiendo también las dimensiones fácticas, éticas y transaccionales de todos estos fenómenos. La terapia debería tomar en cuenta todas y cada una de estas dimensiones. Es bueno pensar en esta psicología y aquella otra psicología, pero deberían tomarse en cuenta las cuatro dimensiones para poder tener una orientación terapéutica completa.

C: Le agradezco muchísimo esta entrevista. Fue muy interesante conversar con usted.

LIBROS

TERAPIA DE SOLUCION DE PROBLEMAS

Jay Haley

Ed. Jossey-Bass, San Francisco/London 1977.

Sobre el autor, es profesor de psiquiatría clínica de la Universidad de Maryland y director del Instituto de Terapia Familiar de Washington D.C.. Anteriormente, fue director de investigación de terapia familiar de la Philadelphia Child Guidance Clinic (Penn State University), profesor de psiquiatría de la Universidad de Pensilvania e investigador en el departamento de antropología de la Universidad de Stanford, California. Habiendo sido "maestro de Terapia", en la actualidad, prefiere ser "maestro de maestros de terapia".

En este, su último libro, Haley describe en forma muy clara y en su estilo tan interesante, técnicas para la resolución de problemas.

Su enfoque no se orienta hacia el desarrollo de insight o comprensión, ni a proveer una experiencia de maduración que podría, quizás, favorecer la desaparición de la dificultad; sino a producir Cambios en la conducta del paciente que permitan eliminar el problema o disminuir (aliviar) el síntoma. Para él toda la responsabilidad de la terapia recae en el terapeuta. Además, destaca con

Libros

mucho énfasis, que el terapeuta no puede imponer un método para todos los casos, y que debe adaptar el tratamiento de acuerdo a cada paciente o a cada familia.

A partir de su ya clásico libro "Estrategias en Psicoterapia", su enfoque de terapia familiar está focalizado en la situación social del paciente, no en el individuo. Esto obliga a pensar de una forma totalmente diferente respecto a la psicoterapia, la cual requiere de nuevas destrezas, estrategias e intervenciones técnicas.

En el primer capítulo, muestra cómo conducir la primera entrevista con el paciente y su familia, cómo interpretar los intercambios y cómo formular problemas en el contexto social.

Enfatiza la importancia de tomar en cuenta la modalidad sensorial del paciente, o sea "hablar el lenguaje del paciente", conocer sus valores, sus motivaciones, creencias y prejuicios. También estructura las sesiones respetando las jerarquías en la familia; y sintéticamente, destaca la importancia de aclarar la información que dan los pacientes, manteniendo la influencia del terapeuta. En este mismo capítulo destaca la importancia de formular objetivos (metas) "posibles"-concretos, y que puedan representar con claridad un cambio en el problema.

Explica cómo dar directivas que conducirán a cambios en la conducta y cómo desarrollar la terapia paso a paso; todo esto en el segundo capítulo, temas que retoma en los capítulos V y VI sobre tácticas estratégicas en los tratamientos, incluyendo las explicaciones racionales subyacentes.

Los capítulos III y IV son fundamentalmente teóricos sobre comunicación; el III sobre "Comunicación como Trocitos y Metáfora" y el IV sobre "Comunicación-Secuencia y Jerarquía".

El capítulo V se refiere a las etapas de la terapia, y el VI a cómo manejar los especiales problemas de la terapia marital a la que él ve como un triángulo.

El capítulo VII lo dedica a los problemas en el entrenamiento de terapeutas; el capítulo final lo refiere a los aspectos éticos de la terapia; y el libro termina con un historial, muy adecuadamente titulado "Un Moderno Pequeño Juanito" (el niño tenía un excesivo temor a los perros).

Indudablemente, este libro ofrece indicaciones que podrían

incrementar la eficiencia de los terapeutas, aún la de aquellos de diferentes orientaciones, y obviamente sería sumamente útil para el terapeuta de la familia que se está cansando, infructuosamente, de sesiones no estructuradas. Haley brilla a través de las partes del libro en las que estimula a los terapeutas a asumir el liderazgo en el tratamiento.

En términos generales, el libro tiene tres áreas principales: Estrategias y Tácticas, Racionalización Subyacente o Teoría, y el Entrenamiento de Terapeutas.

Intentaré referirme sintéticamente a cada una de estas.

Respecto a la primera de estas áreas, podría decir que su habilidad en esta publicación muestra como nunca su brillantez y pragmatismo. Nos demuestra como cualquier actitud que el terapeuta tenga en la sesión puede ser vista como una directiva, ya que "todo lo que el terapeuta hace es un mensaje (indicación) para que la otra persona haga algo, y en ese sentido está dando una directiva".

Enfatiza Haley, que aún cuando el terapeuta evite dar directivas mostrando al cliente que está tratando que el terapeuta le indique qué hacer, aún en ese caso, le está dirigiendo la conducta al paciente. En consecuencia, como la influencia interpersonal existe en todo contacto humano, el instrumentar habilmente los diferentes tipos de directivas es una condición sine qua non para lograr el objetivo terapéutico. Para llegar a esa meta, es preciso motivar a la familia a acatar las directivas, y motivar a una persona para que haga algo, significa persuadirla de que en algo, se beneficiará con ello. Para que un terapeuta pueda motivar a los miembros de una familia a cumplir una tarea, es necesario convencerlos de que esa acción les permitirá conseguir las metas que ellos desean para si mismos individualmente, para cada uno de los demás, y para la familia como sistema.

El autor explica detalladamente las directivas directas y las indirectas, enfatizando la necesidad de que se adecuen a los individuos, ya que la experiencia profesional permite al terapeuta observar en las entrevistas como son los miembros, y cual es el estilo de la familia.

Así como el terapeuta debe hacer que todos los miembros de

la familia se involucren en la entrevista, también hará que todos tengan algo que hacer en la tarea, ya que, aún cuando especifique que uno de los integrantes queda excluido de la misma, esto ya le está dando a esa persona una participación.

Con frecuencia, la gente estará más dispuesta a seguir una directiva si no tiene conciencia de haberla recibido.

Hablar metafóricamente es una forma de dar directivas metafóricas empleando analogías. Las metáforas, además de palabras, son también acciones. El terapeuta elige una meta para modificar alguna actitud de la familia, luego, selecciona una actividad que se parece a la que él desea cambiar, una que los miembros puedan manejar con mayor facilidad.

Con referencia a las directivas paradójales, brinda una amplia y detallada explicitación de este tipo de instrucciones; cuándo emplearlas y con quién; ya que cuando el terapeuta las implementa, lo que persigue, es que los miembros del grupo familiar tengan que cambiar, para desafiar al terapeuta.

El fundamento de esto, es que algunas familias acuden a terapia siendo resistentes a la ayuda que solicitan, y por lo común, son muy exitosas en lograr que los terapeutas hagan esfuerzos y fracasen; situación frustrante tanto para el terapeuta como para la familia.

La implementación de las instrucciones paradójales puede hacerse de dos formas: a la familia como totalidad, o solo involucrando a una parte del sistema. Este tipo de instrucciones consta de diferentes pasos, que el autor describe e ilustra con muchos ejemplos, aclarando que está preparando un libro, conjuntamente con Cloé Madanes, totalmente dedicado a este tema y que se titulará "Paradojas en Psicoterapia".

La fundamentación teórica en la que Haley se apoya, figura en los cuatro primeros capítulos de este libro, en el que define la terapia como "una intervención que hace un extraño en un sistema comunicacional estrechamente estructurado, en el cual los síntomas son una modalidad de comportamiento adaptativo a la conducta habitual de los otros miembros de ese sistema".

Si el problema se ha definido como fobia, depresión, desorden del carácter, etc., la comunicación será funcional dentro de ese

sistema, en consecuencia, el hecho de intervenir, tanto en terapia individual, como en terapia de familia, implica operar en el sistema.

Cuando la terapia es efectiva, el sistema total en el cual la persona vive, sufre un cambio, de modo que una comunicación más fluida y normal sea posible para todas las personas involucradas.

Desde este punto de vista, es posible describir los síntomas como actos comunicacionales que cumplen una función dentro de la red interpersonal. El comportamiento sintomático es una respuesta a la situación del individuo en interacción con sus "personas significativas", por lo tanto, la situación cambiará si su comunicación sufre un cambio. Observando personas que tienen una historia y un futuro compartido, vemos que tienen formas organizadas de comportarse entre ellas; y si también miramos a la familia en términos de jerarquías, vemos que la organización incluye personas de diferentes posibilidades económicas, de distinto grado de habilidad e inteligencia.

Estas complicadas líneas jerárquicas se relacionan con las muchas y variadas funciones de la familia. Cuando las posiciones (status) en jerarquía, son poco claras y confusas, se puede detectar una lucha por el poder; pero también podría verse esa lucha como un esfuerzo para aclarar o intentar soluciones en las posiciones jerárquicas de la organización o estructura.

Una de las formas posibles de entender una jerarquía sería observando las secuencias interaccionales que tienen lugar en esa organización. Si vemos, por ejemplo, que el Sr. A le dice al Sr. B que haga algo y el Sr. B lo hace, eso puede ser un hecho aislado, si ese hecho se repite una y otra vez, deducimos que el Sr. A tiene un lugar más prominente en la jerarquía que el Sr. B. La estructura está compuesta por actos repetitivos entre personas; y ésto ha revolucionado el campo de la psicoterapia ya que el objetivo de la misma consiste en modificar las secuencias que tienen lugar entre los miembros de un grupo organizado. Cuando cambian las secuencias, los individuos que integran el grupo sufren un cambio.

Haley define el cambio terapéutico como un cambio en los actos repetitivos de un sistema que se autoregula, con preferencia para convertirse en un sistema de mayor diversificación. Si

el sistema es rígido, las secuencias repetitivas tendrán un rango limitado, lo que da lugar a la patología.

Si tomamos en cuenta las distintas etapas de una secuencia y también, por lo menos, tres de los niveles de una jerarquía, podremos planificar estrategias con el objetivo de cambiar la secuencia; previniendo coaliciones intergeneracionales.

Por supuesto, que tres niveles jerárquicos no aparentan ser suficientes para describir la complejidad de la vida humana; pero igualmente nos permite tener elementos para trabajar. Por ejemplo, si pensamos en términos del triángulo familiar-madre/padre/hijo o suegro/marido/mujer- podemos calcular los triángulos que existen en una familia típica.

Esta descripción, respecto a jerarquía que aporta Haley, nos permite descubrir determinadas características de la organización (estructura) disfuncional:

Primero, las tres personas que la integran responden unas a otras, no son pares pues pertenecen a diferentes generaciones. En este caso, generación significa un orden distinto en el poder jerárquico, como por ejemplo -padre/hijo o empleador/empleado.

Segundo, un miembro de una generación hace coalición con alguien de otra generación. El término coalición implica un proceso de acción conjunta contra una tercera persona; en contraste con una "alianza", en la cual dos personas pueden compartir un interés común, en el que no está integrada la tercera persona. Tercero, el problema es más severo cuando la coalición intergeneracional es negado u ocultado.

Es preciso enfatizar que una organización es disfuncional, no sólo por las coaliciones intergeneracionales, sino porque esas coaliciones son repetitivas y son parte de esa estructura.

Referente al área dedicada al "Entrenamiento de Terapeutas" las ideas y las dificultades que presenta el autor son evidentes y claras para todos los que nos ocupamos de esa tarea, lo que me obliga a remitir a los lectores a la lectura de este texto, ya que su forma de encarar el entrenamiento, está perfectamente organizada y su forma pragmática refleja en todo momento un estilo especialmente útil para quienes enseñan terapia de familia.

La experiencia del autor hace que este capítulo presentado en forma tan concisa, lo convierta en una guía irremplazable, pues,

maximiza la posibilidad de aprendizaje de las habilidades terapéuticas. Cubre ítems tan importantes como la necesidad de aprender a través de la práctica, de hacerlo en un equipo, enfatizando la gran importancia de la supervisión "en vivo".

Cuando el supervisor observa al terapeuta trabajando, se da cuenta lo poco adecuado de las supervisiones clásicas; en las cuales solo se revelaba aquello que el terapeuta quería contar.

En los últimos veinte años, se hicieron muchos progresos, ya que con la ayuda del videotape se pueden observar los movimientos y las palabras; los terapeutas aprendimos así a mostrarnos trabajando, a cuestionarnos y a ser cuestionados por nuestros observadores. Mediante este tipo de supervisión podemos proteger a los pacientes de la incompetencia y del exceso de intrusión, y simultáneamente enseñar cómo hacer terapia en el preciso momento en el que el terapeuta lo está haciendo.

Este tema, que concierne al entrenamiento de terapeutas está magníficamente desarrollado y es el producto de los esfuerzos y de la experiencia acumulada durante muchos años por Jay Haley, en la Philadelphia Child Guidance Clinic, en la cual formó a muchos terapeutas quienes hoy nos beneficiamos debido a su creatividad, ingenio, conocimientos, dedicación y brillantes condiciones didácticas.

Celia Elzufani

ESTRUCTURA FAMILIAR Y PSICOSIS

Gisela Pankow

Ed. Paidós, Bs. As. (1979)

Quizás no sea extraño a sus orígenes que esta autora trabaje en Francia y sea catedrática en una universidad de Alemania. Si pensamos que lo real es solo el lugar de un nudo donde se inserta el sujeto, podríamos decir que eso real geográfico marca, fronteras mediante, un juego dialéctico que se introduce en su CUERPO de doctrina y que podríamos representar como:

Terapia Familiar, 4, 1980

205



(Aunque pudiéramos pecar en exceso)

Volviendo sobre el CUERPO, algo principia en dos funciones.

La primera función de la imagen del cuerpo: estructura espacial que como guesalt dialectiza una relación entre las partes y el todo. Allí veremos el cuerpo disociado de la psicosis o el cuerpo fragmentado de la neurosis.

La segunda función de la imagen del cuerpo: contenido y sentido, lugar de inserción, por ejemplo de los delirios crónicos no esquizofrénicos.

Destaquemos que en su campo de trabajo la autora tiene un importante desarrollo en el terreno de la psicosis. Digamos además que podremos introducirnos en este terreno si nos guía un verdadero espíritu pionero, el resto repetición o imposibilidad.

Es así que psicoanalizar en la psicosis se trataría no solo de volver a ordenar, sino, de aportar desde afuera lo que nunca llegó a ser.

Si recordamos a S. Freud en uno de sus cinco psicoanálisis del "hombre de los lobos", donde en las "Discusiones" sobre la escena primordial y los recuerdos infantiles nos dice: "Estas escenas infantiles no son reproducidas en la cura como recuerdos: son resultados de la construcción. Seguramente, habrá alguien que crea ya resuelto el problema con esta sola confesión". (pág. 806 tomo II Ed. Biblioteca Nueva Madrid, 1968)

Desde ya el problema no se resuelve, es más, se complica cuando pensamos en la psicosis dado que quizás es la construcción permanente lo que el terapeuta puede aportar en el proceso de la cura; diríamos aún, construcciones alrededor de tiempos lógicos.

Desde esta óptica dejaremos hablar a G. Pankow desde uno de sus casos del capítulo, "Estructura familiar y esquizofrénica", apartado "Una hija esquizofrénica vista por su madre": La paciente llega ese día a sesión, decide no acostarse en el diván, en cambio,

206

Terapia Familiar, 4, 1980

abre su paraguas y escondida desde él exclamaba: "Debe sentirse muy cómoda ahora, está tan bien protegida". La paciente estuvo en esta posición media hora reiterando sus ataques, de pronta la terapeuta se levanta y le dice: "Tengo que ver a su madre".

¿Qué es esto? ¿No era una sesión de psicoanálisis? ¿Cómo introducir a otro que no sea el paciente? Llamáramos a esto pervisión del encuadre? ¿Porqué no interpretó la terapeuta en vez de pasar al acto?

Pero continuemos. "Inmediatamente la expresión de la enferma cambió. Tuvo una mirada normal, replegó su paraguas y me dijo: hoy no pagaré mi sesión pues he sufrido demasiado. Respondí que comprendía su sufrimiento y que todavía tendría que sufrir más hasta nacer". Tres días después aparece la paciente con su madre exclamando "aquí está mi madre", esta era una mujer de setenta años.

En su primera impresión la terapeuta descubre en esta mujer una mirada paranoica, al preguntarle si había notado a su hija enferma la mujer responde negativamente. Luego continúa investigando sobre el embarazo, la respuesta fue: "Tenía la impresión de que llevaba adentro un canario". Comenta también que a los diecisiete años su deseo era tomar los hábitos lo que no pudo concretar por la oposición de sus padres.

Buscando un plano de clivaje la terapeuta interpreta: "Da la impresión de que una parte de su vida esta alienada, de que es vivida por su hija. Ella es religiosa y realizó un deseo que usted no realizó a causa de sus padres. Si quiere que su hija se salve de la enfermedad mental, tenemos que cortar ese antiguo hilo entre usted y su hija. Ella es ella y usted es usted. Cada una debe vivir su vida".

A partir de esta intervención algo cambia, la hija que esperaba en la sala de espera ya no estaba allí al salir la madre. Algo se había roto.

Al volver la paciente a la sesión siguiente dice: "Mi madre estaba muy contenta de haberse encontrado con usted y me dijo que era la primera vez en su vida que había podido hablar de mí".

Ahora bien ¿cómo llegamos hasta aquí? Pankow nos plantea una construcción a partir de la escena del paraguas, establecer "la relación entre formas y cuerpos". En ese sentido el cuerpo de la

paciente en relación al paraguas era el equivalente de un recién nacido suspendido de la placenta, imagen de alumbramiento y de vínculo indisoluble a la madre.

A partir de la intervención de la terapeuta "Tengo que ver a su madre", la paciente cierra el paraguas y comienza un recorrido.

Luego de esta entrevista a la madre la paciente recién pudo introducirse en su dinámica edípica y rescatar a su padre.

Como conclusión de este apartado Pankow introduce una fórmula interesante: "la madre es parte de su propio hijo, la madre no tiene hijo. El hijo es parte de su propia madre, el hijo no tiene madre".

Diríamos entonces que habrá que lograr que una madre tenga un hijo y un hijo tenga una madre, pero que además juegue entre ellos el nombre del padre.

En el campo de la psicosis toda intervención es posible, no porque se intervenga de cualquier manera, sino en el terreno de las construcciones como se ve en el ejemplo de la autora. Construcciones que abordadas en la relación familiar buscarían establecer los clavajes necesarios para que alguien sea.

Construcciones que desde ya no resuelven el problema, como nos confesara Freud, sino que abren a partir de ellas el camino del discurso.

Así podemos decir que esta autora hace un muy interesante aporte para pensar al paciente psicótico y su familia.

Rafael Skiadaressis

A partir de esta intervención algo cambia, la hija que esperaba en la sala de espera ya no estaba allí al salir la madre. Algo se había roto.

Al volver la paciente a la sesión siguiente dice: "Mi madre estaba muy contenta de haberse encontrado con usted y me dijo que era la primera vez en su vida que había podido hablar de mí".

Ahora bien ¿cómo llegamos hasta aquí? Pankow nos plantea una construcción a partir de la escena del paraguas, establecer "la relación entre formas y cuerpos". En ese sentido el cuerpo de la

CONGRESOS

VIII Congreso Latinoamericano de Psicología y Psicoterapia de grupo

El VIII Congreso Latinoamericano de Psicología y Psicoterapia de Grupo, tuvo lugar entre el 12 y 15 de septiembre de 1979 en el Plaza Hotel de Buenos Aires, organizado por la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia del Grupo, a través de un Comité Organizador constituido por: Dr. Guillermo Ferschtut, Presidente; Dr. Carlos Elinger, Vicepresidente; Lic. Mignon Rousseau, Secretaría General; Dr. Alejandro Gallo, Secretaría Científica; Lic. Marina Ravenna de Selvatici, Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas; Prof. Ida Butelman, Secretaría de Educación, Difusión y Cultura; y el Dr. Horacio Koltan, en la Secretaría de Finanzas.

Se inició con un acto inaugural al que asistieron, además de los delegados, diversas personalidades en representación de las entidades auspiciantes (American Group Psychotherapy Association, Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, Asociación de Psiquiatras de la Capital Federal, Asociación Psicoanalítica Argentina, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Centro de Rehabili-

Congresos

tación Social - CENARESO - ; Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo - FLAPAG-, Internacional Association of Group Psychotherapy, Secretaría de Estado de Salud Pública del Ministerio de Bienestar Social, Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires y World Association for Social Psychiatry.

Su primera sesión científica tuvo lugar el jueves 13/9 a las 8,30 hs., y se abrió con un Relato Oficial presentado por la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, seguido luego de dos correlatos, uno exponente de la Asociación Brasileña de Psicoterapia Analítica de Grupo y el otro representando a la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo. Los tres fueron trabajados luego en pequeños grupos de discusión programados con una conformación espontánea.

El relato oficial argentino "Corrientes actuales en Psicoterapia de Grupo", estuvo a cargo de los Dres. Alejo Dellarossa, Guillermo Ferschtut, Janine Puget y Raúl Usandivaras. Sus autores se definen como psicoterapeutas de grupo de formación psicoanalítica. Reconocen que existen otros esquemas referenciales pero presentan su perspectiva. Este relato quiere ser un punto de partida, un estímulo para la interacción fecunda entre los distintos participantes, facilitada y propiciada por la novedosa modalidad que caracterizó a este Congreso: los workshops (grupos de trabajo). Es decir que éste no fué un Congreso al que la gente concurrió para escuchar aportes de unos pocos, sino un Congreso donde se fue a producir y construir entre todos. Por eso los autores de este relato oficial señalan que "el verdadero relato sobre Corrientes actuales en Psicoterapia de Grupo", recién será logrado en la síntesis final de este Congreso, y se irá armando en los grupos de discusión.

Se señala la gran responsabilidad que cabe a este evento "...de establecer las bases para realizar estudios metodológicos sobre la validez de los criterios de salud mental, la evaluación de los resultados terapéuticos y el valor de los distintos instrumentos técnicos..."

Se hace una correlación entre el surgimiento de una gran variedad de técnicas nuevas y los cambios de nuestra era, cuyo común denominador es su instrumentación a través del pequeño grupo como medio adecuado para la solución de conflictos vinculados con la identidad.

El correlato brasileiro "La interacción constante del trabajo en grupo", se centró sobre el lenguaje peculiar que caracteriza a un grupo terapéutico, destacando el relativo hermetismo que existe en la comunicación grupo-terapeuta y viceversa, y señalando que el objeto básico de la tarea terapéutica es crear a partir de dicho hermetismo un código compartido.

El correlato mexicano va recorriendo la evolución institucional de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, ubicándola en su contexto histórico social.

En el transcurso de las tres medio jornadas siguientes se desarrollaron los grupos de trabajo y los simposios. Las grandes líneas temáticas desarrolladas en los mismos, versaron sobre: Familia, Pareja, Psicopedagogía, Psicología Institucional, Técnicas Corporales, Psicoprofilaxis, Grupos de Encuentro, Técnicas Gestálticas, Técnicas Dramáticas, Vínculos Psicosomáticos, Identidad, Niñez, Adolescencia, Tercera Edad, Alcoholismo, Drogadicción, Tabaquismo, entre otras.

La estructura funcional de este Congreso, organizado sobre la base de un trabajo cara a cara en pequeños grupos, permitió que más de mil personas se reunieran para mostrarse y compartir, dando lugar a experiencias intensas a varios niveles: por el ritmo de las actividades, por el amplio abanico de estímulos, por las redes de comunicación establecidas, por la emotividad de encuentros y reencuentros, por los descubrimientos.

Durante tres días, a través de los grupos de discusión, de los workshops y de los simposios, se vieron los fenómenos grupales desde diferentes perspectivas y los integrantes se incluyeron como sujeto y objeto de estudio; lo que otorgó una dimensión realmente vivencial a toda la experiencia.

Esto no fue fácil y entrañó alegría por obtener algo nuevo y dolor por el cambio, o sea un verdadero aprendizaje que dejó el sedimento de un encuentro lleno de interrogantes y aperturas.

Bajo formas de expresión distintas, en todos los grupos hubo movilización, descubrimiento de la heterogeneidad y comienzo de la gestación del proceso de identidad congresal.

Extranjeros y argentinos de todo el país, pudieron así concluir en un encuentro básicamente signado por el intercambio. Este fue fundamentalmente un evento joven, no tanto por la edad de

sus participantes, sino por la modalidad de apertura a nuevos estilos y nuevas técnicas. Permite estrechar vínculos entre gente de las más variadas disciplinas de las ciencias del hombre y cuyo interés se centra en el fenómeno grupal.

Este Congreso se constituyó así en el punto de partida. El próximo paso, ya en proceso de organización, es el Primer Congreso Argentino de Psicología y Psicoterapia de Grupo, también organizado por la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, que tendrá lugar en Buenos Aires, en Mayo de 1981, y que continuará en los años sucesivos, en distintas sedes del interior del país.

Congreso de Terapia Familiar - Zurich (Suiza)

Por Dr. Helm Stierlin

Comparado con los Estados Unidos, la terapia familiar llegó tarde a los países de habla alemana. Sin embargo, en los últimos cinco años, se ha desarrollado un "Boom" en terapia familiar, particularmente entre jóvenes profesionales en salud mental.

Además del Congreso de Zurich, dos congresos de familia importantes tuvieron lugar en Giessen, Alemania, durante estos dos últimos años. Cada uno contó más o menos con 800 participantes. El próximo Congreso de esta clase está programado en Heidelberg para la primavera del 80. Tendrá lugar en alemán solamente y reunirá a personas de Austria, la parte alemana de Suiza y Alemania Occidental.

Otro signo del agitado crecimiento de la terapia familiar es el desarrollo rápido de nuevos centros de entrenamiento en los países de

habla alemana. De estos centros el mejor establecido actualmente es el "INSTITUT FÜR EHE UND FAMILIE" en Zurich, dirigido por Josef Duss-von Werdt. Ofrece a los profesionales en salud mental un programa balanceado de cursos conducidos por un amplio equipo de docentes de distintos lugares de Suiza. Comparado con el Instituto de Zurich, nuestro Centro de Heidelberg es todavía nuevo e inexperto. Al principio, después de mi regreso de los Estados Unidos, aproximadamente hace 4 años y medio nosotros ofrecíamos entrenamiento en terapia familiar solamente con el curriculum universitario. Hace más o menos un año nosotros formamos el "HEIDELBERGER FAMILIEN THERAPEUTISCHE ARBEITSGRUPPE" que ofrece entrenamiento también a profesionales en salud mental no conectados con la Universidad. El elemento central de este programa de entrenamiento es la supervisión en grupo, de sesiones de terapias familiares que son observadas detrás de una pantalla unidireccional. Además se dictan diversos cursos teóricos y prácticos. Hasta el momento cerca de 70 profesionales en salud mental están registrados en este programa. Otros programas familiares en países de habla alemana son todavía noveles. Todos ellos reflejan el gran problema con el cual todos los docentes y los institutos tienen que enfrentar: la enorme discrepancia entre la oferta y la demanda y la alta calidad del entrenamiento. Y este problema parece no tener solución a la vista ya que la demanda

es cada vez mayor. En vista de la escasez de docentes locales los seminarios ofrecidos por terapeutas extranjeros, especialmente de los Estados Unidos son un recurso valioso. Nosotros en Heidelberg hemos tenido la suerte de haber podido organizar conferencias y seminarios con Iván Boszormenyi-Nagy, Norman Paul, Don Bloch, Jim Framo, Lyman Wynne, Salvador Minuchin, Mara Selvini-Palazzoli, Ted Lidz y otros. (Nuestra cercanía geográfica con Italia nos ha dado la posibilidad de ver a la Dra. Servini y su excelente equipo en acción con varias familias. Sin embargo, los congresos y lo que viene de los Estados Unidos no han todavía solucionado el complicado y difícil problema del entrenamiento. Otros problemas que los terapeutas de familia de países de habla alemana deben enfrentar son los que se refieren a licencia y a seguro de salud. En Alemania Federal el problema de la licencia está estrechamente vinculado con el de la licencia para psicoterapeutas en general. Actualmente la legislación está pendiente de regular este problema sobre las bases de un país liberal. Queda por verse si y cómo, la terapia familiar pueda hacer valer sus derechos entre las diferentes escuelas de psicoterapia individual y grupal, clamando aquí por reconocimiento. En lo que se refiere al pago de la terapia familiar a través del seguro de salud, la situación es igualmente irregular. En Alemania aproximadamente el noventa por ciento de la población está cubierta por El

Seguro Nacional de Salud. Las negociaciones para cubrir también la terapia familiar están empezando, pero pienso que solamente será para la terapia familiar ejercida por médicos.

Sin embargo, hay algunos puntos más halagüeños: no hay ya una escasez de literatura, ya que la mayoría de los textos de terapia familiar han sido traducidos. También es de esperar que muy pronto haya mayor intercambio entre los terapeutas de familia de América y Europa. Actualmente un fuerte estímulo europeo nos llega desde Milán a través de la Dra. Mara Selvini-Palazzoli y su equipo. También nosotros en Heidelberg esperamos contribuir. Nuestro libro "La Primera Entrevista Familiar" realizado hace dos años por nuestro equipo de Heidelberg está actualmente siendo traducido en varios idiomas, incluyendo el inglés. El contiene un bosquejo de nuestro modelo teórico de Heidelberg,

llamado también "Heidelberger familiendynamische Konzept". Dentro de este modelo los conceptos de delegación y modos transaccionales de vínculo y proyecciones son centrales.

Finalmente, me gustaría mencionar nuestra publicación alemana "Familiendynamik" editada por Josef Duss-von-Werdt y por mí. Nosotros hemos arreglado libres intercambios de artículos con varias publicaciones extranjeras, incluyendo el "Family Process". En cada número de "Familiendynamik" nosotros desarrollamos un tema especial como "Sexualidad y terapia sexual", "Problemas de dolor y muerte en la familia", "Problemas de adopción", o "Aportes especiales a Terapia Familiar", (nuestro último número). Aunque aún no podemos competir en circulación con algunas publicaciones en inglés, aquí nos está yendo bien y vamos creciendo.

III Congreso Internacional de Terapia Familiar

Tel Aviv - Israel - 1 - 5 julio 1979

Por Dra. Florence Kaslow, Editor del Journal of Marital and Family Therapy y Profesora del Hahneman medical college.

Regocijo y tristeza. Estas son las sensaciones que llenan mi corazón y mi espíritu cuando nos alejamos del aeropuerto Ben Gurión, después de haber asistido a un Congreso inspirativo y singular. Uno se siente privilegiado de haber estado en esta antigua y magnífica tierra

deliberando con colegas, profesionales de muchos países alrededor del mundo. Los 900 participantes llegaron de Australia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, Italia, Sud Africa, Canadá, USA y por supuesto Israel. Las sesiones, que tuvieron lugar desde

las 8.30 a.m., fueron celebradas en inglés, con saludos y expresiones en hebreo que agregaron color local.

Nuestros colegas israelíes hicieron un excelente trabajo de organización, de manera que la conferencia se desarrolló fácilmente en un clima agradable. Las mañanas se dedicaron a numerosas sesiones plenarias y paneles, las tardes a los materiales y mesas de trabajo, y las noches a programas especiales.

Aunque muchos trabajos y mesas de trabajos mostraron títulos similares a los que se presentan en cualquier otro congreso ya que numerosos temas de terapia familiar son universales, hubo algunas diferencias sustanciales. El más notable fue el material sobre dinámicas y tratamiento de los sobrevivientes del holocausto y sus familias. Shamai Davidson, Director del Salvate Psychiatric Center, cerca del Tel-Aviv, tiene gran experiencia terapéutica con esta población que sufre un trauma masivo. Su presentación calma, racional, de cargado material en una de las sesiones plenarias, mantuvo a la audiencia en un silencio pasmoso. Muchos de los oyentes habían perdido seres queridos en el holocausto y sentían otra vez la pena compartida. Uno de los terapeutas de la audiencia conocedor del hecho de que chicos de miembros del primer Partido nazi están también todavía sufriendo los horrores de los recuerdos de aquel período tortuoso en la historia de la humanidad, sugirió que tal vez terapeutas de familia de Israel y Alemania podrían trabajar juntos en intervenciones con chicos sobre-

vivientes de ambos grupos para que estas reverberaciones, que 35 años más tarde todavía tienen resonancia, no continúen plagando la descendencia de los sobrevivientes en generaciones venideras.

En un tono más alegre, una tarde fue dedicada a un panel sobre terapia familiar alrededor del mundo. Presidida por Avner Barcai de Israel, el panel tuvo oradores de Australia, Inglaterra, Alemania, Holanda, Italia, Noruega, Sud Africa y USA. Nosotros conocimos publicaciones de Australia, Inglaterra, Israel y Noruega; también acerca de la liberación femenina en Holanda; y cómo se hace la "escultura familiar" en Italia y Sud Africa, y mucho más. Yo me alegré muchísimo de haber sido seleccionada para representar a los Estados Unidos y hablar acerca de los adelantos tales como licencia, acreditación de programas e indemnización de seguros lo mismo que de las diferentes teorías de terapia que han sido corrientemente enseñadas aquí. Otro panel sobre supervisión y entrenamiento también tuvieron representantes de varios países, cada uno de los cuales enfocó este crítico asunto de la misma manera que lo hacen en su propio país.

Los miembros americanos y canadienses de AAMFT que presentaron fueron: Beryl y Noam Chernick, Axel y Lila Russell, Robert Garfield, y Marion Usher. Uno de los organizadores del programa de la conferencia Yochaved Howard es un miembro israelita del Consejo de Redacción de nuestra revista. Avner Barcai e Israel Charney de Israel

desempeñaron papeles de mayor importancia. Maurizio Andolfi de Italia participó como coordinador y panelista, y Lita Schwartz habló sobre pseudoreligiones y la familia. Yo tuve el privilegio de pronunciar uno de los discursos más importantes sobre un tema que me interesa: *Perfil de una familia sana*. Algunos de los participantes fueron estimulados bastante para investigar sobre este asunto en términos de un perfil de una familia sana en sus países de manera que nosotros pudimos conocer qué es universal y qué es culturalmente específico, y también discutimos sobre *familias sanas con un solo progenitor*.

Varios israelíes trabajando con Familias que han emigrado del Yemen, Persia y Marruecos expresaron su interés en determinar si hay un prototipo de familia sana cuando hay varias esposas simultáneamente (cómo lo permite la religión musulmana). Quedamos pensativos...

Habría mucho más para contar sobre esta cálida y rica conferencia que tuvo lugar a una hora de distancia de la ciudad santa de Jerusalén. Muchos de los participantes viajaron a la sagrada ciudad de Oro cuyas casas forman un complejo tapiz de "viviendas" judías, árabes y armenias dentro de la ciudad amurallada, la cual contiene veneradas mezquitas y hermosas sinagogas reconstruidas, que laten con los chicos jugando en la Vía Dolorosa y otras calles estrechas, y con la energía confiada de los adultos jóvenes estu-

diando en la Universidad Hebrea.

Es una mezcla fascinante de un pasado antiguo con el conflictuado presente perpetuada en posters y la reciente paz firmada por Begin, Sadat y Carter, y de los profundos deseos de paz y tranquilidad futuras. La amenaza de la actividad terrorista está omnipresente; ningún soldado camina por la calle sin un arma colgada de su brazo y el hotel de la conferencia, lo mismo que todos los demás tenían un soldado alerta en su entrada. Dado este contexto histórico, hablar de gramas, de historias y herencias familiares y cooperación entre países tiene un significado más elevado.

No queda más que resaltar hechos de la conferencia. Dos aspectos especiales fueron significativos para mí. El humorístico y brillante discurso de Sol Gordon sobre Educación Sexual en Terapia Familiar mereció las máximas aclamaciones. El logró animarnos a ayudar a los padres con la educación sexual de sus hijos, un aspecto descuidado muchas veces en terapia. La reunión de despedida contó con un grupo de bailarines israelíes, quienes actuaron maravillosamente y al final comprometieron al auditorio en una viva y enérgica danza tradicional hebrea. Cuando nos dimos las manos, inclinándonos y moviéndonos al son de las danzas israelíes, todos nosotros nos sentimos agradecidos por la maravillosa experiencia de haber concurrido a este Congreso.

Sociedad Argentina de Terapia Familiar

Segundas Jornadas de Actualización en Terapia Familiar.

Durante los días 19 y 20 de octubre, del año 1979, se desarrollaron las Segundas Jornadas de Actualización en Terapia Familiar, que organizara la Sociedad Argentina de Terapia Familiar.

En tal ocasión, se contó con la participación del Dr. David Rubinstein, médico psicoanalista Director del Eastern Pennsylvania Psychiatric Institute de Philadelphia y Profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Temple, de la misma ciudad.

Durante el primer día, por la mañana, luego de un acto inaugural, se procedió a la proyección, en Video Tape, de sesiones familiares, a través de las cuales, se pudo apreciar la modalidad de trabajo del Dr. Rubinstein, y, posteriormente, se tuvo la oportunidad de intercambiar con él, fructíferos aportes, preguntas y observaciones.

Por la tarde, nuestro invitado ofreció diversas supervisiones clínicas, un seminario teórico y una conferencia.

El último día de las jornadas, por la mañana, se prosiguió con la proyección, en Video Tape, de sesiones familiares. Esta vez, la

Información sobre la Sociedad Argentina de la Terapia Familiar

audiencia se vió favorecida por el hecho de que la muestra, estaba constituida por entrevistas realizadas en nuestro país, con personas de habla hispana; con lo cual, no sólo se libró de la traducción o de los esfuerzos para comprender el inglés; pero también se sintió más consustanciada por la ausencia de diferencias culturales. Cabe agregar, que el Dr. Rubinstein, no sólo habla fluídamente en español; sino que además lo hace con particular grandilocuencia.

Por la tarde, distintos miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Familiar, y otros invitados, tuvieron a su cargo la conducción de diversos seminarios sobre la materia; cuyo programa se presenta a continuación:

Terapia Familiar e Institución -Dres. Luis Albornoz y Alfredo Canevaro.

El Narcisismo Como Supuesto Familiar -Dr. Juan Yaría.

El Proceso Transferencial en Terapia Familiar -Dr. Miguel A. Bianucci.

Diagnóstico del Grupo Familiar, Teoría y Práctica -Lic. Gisela Ahlin y Graciela Boticella.

Familia y Transmisión -Dr. Carlos Kligmann.

Asambleas Multifamiliares -Estructura y Dinámica de los Grupos Multifamiliares -Lic. Stella Maris Molina y Dres. Oscar Czertok, Rafael Skiadaressis y Roberto Marcer.

Familias con un Miembro Psicótico -Dr. Jorge Alonso.

El Proceso Terapéutico en la Terapia Familiar -Dr. Alejandro Sicardi.

Inclusión del Paciente Psicótico y su Familia en la Comunidad Terapéutica Psicoanalítica -Dr. Jorge García Badaracco.

Terapia Familiar: Transferencia -Contratransferencia y Equipo Terapéutico -Lic. Eduardo Mandelbaum.

Del Mito Patológico a lo Mítico Reestructurante -Dr. Octavio Fernandez Mouján.

Experiencias en Tratamiento de Familias -Dr. Juan José Morgan.

El Enfoque Interaccional. Teoría y Práctica -Dra. Celia Elzufan.

Tiempo, Espacio y Esquema Referencial -Dr. Guillermo Ferschut.

Después de estos seminarios, el Dr. Rubinstein trabajó con un grupo familiar terapéutico simulado, el cual se constituyó con la

Información sobre la Sociedad Argentina de la Terapia Familiar

participación de miembros de la concurrencia; dramatizando un material clínico relatado por nuestro invitado. Terminada la experiencia, se suscitó un nutrido debate.

Con respecto al Dr. David Rubinstein se pudo apreciar que, además de su acervo teórico, hace gala de una gran serenidad y calidez humana, las cuales le confieren características muy personales, en el acercamiento a los pacientes. Su enfoque ecológico de la esquizofrenia, sus ideas sobre las diadas depresivas y sobre el desarrollo de la libido de una persona en relación al desarrollo de esas mismas etapas en sus progenitores; fueron algunos de los muchos conceptos vertidos durante sus disertaciones.

Llamó la atención también, la variada gama de medios utilizados para lograr efectos terapéuticos: interpretaciones, señalamientos, cambios de ubicación espacial de los miembros de la familia, también de él mismo, no sólo en el plano horizontal, pero hasta en el vertical, cambios en el tono y modulación de la voz, etc. Al mismo tiempo se lo notó dueño de un claro esquema referencial, que se ponía en evidencia, cada vez que era capaz de conceptualizar cada una de sus intervenciones.

Las Jornadas sirvieron para el intercambio científico, pero también para el acercamiento entre los profesionales, que trabajan en esta área, todavía joven del saber. El clima que imperó fue de amistad y de interés científico.

La Sociedad Argentina de Terapia Familiar tiene programado, continuar organizando invitaciones a destacados especialistas en la materia, y cuenta, para la tercera semana del mes de abril de 1980, con la vista del Dr. Gerald Zuk de Filadelfia. Y para la tercera semana de Junio con la visita de los Dres. Israel Zuerling e Ilda Ficher del Hanemann College.

Alejandro Sicardi

Terapia Breve y Terapia Familiar

Curso intensivo en castellano.

Entre los días 2 y 24 de agosto tuvo lugar el "CURSO INTENSIVO EN CASTELLANO" sobre TERAPIA FAMILIAR Y BREVE organizado por el MENTAL RESEARCH INSTITUTE.

Dando comienzo con "The Fourth Don Jackson Memorial Conference, fue continuado en el ámbito de la Universidad de Stanford, con la dirección de Carlos Sluzki y Paul Watzlawek, con la asistencia de colaboradores.

Durante 102 horas de trabajo programado, debieron cubrirse las expectativas de un heterogéneo grupo de hispanoparlantes, compuesto por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, sociólogos, con muy diverso nivel de experiencia, formación y aproximación al modelo teórico del M.R.I.

Siendo la primera experiencia dictada en este contexto cabía preguntarse como los conductores adaptarían su programa a una demanda tan dispar.

La fundamentación teórica del modelo fue abarcada en forma conjunta por ambos directores, priorizándose y privilegiándose la descripción sistémica del proceso interaccional, en su contexto histórico, epistemológico y metodológico.

El recuerdo de nociones fundamentales de la Teoría General de

los Sistemas y de los sistemas cibernéticos, estuvo acompañado de ejemplificaciones sobre el material clínico del equipo y el de los participantes.

La observación y discusión de videocassettes, el trabajo con familia simulada, como así mismo el que se realizó sobre material aportado por los participantes, constituyó el vehículo donde el esquema referencial teórico se articuló con la fundamentación de las estrategias del enfoque terapéutico. Dentro de otros muchos temas, fueron cubiertos los siguientes tópicos:

Síntoma y su valor como función en el sistema familiar.
Connotación positiva. Prescripción del síntoma. Reformulación. Manejo de la coalición y reestructuración en el proceso. Puntuación de secuencias. Reformulación de roles. Cambio.

La discusión del material con sus propios autores permitió la fundamentación por parte de los mismos de cada una de sus intervenciones y la implementación de su personal estilo terapéutico.

Con la participación de todos los miembros del curso y la eficaz conducción de Phoebe Prosky se trabajó en "family sculpting" sobre familia real y familia simulada, apreciándose la riqueza de que aporta esta técnica en manos de

su conductora.

El curso contó asimismo con una presentación especial de Mara Selvi-ni Palazzoli quien se refirió a la posición de su equipo sobre el con-texto de la comunicación paradójal explicando que sería necesaria una interacción triádica para la forma-ción de su secuencia. Este tercero constituiría en su hipótesis el desti-natario real de parte de los mensajes. Este y otros temas fueron aborda-dos en su brillante y expresivo estilo personal.

Contando con la ayuda de Fred Hoebel, Dora Schmitman y Aldo Lubrano que secundaron eficiente-mente a los coordinadores, se cu-brieron las metas del curso que pudieran sintetizarse a través de la descripción que Sluzki hace de la Revolución epistemológica que im-plica:

Un corrimiento de los indivi-

duos a los sistemas más amplios.

Un corrimiento desde el conte-nido al proceso.

Un corrimiento desde las inter-pretaciones a las intervenciones.

Un corrimiento desde las inter-pretaciones a las intervenciones.

Un corrimiento desde las inter-acciones a los efectos.

Un corrimiento desde los orí-genes a los lazos presentes; autoper-petuentes.

Un corrimiento desde los roles a las reglas.

Un corrimiento desde los sinto-mas a las funciones.

Un corrimiento desde la causa-lidad lineal a la circularidad ciber-nética.

Es deseable que programas de for-mación y actualización sean mas fre-cuentes de acuerdo al resultado de esta primera experiencia.

Dra. MABEL BEATRIZ BELLO

CONCURSO ANUAL DE TRABAJOS SOBRE TERAPIA FAMILIAR

La Revista TERAPIA FAMILIAR instituyó un CONCURSO de trabajos teóricos, clínicos o de investigación que signifiquen un aporte relevante al desarrollo del conocimiento y de la práctica de nuestra disciplina.

Recordamos que las condiciones son las siguientes:

- El concurso se realizará anualmente a partir de 1980.
- Los trabajos podrán ser presentados individual o gradual-mente, pudiendo tratarse de terapeutas familiares o de equipos interdisciplinarios residentes en el país.
- El jurado estará compuesto por 6 (seis) personalidades reco-nocidas en nuestra disciplina y será designado por los responsables de la Revista Terapia Familiar. En caso de empate se requerirá el voto del Director de la Revista.
- El premio consistirá en un diploma y la publicación del tra-bajo en la Revista TERAPIA FAMILIAR. Podrá ser compartido o declarado desierto. El jurado podrá otorgar menciones a otros trabajos que serían eventualmente publicados.
- Los trabajos, que deberán ser inéditos, serán presentados en 7 (siete) copias escritas a máquina, a doble espacio, tamaño carta. Serán firmados con un seudónimo; que figurará con el título del trabajo en la cara externa de un sobre cerrado conteniendo en su interior el nombre y domicilio del o los autores.
- La recepción de los trabajos quedará a cargo de los responsa-bles de la Revista TERAPIA FAMILIAR. Teniendo en cuenta numerosos pedidos se posterga la misma hasta el 31 de Mayo de 1980 inclusive, por lo que el trabajo premiado y las menciones que hubiese resuelto el jurado serán publicados en el segundo número de la Revista de ese mismo año.

- Familia.
- Paz.
- Paz.
- Ansiolítico.
- Ansiolítico.
- Sidenar.
- Menor somnolencia.
- Sidenar.
- Mayor respuesta motora.
- Sidenar.
- Lorazepán 1 mg.
- Sidenar.
- Lorazepán 2,5 mg.
- Sidenar.
- Sidenar.
- Syncro.
- Syncro.
- Laboratorio.
- Dirección.
- Muñiz 230/238.
- Teléfono.
- 811-3111/2807/7748.

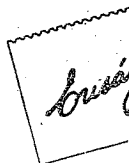
sidenar

Lorazepán



SYNCR0

ARGENTINA S.A.Q.I.C.I.F.



ANNOUNCING...



The Journal of Marital and Family Therapy

Florence W. Kaslow, Ph.D., Editor

formerly known as
THE JOURNAL OF MARRIAGE AND FAMILY COUNSELING

WE HAVE CHANGED OUR NAME . . . in order to more accurately reflect the education and nature of clinical practice in the present professional developments in the discipline. With this new title, we will continue to offer quality articles on theory, research and treatment interventions in marital and family therapy.

A publication of the American Association for Marriage and Family Therapy (formerly known as the American Association of Marriage and Family Counselors).

SUBSCRIPTION ORDER FORM

Individual — \$20/year (4 issues)

Institutional (Libraries and Multi-Reader Establishments) — \$30/year (4 issues)

(Orders outside the United States and Canada request latest prices from JMFT Business Office)

Check Enclosed.

Please bill me for this order plus postage and handling.

Name _____

(or Institution) _____

Address _____

City _____ State/Province _____ Zip _____

Please mail this form to: JMFT Business Office, 924 W Ninth, Upland CA 91786.

Family Process

A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF FAMILY STUDY RESEARCH AND TREATMENT

EDITOR/Donald A. Bloch, *New York, N.Y.*

EDITORIAL BOARD/Lyman C. Wynne, CHRM., *Rochester, N.Y.* Edgar H. Auerswald, *Mau, Hawaii.* Michael Goldstein, *Los Angeles, Calif.* Salvador Minuchin, *Philadelphia, Pa.* Jules Riskin, *Palo Alto, Calif.* Arthur G. Rosenthal, *Cambridge, Mass.* Margaret T. Singer, *Berkeley, Calif.* Carl Whitaker, *Madison, Wis.*

FAMILY PROCESS is the definitive Journal in the field of family psychotherapy, study, and research, published quarterly. Original articles report on the theory and practice of family treatment as well as on related research. Additionally, regular departments of FAMILY PROCESS are devoted to Books, Abstracts of relevant literature, Training Announcements, and news of Activities in the family field.

Among the many contributors to FAMILY PROCESS in recent years have been Nathan W. Ackerman, Edgar H. Auerswald, John E. Bell, Nathan B. Epstein, Andrew Ferber, Antonio J. Ferreira, James Framo, Jay Haley, Don D. Jackson, Walter Kempler, Frank S. Pittman, Ross V. Speck, and Gerald Zuk.

FAMILY PROCESS

149 East 78th Street
New York, N.Y. 10021

DATE _____

Gentlemen:

Please enter my subscription for FAMILY PROCESS

INDIVIDUAL SUBSCRIBERS

INSTITUTIONAL SUBSCRIBERS

(paid by personal check)

- ☐ \$12.00 per year United States
☐ \$13.00 per year Canada & Latin America
☐ \$14.00 per year All other countries

- ☐ \$20.00 U. S.
☐ \$21.00 Canada & Latin America
☐ \$22.00 All other countries

NAME _____

ADDRESS _____

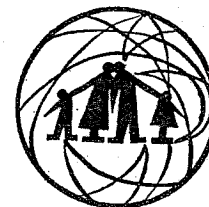
CITY _____

STATE/COUNTRY _____

ZIP _____

All subscriptions are entered on a calendar year basis

La rivista esce in collaborazione con le riviste *Family Process* dell'Ackerman Institute for Family Therapy di New York e del Mental Research Institute di Palo Alto; *Journal of Marriage and Family Therapy* dell'American Association of Marriage and Family Therapy; the *American Journal of Family Therapy* della National Alliance for Family Life.



Abbonamenti 1979

Italia: Ordinario L. 11.000

Enti L. 20.000

Esteri: L. 15.000 o doll. 17

Sostenitore: L. 50.000

Numero separato: L. 6.500

Pubblicazioni arretrate:

Numero singolo: L. 7.500

Annata: L. 15.000

I versamenti per gli abbonamenti vanno inviati a mezzo modulo di c/c postale N. 23889009 intestato a Rivista «Terapia Familiare» della C.T.F. s.r.l. via Reno 30, 00198, Roma.

Gli abbonamenti non disdetti entro il Giugno dell'anno successivo si intendono tacitamente rinnovati. Dopo questa data la rivista sarà inviata 'contrassegno' agli abbonati che non hanno ancora inviato il versamento tramite c/c postale.

I reclami per eventuali dispersioni di fascicoli vanno presentati non oltre un mese dalla pubblicazione. Eventuali cambiamenti d'indirizzo vanno tempestivamente notificati.

Autorizzazione del Tribunale di Reggio Calabria n. 2467 di Reg. S.P. in data 2 marzo 1977.

Visigalli-Pasetti - arti grafiche - Roma.

TERAPIA FAMILIARE

Rivista semestrale

Organo ufficiale della Società Italiana di Terapia Familiare (S.I.T.F.)

Direttore Responsabile:

Maurizio Andolfi.

Comitato Direttivo:

P. Menghi - A. Nicolò - C. Saccu

Comitato

di redazione nazionale:

C. Angelo (Bolzano), J. Anzilotti (Firenze), A. Berardi (Latina), M. Bertini (Roma), R. de Bernart (Firenze), C. Dobrowski (Firenze), K. Giacometti (Firenze), S. Montagano (Firenze), P. Pepe (Roma), R. Piperno (Roma), C. Pontalti (Roma), S. Soccorsi (Roma), C. Truppi (L'Aquila), F. Vanon (Firenze).

Comitato

di redazione internazionale:

H. Aponte (Filadelfia), A. Bentovim (Londra), D. Bloch (New York), I. Boszormenyi-Nagy (Filadelfia), M. Bowen (Washington), P. Caillé (Oslo), A. Canevaro (Buenos Aires), Y. Colas (Lione), M. Elkaim (Bruxelles), J. Framo (Filadelfia), F. Kaslow (Filadelfia), L. L'Abate (Atlanta), K. LaPerrière (New York), B. Luban-Plozza (Locarno), S. Minuchin (Filadelfia), E. Pancheri (Losanna), P. Papp (New York), A. Schefflen (New York), O. Silverstein (New York), C. Sluzki (San Francisco), H. Stierlin (Heidelberg), P. Watzlawick (Palo Alto), C. Whitaker (Madison), I. Zwerling (Filadelfia).

Responsabile pubblicazioni estere:

K. Giacometti

Segretarie di redazione:

A. La Mesa, G. Montinari, P. Valentini.

Diffusione e pubblicità:

E. Bentivegna, U. Capitani.

Progetto grafico e impaginazione:

D. Grauer.

Redazione:

Via Reno, 30 - 00198 Roma

Tel. 86.42.61

**CLINICA
GRADIVA**



COORDINADORES:

Dr. MIGUEL A. BIANUCCI
Dr. JUAN A. YARIA

- TRATAMIENTO PSIQUIATRICO INTEGRAL
- INTERNACION
- CLINICA DE DIA
- CONSULTORIOS EXTERNOS
- URGENCIAS DOMICILIARIAS

Rivadavia 5840 Capital T.E.: 631-7581/632-5565

Radiomensaje: 46-5329/3701 • 45-9392/9549 • Código 4777

centro de investigaciones en psicopatología **Ciep**

- INTERNACION
 - HOSPITAL DE DIA
 - CONSULTORIOS EXTERNOS

Coordinadores:

Jorge Cosín y Carlos Lorusso

FRANKLIN D. ROOSEVELT 2296 esq. VUELTA DE OBLIGADO

Tel. 781-6929 (por radiollamado: 32-6383/84/85/86/87)

Códigos: 6800-6801 (especificando nombre, tel. y/o dirección)
1428 Buenos Aires - República Argentina

SERVICIO DE PSICOPATOLOGIA DEL "HOSPITAL ITALIANO"

Integrado al Dto. de Medicina

Guardia médica psiquiátrica activa permanente: de un médico de planta y un médico residente

- Consultorio Externo: Sectores de Adolescentes, Adultos y Personas de Edad.
- Internación: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal.
- Hospital de Día: Musicoterapia, Terapia Ocupacional, Recreación, Integración Corporal, Psicodrama.

Jefa int.: Prof. Dra. Lía Ricón de Tenconi

Gascón 450

Tel. 811 - 4149

1968 - 1979

CLINICA PSIQUIATRICA (Comunidad Terapéutica)

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. García Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Pone a disposición de los colegas una larga trayectoria de experiencia Institucional privada en los trastornos psíquicos graves que requieran Internación total o parcial, incluyendo los más modernos recursos terapéuticos, desde los recientes avances de la Investigación biológica hasta la experiencia clínica psicoterapéutica individual, grupal, familiar e institucional.

O'Higgins 2328/48

1428 - CAPITAL FEDERAL

Radiollamada Código 9807

Teléfonos: 781 - 1306/0557/7825
31 - 0056/59 y 32 - 6383/87

COMUNIDAD TERAPEUTICA DIURNA

DIRECCION MEDICA Prof. Dr. Jorge E. García Badaracco
Dr. Norberto J. Proverbio
Dr. Alfredo A. Canevaro

Ofrece a los colegas una nueva modalidad asistencial para aquellas personas que psicológicamente no hayan podido aún reintegrarse en forma plena a la sociedad.

•Gorostiaga 1731
1426 - CAPITAL FEDERAL
TELEFONO 773 - 1308

RADIOLLAMADOS:
32 - 6383 / 87
31 - 0056 / 59
Código 9910

Indicaciones sobre los trabajos que se envíen como colaboraciones

Aquellos trabajos originales o comunicaciones sobre Congresos, conferencias y seminarios que traten el tema específico de la terapia familiar, deben ser enviados a:

Alfredo A. Canevaro, Gorostiaga 1731 - Cap. Federal (1426) - Rep. Argentina.

Las colaboraciones deberán ser originales y en dos (2) copias mecanografiadas a doble espacio, con un resumen final. La propiedad literaria de los artículos enviados pertenece a la revista y ésta se reserva todos los derechos de reproducción y publicación.

FICHA DE SUSCRIPCION

Sres. de Terapia Familiar:

Solicito ser suscripto por el término de un año a vuestra revista para lo que acompaño los siguientes datos:

Nombre y Apellido

Dirección

Código Postal Localidad

Profesión

Adjunto Cheque o Giro a nombre de: Editorial ACE S.R.L., No a la orden, por pesos

Gorostiaga 1731, Capital Federal (1426), R. Argentina

PRECIO DE LA SUSCRIPCION ANUAL
Argentina \$ 40.000.-
Exterior u\$s 26.- recargo vía aérea u\$s 5.-